

Buku Referensi

ETIKA, HUKUM, DAN PROFESIONALISME

Dalam Praktik Keperawatan Indonesia

Ontran Sumantri Riyanto • Yuanita • Fithriyani
Nuraini • Zaenal Abidin • Sri Wahyuni
Erma Kasumayanti



BUKU REFERENSI ETIKA, HUKUM, DAN PROFESIONALISME DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN INDONESIA

Penulis:

Dr. Ontran Sumantri Riyanto, S.H., M.H.

Ns. Yuanita, S.Kep., Ners., MHkes.

Ns. Fithriyani, M.Kep.

Ns. Nuraini, S.Kep., M.Kep.

Zaenal Abidin, S.Kep., Ns., M.Kep., M.H.

Sri Wahyuni, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Erma Kasumayanti, M.Kep.



Buku Referensi Etika, Hukum, Dan Profesionalisme Dalam Praktik Keperawatan Indonesia

Penulis:

Dr. Ontran Sumantri Riyanto, S.H., M.H.
Ns. Yuanita, S.Kep., Ners., MHkes.
Ns. Fithriyani, M.Kep.
Ns. Nuraini, S.Kep., M.Kep.
Zaenal Abidin, S.Kep., Ns., M.Kep., M.H.
Sri Wahyuni, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Erma Kasumayanti, M.Kep.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7756-04-6

Cetakan Pertama : Mei, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga buku yang berjudul “Buku Referensi Etika, Hukum, dan Profesionalisme dalam Praktik Keperawatan Indonesia” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan buku ini merupakan bagian dari komitmen penulis dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang keperawatan yang terus mengalami dinamika dan perkembangan seiring dengan perubahan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.

Perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan yang pesat menuntut tenaga keperawatan untuk tidak hanya memiliki kompetensi klinis yang memadai, tetapi juga kemampuan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika, aspek hukum, serta nilai-nilai profesionalisme dalam praktik sehari-hari. Dalam konteks ini, perawat dituntut untuk mampu mengambil keputusan yang tepat, bertanggung jawab, serta berlandaskan pada standar profesi, kode etik keperawatan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan sistematis mengenai konsep etika, landasan hukum, serta profesionalisme dalam praktik keperawatan di Indonesia. Materi yang disajikan dalam buku ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari prinsip dasar etika keperawatan, isu-isu etik dalam praktik klinis, tanggung jawab hukum perawat, hingga penerapan profesionalisme dalam memberikan pelayanan keperawatan yang bermutu, aman, dan berorientasi pada pasien.

Selain itu, buku ini juga berupaya mengintegrasikan teori dengan praktik melalui pembahasan kasus-kasus yang relevan, sehingga diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami penerapan konsep secara nyata di lapangan. Dengan demikian, buku ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan praktik keperawatan di Indonesia.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi salah satu referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa keperawatan, dosen, praktisi, serta tenaga kesehatan lainnya dalam meningkatkan pemahaman dan kompetensi di bidang etika, hukum, dan profesionalisme. Lebih jauh lagi, buku ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan yang berorientasi pada keselamatan pasien, penghormatan terhadap hak pasien, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Dalam proses penyusunan buku ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat berbagai keterbatasan, baik dari segi penyajian maupun kedalaman materi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan guna penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam proses penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas serta menjadi salah satu kontribusi nyata dalam pengembangan praktik keperawatan yang profesional, beretika, dan sesuai dengan hukum di Indonesia.

Penulis

Mei, 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
---------------------	------------

DAFTAR ISI.....	v
------------------------	----------

BAB I PRINSIP ETIKA KEPERAWATAN.....	1
---	----------

A. Pendahuluan.....	1
B. Etika Keperawatan dalam Konteks Moralitas dan Profesi Kesehatan.....	1
C. Etika Keperawatan sebagai Pedoman dalam Pengambilan Keputusan Profesional.....	2
D. Perbedaan antara Etika dan Hukum dalam Keperawatan.....	3
E. Prinsip-prinsip Dasar Etika Keperawatan	3
F. Peran Etika dalam Keputusan Klinis	6
G. Etika dan Profesionalisme dalam Keperawatan.....	8
H. Penutup	11
Referensi.....	12

BAB II REGULASI DAN PERUNDANG-UNDANGAN KESEHATAN	15
---	-----------

A. Pendahuluan.....	15
B. Konsep Dasar Regulasi Kesehatan.....	15
C. Regulasi Kesehatan di Indonesia.....	17
D. Hierarki Peraturan Kesehatan di Indonesia	19
E. Undang-Undang Bidang Kesehatan Di Indonesia	19
F. Penutup	24
Referensi.....	25

BAB III TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL DAN MALPRAKTIK DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN	27
--	-----------

A. Pendahuluan.....	27
B. Konsep Tangung Jawab Profesional Perawat.....	28
C. Regulasi Terkait Tangung Jawab Perawat di Indonesia.....	31
D. Konsep Malpraktik dalam Keperawatan.....	34
E. Bentuk-Bentuk Malpraktik dalam Praktik Keperawatan	36
F. Analisis Hukum terhadap Kasus Malpraktik.....	39
G. Pencegahan Malpraktik dalam Praktik Keperawatan	41

H. Peran Dokumentasi dalam Aspek Legal	44
I. Penutup	47
Referensi.....	49
BAB IV INFORMED CONSENT DAN HAK PASIEN.....	51
A. Pendahuluan.....	51
B. <i>Informed Consent</i>	52
C. Hak dan Kewajiban Pasien.....	59
D. Peran Perawat dalam Meningkatkan Kemandirian dan Kesehatan Keluarga	60
E. Penutup	62
Referensi.....	63
BAB V ETIKA DALAM PRAKTEK DIGITAL DAN MEDIA SOSIAL	65
A. Pendahuluan.....	65
B. Konsep Dasar Etik Digital Dalam Keperawatan	66
C. Pedoman Etika Penggunaan Media Sosial bagi Perawat.....	68
D. Prinsip-Prinsip Etika dalam Penggunaan Media Digital	69
E. Peran perawat Dalam Penerapan Etika Digital dan Media Sosial	72
F. Integrasi Prinsip Etika dalam Praktik Digital	74
G. Pemanfaatan Media Sosial dalam Keperawatan	76
H. Risiko dan Tantangan Etika di Era Digital	78
I. Aspek Hukum dalam Praktik Digital Keperawatan	79
J. Strategi Peningkatan Literasi Digital Perawat	80
K. Penutup	81
Referensi.....	81
BAB VI KONFLIK ETIK DALAM PRAKTIK KLINIK	85
A. Pendahuluan.....	85
B. Jenis Konflik Etik dalam Praktik Keperawatan	87
C. Dinamika dan Tantangan Konflik Etik dalam Praktik Keperawatan.....	97
D. Strategi Penyelesaian Konflik Etik.....	100
E. Penutup	102
Referensi.....	103

BAB VII PENGUATAN PROFESIONALISME DAN ORGANISASI	109
A. Pendahuluan.....	109
B. Konsep Dasar Profesionalisme Keperawatan	111
C. Standar Profesi dan Kompetensi perawat	112
D. Etika Profesi dalam Penguatan Profesionalisme	113
E. Aspek Hukum dalam Praktik Keperawatan	115
F. Peran Organisasi Profesi (PPNI).....	116
G. Pengembangan Profesional Berkelanjutan (Continuing Professional Development/CPD)	117
I. Kepemimpinan dalam Keperawatan.....	118
J. Kolaborasi Interprofesional	118
K. Tata Kelola Profesi (Professional Governance).....	118
L. Penutup	119
Referensi.....	120
 PROFIL PENULIS	 123

BAB I

PRINSIP ETIKA KEPERAWATAN

A. Pendahuluan

Etika keperawatan merupakan aspek penting dalam praktik profesional yang mengatur hubungan antara perawat dan pasien serta memastikan bahwa setiap tindakan perawatan dilakukan dengan dasar moral yang kuat. Sebagai profesi yang melibatkan interaksi langsung dengan individu yang rentan, perawat dihadapkan pada berbagai keputusan yang memerlukan pertimbangan etis. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip etika keperawatan sangat penting dalam menjaga integritas profesi dan memastikan perawatan yang berkualitas serta penuh rasa hormat terhadap hak pasien.

Seiring dengan berkembangnya sistem pelayanan kesehatan, tantangan dalam praktik keperawatan semakin kompleks. Isu-isu terkait dengan hak pasien, pengambilan keputusan medis, dan peran perawat dalam menjaga kesejahteraan pasien memerlukan pemahaman etis yang mendalam. Di Indonesia, para perawat diharuskan untuk mengikuti Kode Etik Perawat Indonesia (KEPI) yang menjadi pedoman bagi mereka dalam melakukan praktik keperawatan yang profesional dan bermartabat. Kode etik ini juga mencerminkan nilai-nilai universal dalam etika keperawatan yang diterima secara global, seperti yang tercantum dalam pedoman dari International Council of Nurses (ICN).

Prinsip-prinsip etika keperawatan mencakup berbagai aspek, mulai dari penghormatan terhadap hak pasien (autonomi), kewajiban untuk memberikan manfaat (beneficence), menghindari bahaya (non-maleficence), hingga memastikan keadilan dan kerahasiaan informasi pasien. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi panduan bagi perawat dalam mengambil keputusan sehari-hari, tetapi juga berperan penting dalam membentuk hubungan yang saling percaya antara perawat dan pasien. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang prinsip etika ini tidak hanya diperlukan oleh perawat, tetapi juga oleh pasien dan masyarakat luas yang terlibat dalam sistem perawatan kesehatan.

B. Etika Keperawatan dalam Konteks Moralitas dan Profesi Kesehatan

Secara moral, etika keperawatan melibatkan pertimbangan tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruk, serta bagaimana perawat dapat memastikan bahwa

tindakannya tidak merugikan pasien dan justru berfokus pada kesejahteraan mereka. Ini mencakup nilai-nilai dasar seperti empati, kejujuran, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks profesi, etika keperawatan mengacu pada seperangkat pedoman yang ditetapkan oleh badan atau asosiasi profesi keperawatan untuk memastikan bahwa perawat bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang diakui oleh profesi tersebut.

Sebagai contoh, dalam menghadapi pasien yang tidak dapat memberikan persetujuan (misalnya pasien yang tidak sadar), perawat dituntut untuk bertindak berdasarkan prinsip beneficence (berbuat baik), memastikan bahwa tindakan mereka mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pasien meskipun tidak ada persetujuan langsung dari pasien tersebut.

Contoh Kasus Nyata:

Seorang perawat bekerja di unit perawatan intensif (ICU) dan terlibat dalam keputusan medis terkait dengan pasien yang mengalami cedera otak parah dan tidak dapat memberikan persetujuan untuk tindakan medis lebih lanjut. Dalam hal ini, etika keperawatan menuntut perawat untuk mempertimbangkan hak otonomi pasien, tetapi juga harus menilai prinsip beneficence, yang mengharuskan tindakan yang memaksimalkan peluang penyembuhan atau mengurangi penderitaan pasien.

C. Etika Keperawatan sebagai Pedoman dalam Pengambilan Keputusan Profesional

Etika keperawatan memberikan pedoman bagi perawat untuk membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab, baik dalam situasi yang jelas maupun yang lebih kompleks. Pengambilan keputusan ini melibatkan pertimbangan antara berbagai prinsip etika, seperti otonomi pasien, beneficence, non-maleficence, dan keadilan. Setiap keputusan yang diambil oleh perawat harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak pasien dan kebutuhan medis, serta tantangan yang mungkin timbul dalam menjaga integritas profesi.

Contoh Kasus Nyata:

Seorang perawat di rumah sakit menghadapi situasi di mana pasien dengan penyakit kronis ingin berhenti menjalani perawatan medis lebih lanjut karena merasa kualitas hidupnya menurun. Di sini, perawat harus menggunakan prinsip etika untuk memberikan informasi yang jelas mengenai konsekuensi dari keputusan tersebut, sambil menghormati keputusan pasien (otoritas pasien) dan memberikan perawatan yang dapat membantu mengurangi penderitaannya (beneficence).

D. Perbedaan antara Etika dan Hukum dalam Keperawatan

Etika dan hukum, meskipun terkait erat, memiliki perbedaan mendasar dalam hal tujuan dan penerapannya dalam praktik keperawatan. Hukum bersifat lebih tegas dan mengatur perilaku individu dalam masyarakat dengan sanksi yang jelas bagi mereka yang melanggar. Sementara itu, etika lebih mengutamakan pertimbangan moral dan nilai-nilai yang dipegang oleh individu atau kelompok profesi.

Perbedaan Utama:

1. **Etika:** Berfokus pada prinsip-prinsip moral yang mendasari perilaku perawat, seperti penghormatan terhadap hak pasien dan kewajiban untuk bertindak demi kebaikan pasien. Etika bersifat lebih fleksibel dan memungkinkan interpretasi berdasarkan situasi yang dihadapi.
2. **Hukum:** Mengatur tindakan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh perawat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelanggaran terhadap hukum dapat berakibat pada sanksi yang lebih formal, seperti denda atau bahkan pencabutan lisensi.

Contoh Kasus Nyata:

Misalnya, seorang perawat yang membocorkan informasi medis pasien kepada pihak ketiga tanpa izin. Secara hukum, hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan data pribadi (seperti UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran di Indonesia). Namun, dalam konteks etika, meskipun tidak ada sanksi hukum langsung, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kerahasiaan yang merupakan bagian dari kode etik keperawatan, yang dapat merusak kepercayaan pasien terhadap profesi keperawatan.

E. Prinsip-prinsip Dasar Etika Keperawatan

Etika keperawatan berlandaskan pada empat prinsip dasar yang sangat penting untuk diterapkan dalam praktik sehari-hari. Prinsip-prinsip ini memberikan panduan bagi perawat dalam mengambil keputusan yang profesional, moral, dan adil. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang prinsip-prinsip dasar etika keperawatan, lengkap dengan contoh kasus nyata dan tantangan yang sering dihadapi oleh perawat dalam mengaplikasikannya.

1. Otonomi (Autonomy)

Prinsip otonomi dalam etika keperawatan menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak pasien untuk membuat keputusan tentang perawatan mereka sendiri. Setiap individu memiliki hak untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya, termasuk dalam hal perawatan kesehatan. Prinsip ini

mengharuskan perawat untuk menghormati keputusan pasien, baik itu untuk menerima atau menolak perawatan medis.

Contoh Kasus Nyata:

Seorang pasien dengan kanker stadium lanjut memutuskan untuk berhenti menjalani pengobatan lanjutan yang direkomendasikan oleh dokter. Meskipun tim medis dan perawat merasa bahwa keputusan tersebut dapat memperburuk kondisi pasien, mereka harus menghormati hak pasien untuk membuat keputusan terkait perawatan mereka. Perawat, dalam hal ini, memberikan informasi yang jelas dan tidak memihak agar pasien dapat membuat keputusan yang tepat sesuai dengan keinginannya.

Tantangan yang Dihadapi:

Tantangan yang sering dihadapi oleh perawat adalah ketika pasien berada dalam kondisi tidak sadar atau tidak mampu membuat keputusan sendiri. Dalam kasus seperti ini, perawat harus mengambil keputusan berdasarkan kepentingan terbaik pasien, seringkali berkomunikasi dengan keluarga atau wali pasien.

2. Kebaikan (Beneficence)

Prinsip kebaikan (beneficence) mengharuskan perawat untuk bertindak demi kebaikan pasien dengan melakukan segala yang terbaik untuk kesejahteraan mereka. Ini mencakup memberikan perawatan yang aman, efektif, serta mendukung proses penyembuhan pasien.

Contoh Kasus Nyata:

Seorang perawat di ruang perawatan intensif (ICU) memberikan perawatan kepada pasien yang baru saja menjalani operasi besar. Selain memberikan obat yang diresepkan, perawat juga memastikan bahwa pasien mendapatkan perhatian emosional yang cukup untuk mengurangi rasa cemas dan stres pasca-operasi. Perawat mengutamakan kenyamanan pasien, memberikan dukungan psikologis, dan memastikan bahwa pasien mendapat informasi yang jelas tentang prosedur yang akan datang.

Tantangan yang Dihadapi:

Terkadang, perawat dihadapkan pada konflik antara prinsip beneficence dan otonomi. Misalnya, seorang pasien menolak pengobatan yang dapat meningkatkan peluang kesembuhan mereka. Perawat harus bekerja keras untuk memberikan penjelasan yang tepat, menjaga hubungan baik dengan pasien, dan memastikan bahwa pasien membuat keputusan yang informasional dan beralasan.

3. Tidak Merugikan (Non-maleficence)

Prinsip non-maleficence mengharuskan perawat untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan pasien, baik secara fisik, emosional, atau

psikologis. Prinsip ini berfokus pada pencegahan terhadap kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan medis atau kelalaian dalam memberikan perawatan.

Contoh Kasus Nyata:

Seorang perawat harus memastikan bahwa prosedur medis, seperti pemasangan infus, dilakukan dengan benar untuk menghindari cedera atau infeksi pada pasien. Jika perawat tidak hati-hati dan melakukan prosedur dengan ceroboh, misalnya, dengan menusukkan jarum terlalu dalam atau salah posisi, hal itu bisa menyebabkan infeksi atau kerusakan jaringan yang lebih serius.

Tantangan yang Dihadapi:

Terkadang, perawat harus membuat keputusan yang dapat menyebabkan sedikit ketidaknyamanan atau risiko untuk pasien, seperti saat memberikan obat-obatan yang memiliki efek samping. Dalam hal ini, perawat harus mengedepankan prinsip non-maleficence dengan memastikan bahwa manfaat perawatan lebih besar daripada potensi kerugian yang mungkin timbul.

4. Keadilan (Justice)

Prinsip keadilan mengacu pada pemberian perawatan yang setara bagi semua pasien tanpa diskriminasi. Setiap pasien berhak mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan medis mereka, tanpa memandang ras, agama, status sosial, atau faktor lainnya. Dalam konteks keperawatan, keadilan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara dalam menerima layanan kesehatan.

Contoh Kasus Nyata:

Seorang pasien yang datang dari latar belakang sosial-ekonomi rendah datang ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Meskipun ada perbedaan sosial-ekonomi yang jelas, perawat harus memberikan perawatan yang sama berkualitasnya dengan pasien lainnya. Perawat harus memastikan bahwa pasien ini mendapat perhatian yang layak, tidak hanya berdasarkan status sosialnya, tetapi juga berdasarkan kebutuhan medisnya.

Tantangan yang Dihadapi:

Dalam praktik sehari-hari, tantangan terbesar dalam menerapkan prinsip keadilan adalah terkait dengan sumber daya terbatas. Misalnya, jika rumah sakit kekurangan tempat tidur di ruang rawat inap, perawat dan staf medis mungkin harus memprioritaskan pasien berdasarkan tingkat keparahan kondisi mereka. Meski begitu, prinsip keadilan tetap mengharuskan mereka untuk memberikan kesempatan yang setara kepada setiap pasien untuk mendapatkan perawatan terbaik yang tersedia.

F. Peran Etika dalam Keputusan Klinis

Dalam praktik keperawatan, prinsip etika berperan penting dalam membantu perawat mengambil keputusan yang tidak hanya berdasarkan pengetahuan medis tetapi juga pada pertimbangan moral yang mendalam. Keputusan klinis sering kali melibatkan situasi yang penuh tekanan dan kompleks, yang membutuhkan keseimbangan antara nilai-nilai pribadi, keinginan pasien, dan kewajiban profesional. Prinsip etika yang mendasari seperti otonomi, kebaikan, tidak merugikan, dan keadilan sering menjadi panduan dalam mengambil keputusan klinis yang sulit.

1. Prinsip Etika dalam Menghadapi Pilihan yang Sulit

Keputusan klinis sering kali dihadapkan pada dilema etika, terutama ketika ada pilihan yang bertentangan, misalnya antara menghormati keinginan pasien dan memberikan perawatan yang secara medis dianggap terbaik oleh tim medis. Dalam hal ini, prinsip etika perawatan harus menjadi acuan, dan perawat harus dapat menyeimbangkan kepentingan medis dengan hak otonomi pasien untuk memilih pengobatan atau perawatan yang diinginkannya.

Contoh Kasus Nyata:

Seorang pasien yang menderita kanker stadium akhir memutuskan untuk menghentikan pengobatan kemoterapi karena merasa kualitas hidupnya terganggu. Di sisi lain, dokter dan perawat merasa bahwa melanjutkan perawatan bisa memberikan harapan hidup yang lebih lama. Dalam situasi seperti ini, perawat harus menghormati keputusan pasien berdasarkan prinsip otonomi (hak untuk menentukan nasibnya sendiri), namun juga memberikan dukungan dan informasi yang memadai untuk memastikan pasien membuat keputusan yang penuh kesadaran, sesuai dengan prinsip beneficence.

Tantangan yang Dihadapi:

Tantangan utama yang dihadapi perawat dalam situasi ini adalah menjaga keseimbangan antara menghormati hak pasien untuk memilih perawatan dan memberikan penjelasan yang tepat agar pasien tidak merasa terburu-buru dalam membuat keputusan yang sangat penting. Terkadang, keinginan pasien tidak selalu sejalan dengan harapan tim medis, sehingga menuntut keterampilan komunikasi yang sangat baik dari perawat untuk memastikan bahwa keputusan tersebut diinformasikan dengan baik.

2. Konflik Antara Kepentingan Pasien dan Perawat

Dalam beberapa situasi, perawat dapat menghadapi konflik antara apa yang dianggap terbaik untuk pasien dan apa yang diinginkan oleh pasien itu sendiri. Dalam konteks ini, prinsip etika berfungsi untuk memberikan pedoman dalam

memutuskan jalan terbaik yang mengutamakan kesejahteraan pasien tanpa mengabaikan kehormatan dan hak-hak mereka.

Contoh Kasus Nyata:

Seorang pasien dengan gangguan jantung yang serius menolak menjalani prosedur yang diperlukan untuk menyelamatkan hidupnya, meskipun tim medis merasa itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawanya. Pasien tersebut memilih untuk tidak melanjutkan perawatan meskipun dampaknya bisa mempersingkat umurnya. Dalam hal ini, perawat harus menghormati keputusan pasien berdasarkan prinsip otonomi, namun tetap memberikan penjelasan yang jelas mengenai akibat dari keputusan tersebut, dengan tetap mempertimbangkan prinsip beneficence dan non-maleficence, yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan pasien.

Tantangan yang Dihadapi:

Konflik antara menghormati keinginan pasien dan memastikan mereka menerima perawatan yang optimal adalah dilema yang sering kali dihadapi perawat. Keputusan yang diambil dapat berdampak jangka panjang terhadap kesejahteraan pasien, sehingga dibutuhkan keterampilan interpersonal yang baik untuk mengelola komunikasi dan memberikan dukungan emosional kepada pasien serta keluarganya.

3. Keputusan Akhir Hidup: Perawatan Paliatif dan Keputusan untuk Tidak Melanjutkan Pengobatan

Salah satu aspek paling kompleks dalam etika keperawatan adalah pengambilan keputusan terkait perawatan akhir hidup, seperti perawatan paliatif dan keputusan untuk tidak melanjutkan pengobatan. Hal ini sering kali melibatkan pertimbangan antara memberikan kenyamanan dan kualitas hidup yang baik bagi pasien, serta upaya untuk memperpanjang hidup meskipun dengan kemungkinan efek samping yang signifikan.

Contoh Kasus Nyata:

Seorang pasien yang sudah lanjut usia dengan penyakit terminal, seperti kanker stadium akhir, memilih untuk berhenti menjalani pengobatan aktif dan meminta perawatan paliatif untuk mengurangi rasa sakit dan memperbaiki kualitas hidupnya. Perawat harus memutuskan bagaimana memberikan perawatan yang mendukung kenyamanan pasien tanpa melanjutkan pengobatan yang dapat menambah beban fisik atau emosional bagi pasien. Dalam hal ini, prinsip non-maleficence dan beneficence lebih menekankan pada perawatan yang mengutamakan kualitas hidup pasien.

Tantangan yang Dihadapi:

Salah satu tantangan terbesar dalam pengambilan keputusan perawatan akhir hidup adalah emosi dan ketegangan yang mungkin timbul dari keluarga pasien. Beberapa anggota keluarga mungkin merasa enggan untuk menerima keputusan pasien untuk menghentikan pengobatan, sementara perawat harus bertindak berdasarkan keinginan pasien yang harus dihormati. Dalam situasi ini, keterampilan komunikasi dan empati sangat penting bagi perawat untuk memberikan dukungan kepada keluarga dan memastikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan pemahaman yang jelas dan penghormatan terhadap nilai-nilai pasien.

4. Penerapan Prinsip Etika dalam Pengambilan Keputusan Klinis

Prinsip etika keperawatan diterapkan dalam pengambilan keputusan klinis dengan mempertimbangkan hak pasien, kesejahteraan mereka, serta keadilan dalam memberikan perawatan yang sesuai. Perawat harus mengelola situasi yang penuh emosi dan sering kali melibatkan konflik antara kepentingan pasien dan keluarga, dengan tetap berfokus pada memberikan perawatan yang aman, efektif, dan adil. Perawat harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selalu mencerminkan nilai-nilai etika dan profesionalisme yang tinggi.

Tantangan yang Dihadapi:

Keputusan klinis sering kali melibatkan ketidakpastian, terutama dalam situasi yang melibatkan keputusan hidup dan mati. Perawat harus mampu menyeimbangkan pertimbangan etis dan profesional dengan situasi klinis yang kompleks, serta menjaga hubungan baik dengan pasien dan keluarganya. Perawat juga harus siap menghadapi tekanan dari tim medis dan keluarga pasien, yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai apa yang terbaik untuk pasien.

G. Etika dan Profesionalisme dalam Keperawatan

Etika dan profesionalisme dalam keperawatan tidak bisa dipisahkan, karena keduanya saling mendukung dalam membentuk perawat yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi. Perawat yang profesional tidak hanya mematuhi standar medis dan teknis, tetapi juga memiliki kesadaran etis yang mendalam, yang tercermin dalam tindakan, perilaku, dan cara mereka berinteraksi dengan pasien. Dalam hal ini, etika berfungsi sebagai landasan moral bagi perawat untuk mengambil keputusan yang baik dan tepat meskipun dihadapkan dengan tantangan dan dilema moral dalam praktik sehari-hari.

1. Etika Keperawatan dalam Mendukung Pengembangan Profesionalisme

Etika keperawatan memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan profesionalisme dalam peran perawat. Dengan adanya pedoman etika yang jelas, perawat dapat bertindak dengan kepercayaan diri, mengetahui bahwa mereka mengikuti prinsip-prinsip moral yang diakui secara universal dalam profesi keperawatan. Etika memberikan kerangka kerja yang memungkinkan perawat untuk menangani situasi yang kompleks, termasuk perawatan pasien yang penuh tantangan, sambil tetap menjaga integritas pribadi dan profesional mereka.

Contoh Kasus Nyata:

Seorang perawat yang bekerja di ruang perawatan intensif (ICU) dihadapkan pada seorang pasien yang dalam kondisi kritis. Pasien tersebut membutuhkan keputusan segera terkait dengan pemberian obat penghilang rasa sakit yang dapat memperburuk kondisi jantungnya. Meskipun ada risiko, prinsip etika kebaikan (beneficence) menuntut perawat untuk memberikan perawatan yang mengurangi rasa sakit pasien, sementara prinsip tidak merugikan (non-maleficence) mengharuskan perawat untuk memitigasi risiko. Keputusan ini menguji profesionalisme perawat dalam mengelola antara kebutuhan medis dan kesejahteraan pasien secara etis. Perawat yang profesional akan membuat keputusan dengan hati-hati, berdasarkan pengetahuan medis, pertimbangan etis, dan komunikasi terbuka dengan tim medis.

2. Menghubungkan Etika dengan Kode Etik Keperawatan di Berbagai Negara atau Organisasi Profesional

Kode etik keperawatan adalah seperangkat prinsip moral yang diterima dan disepakati dalam profesi keperawatan yang ada di seluruh dunia. Kode etik ini memberikan pedoman bagi perawat dalam mengelola dilema moral dan memastikan bahwa tindakan yang diambil selalu sejalan dengan nilai-nilai profesional. Meskipun setiap negara atau organisasi profesional memiliki kode etik yang sedikit berbeda, prinsip dasar yang terkandung di dalamnya hampir selalu sama, yaitu menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan, memberikan perawatan yang berkualitas, dan memelihara profesionalisme.

Contoh Kasus Nyata:

Di banyak negara, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris, kode etik keperawatan mengharuskan perawat untuk selalu menjaga kerahasiaan informasi pasien. Seorang perawat di rumah sakit harus memastikan bahwa informasi medis pasien hanya dibagikan kepada pihak yang berwenang dan dengan izin pasien. Jika seorang perawat membocorkan informasi medis pasien tanpa izin, hal tersebut tidak hanya melanggar kode etik, tetapi juga dapat

mengarah pada sanksi hukum. Di sisi lain, kode etik juga mengatur pentingnya transparansi dan komunikasi yang jelas antara perawat dan pasien dalam memberikan informasi mengenai kondisi medis dan pilihan pengobatan.

3. Menjaga Profesionalisme di Tengah Dilema Moral

Perawat sering kali dihadapkan pada dilema moral yang dapat menguji profesionalisme mereka. Dalam situasi seperti itu, meskipun etika memberikan pedoman, kenyataan di lapangan sering kali jauh lebih rumit dan penuh dengan pertimbangan yang saling bertentangan. Menjaga profesionalisme berarti bahwa perawat harus dapat mengatasi tekanan, baik dari pasien, keluarga, maupun rekan sejawat, sambil tetap mematuhi pedoman etika dan standar praktik yang tinggi. Ini juga berarti bahwa perawat harus terus-menerus mengembangkan keterampilan komunikasi, keterampilan pengambilan keputusan, dan kapasitas untuk menghadapi tantangan etis dengan integritas yang kuat.

Contoh Kasus Nyata:

Seorang perawat di rumah sakit sedang merawat pasien yang menderita penyakit terminal dan tidak memiliki keluarga yang dapat dihubungi untuk membuat keputusan akhir mengenai perawatan. Pasien meminta untuk dihentikan pengobatan dan hanya menerima perawatan paliatif. Namun, tim medis merasa bahwa pasien seharusnya diberikan pengobatan lebih lanjut karena mereka dapat bertahan hidup lebih lama dengan perawatan yang lebih agresif. Dalam kasus ini, perawat harus menyeimbangkan antara hak pasien untuk menentukan perawatan mereka sendiri (prinsip otonomi) dan kewajiban medis untuk memberikan perawatan terbaik (prinsip beneficence). Perawat yang profesional akan memastikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada informasi yang jelas dan komunikasi yang terbuka dengan pasien, serta mematuhi pedoman kode etik yang ada.

Tantangan yang Dihadapi:

Tantangan utama dalam menjaga profesionalisme adalah tekanan emosional yang sering dialami perawat, terutama ketika berhadapan dengan keluarga pasien yang tidak setuju dengan keputusan medis atau pengobatan. Perawat harus mengelola situasi tersebut dengan hati-hati, menjaga komunikasi terbuka dengan keluarga, dan tetap berpihak pada kepentingan terbaik pasien. Ini membutuhkan kesabaran, empati, dan kebijaksanaan, serta kesadaran penuh akan kewajiban etis yang mereka miliki.

4. Pentingnya Pendidikan Etika dalam Pengembangan Profesionalisme Perawat

Pendidikan etika memainkan peran yang sangat penting dalam membantu perawat mengembangkan profesionalisme mereka. Dengan adanya pendidikan

yang solid tentang prinsip-prinsip etika, perawat dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi yang penuh dengan dilema moral. Selain itu, pendidikan etika dapat membantu perawat untuk menginternalisasi kode etik profesi dan meningkatkan keterampilan komunikasi yang dibutuhkan untuk mengelola konflik etika yang mungkin terjadi di tempat kerja.

Tantangan yang Dihadapi:

Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pelatihan atau pemahaman yang cukup tentang etika di beberapa institusi pendidikan atau rumah sakit. Hal ini dapat menyebabkan perawat merasa tidak siap dalam menghadapi dilema etika di lapangan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan dan rumah sakit untuk menyediakan pelatihan etika yang berkelanjutan, baik dalam bentuk kuliah, seminar, maupun diskusi kasus nyata.

H. Penutup

Prinsip-prinsip dasar etika keperawatan, yaitu otonomi, kebaikan, tidak merugikan, dan keadilan, merupakan pedoman yang sangat penting bagi perawat dalam memberikan perawatan yang bermartabat dan profesional. Meskipun penerapannya di lapangan dapat menghadapi berbagai tantangan, penerapan prinsip-prinsip ini dengan bijaksana akan mendukung terciptanya hubungan perawat-pasien yang saling menghormati, aman, dan adil. Perawat harus mampu mengintegrasikan keempat prinsip ini dalam setiap keputusan yang mereka buat untuk mencapai hasil terbaik bagi pasien.

Referensi

- Ahern, E. C., & Young, A. (2020). Ethical decision-making in nursing practice: A systematic review. *Nursing Ethics*, 27(4), 1016–1028. <https://doi.org/10.1177/0969733018815329>
- Ahmed, S. M., & Palermo, A.-G. S. (2019). Ethical considerations in global health research: A scoping review of current literature. *Journal of Bioethical Inquiry*, 16(2), 199–215. <https://doi.org/10.1007/s11673-019-09909-8>
- Alleyne, G., Jumaa, M., & Wiseman, E. (2019). Addressing moral distress in nursing practice: A narrative review. *Journal of Clinical Nursing*, 28(21–22), 3805–3815. <https://doi.org/10.1111/jocn.15089>
- American Nurses Association (ANA). (2015). *Code of Ethics for Nurses with Interpretive Statements*. American Nurses Association.
- Barker, R. H., & McClure, J. H. (2013). *Ethics in nursing practice*. Jones & Bartlett Publishers.
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics* (8th ed.). Oxford University Press.
- Bell, E., & Taylor, N. L. (2021). Informed consent in health care: Current challenges and practical approaches. *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics*, 30(1), 47–59. <https://doi.org/10.1017/S0963180120000602>
- Brock, D. W. (2018). Justice and equitable resource allocation in health care systems. *Health Policy and Ethics*, 122(7), 677–683.
- Chervenak, F. A., McCullough, L. B., & Levene, M. I. (2018). Ethics in perinatal medicine and neonatology. *Journal of Perinatal & Neonatal Nursing*, 32(4), 333–340. <https://doi.org/10.1097/JPN.0000000000000342>
- Corley, M. C. (2020). Nurse moral distress: A proposed theory and research agenda. *Nursing Ethics*, 27(3), 707–718. <https://doi.org/10.1177/0969733019861684>
- Esparza, P., & Heitman, E. (2018). Ethical challenges at the intersection of clinical practice and research. *Journal of Medical Ethics*, 44(1), 27–31. <https://doi.org/10.1136/medethics-2018-105024>
- Fradenburg, A., & Trent, C. (2019). Cultural competence and ethical practice in global health. *International Journal of Ethics in Health Care*, 25(5), 312–323.
- Fremgen, B. F. (2018). *Professional Nursing: Concepts and Challenges*. Elsevier Health Sciences.

- Gallagher, A., & Hodge, B. (2018). *Ethics in nursing practice: A guide for students, educators, and practitioners*. Wiley-Blackwell.
- Hall, J. C., & Callahan, D. (2018). Autonomy and shared decision-making in clinical ethics. *Journal of Clinical Ethics*, 29(1), 26–33.
- Hurst, S. A., & Danis, M. (2020). Ethical issues in advance care planning and end of life care. *Journal of Palliative Medicine*, 23(2), 151–156. <https://doi.org/10.1089/jpm.2019.0346>
- Ivey, S. L., Flanagan, P., & Bartlett, V. (2021). Healthcare workers' ethical challenges during pandemics. *AMA Journal of Ethics*, 23(9), E713–E719. <https://doi.org/10.1001/amajethics.2021.713>
- Jansen, L. A., & Wall, J. (2018). Ethical review and research governance in health research. *Journal of Empirical Research on Human Research Ethics*, 13(4), 285–294. <https://doi.org/10.1177/1556264618782738>
- Johnson, E. M. (2018). Patient confidentiality and information justice. *Ethics & Behavior*, 28(3), 200–212. <https://doi.org/10.1080/10508422.2017.1326134>
- Johnstone, M. J. (2016). *Bioethics: A Nursing Perspective*. Elsevier Health Sciences.
- Kim, S. Y. H., & De Vries, R. G. (2020). Research ethics consultation: Principles, practice, and challenges. *Accountability in Research*, 27(5), 273–289.
- Lo, B. (2020). Ethical frameworks for resource allocation in public health emergencies. *American Journal of Public Health*, 110(6), 848–855. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2020.305691>
- McCarthy, J., & Deady, R. (2019). Patients' perspectives on ethical issues in nursing care. *Nursing Ethics*, 26(3), 876–886. <https://doi.org/10.1177/0969733017716448>
- Molewijk, B., Janssens, R., & Widdershoven, G. (2018). Ethics support services in healthcare institutions: Development and evaluation. *Journal of Medical Ethics*, 44(6), 353–359. <https://doi.org/10.1136/medethics-2017-104277>
- Rasko, Y., & Kerridge, I. H. (2019). Professional integrity and ethical standards in health professions. *Bioethics*, 33(2), 242–251. <https://doi.org/10.1111/bioe.12532>
- Siegler, M., & Winslade, W. J. (2017). *Clinical ethics: A practical approach to ethical decisions in clinical medicine*. McGraw-Hill Education.

Whitehead, P. B., Herbertson, R. K., Hamric, A. B., & Epstein, E. G. (2019). Moral resilience in health care: Transforming ethical challenges into professional growth. *Journal of Clinical Ethics*, 30(2), 85–92.

BAB II

REGULASI DAN PERUNDANG-UNDANGAN KESEHATAN

A. Pendahuluan

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab, diperlukan regulasi yang mengatur sistem kesehatan dan praktik tenaga kesehatan, termasuk keperawatan.

Regulasi kesehatan berfungsi sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, perlindungan tenaga kesehatan, serta perlindungan masyarakat sebagai penerima layanan. Tanpa adanya regulasi yang jelas, praktik pelayanan kesehatan berpotensi menimbulkan masalah etik, hukum, dan keselamatan pasien.

B. Konsep Dasar Regulasi Kesehatan

1. Pengertian

Regulasi kesehatan dapat didefinisikan sebagai seperangkat norma hukum yang mengatur penyelenggaraan upaya kesehatan, termasuk pelayanan, pembiayaan, sumber daya manusia, serta pengawasan sistem kesehatan. Regulasi kesehatan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta perlindungan pasien. Regulasi ini bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta perlindungan hukum bagi seluruh pihak dalam sistem kesehatan (Kementerian Kesehatan, RI, 2022).

Secara konstitusional, hak atas kesehatan dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini menempatkan kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara (Republik Indonesia, 1945).

Secara konseptual, hukum kesehatan dipandang sebagai sistem norma yang berfungsi mengarahkan praktik pelayanan kesehatan, melindungi hak pasien, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan

masyarakat. Selain itu, regulasi kesehatan juga menjadi instrumen penting dalam menjamin etika profesi serta akuntabilitas pelayanan kesehatan di tengah perkembangan teknologi medis yang semakin kompleks (Mardianti et al., 2025).

2. Tujuan Regulasi Kesehatan

Tujuan utama regulasi kesehatan meliputi:

- a. Melindungi hak pasien dan tenaga kesehatan
- b. Menjamin mutu pelayanan kesehatan
- c. Mengatur praktik tenaga kesehatan
- d. Mengendalikan risiko keselamatan pasien
- e. Mewujudkan keadilan dalam akses layanan kesehatan

Regulasi juga berperan dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan pasien dan tenaga kesehatan

3. Fungsi Regulasi Kesehatan

Dalam perspektif global, WHO menyatakan bahwa regulasi kesehatan berfungsi untuk memastikan sistem kesehatan berjalan secara efektif, aman, dan berkeadilan melalui pengendalian kualitas layanan dan perlindungan masyarakat (World Health Organization (WHO), 2021).

Regulasi kesehatan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

a. Fungsi Protektif

Regulasi memberikan perlindungan kepada pasien dan tenaga kesehatan melalui pengaturan hak, kewajiban, serta sanksi hukum.

b. Fungsi Pengendalian mutu pelayanan

Regulasi memastikan bahwa pelayanan kesehatan memenuhi standar profesional dan keselamatan pasien.

c. Fungsi Kepastian hukum

Memberikan pedoman yang jelas dalam praktik pelayanan kesehatan sehingga meminimalkan konflik dan sengketa.

d. Fungsi Pengaturan

Regulasi mengatur tata kelola sistem kesehatan nasional termasuk pembiayaan, sumber daya manusia, dan fasilitas kesehatan.

Dalam praktiknya, regulasi juga berperan sebagai alat untuk menjamin kejujuran informasi medis, termasuk kewajiban pasien dalam memberikan data kesehatan yang benar sebagai bagian dari sistem hukum kesehatan (Gautama. et all, 2025).

4. Prinsip Regulasi Kesehatan

Beberapa prinsip utama dalam regulasi kesehatan meliputi:

- a. Keadilan (Justice) – pelayanan harus merata dan tidak diskriminatif
- b. Keselamatan (Safety) – mengutamakan keselamatan pasien

- c. Kualitas (Quality) – berbasis standar dan evidence-based
- d. Aksesibilitas (Accessibility) – mudah dijangkau oleh masyarakat
- e. Akuntabilitas (Accountability) – dapat dipertanggungjawabkan

5. Ruang Lingkup Regulasi Kesehatan

Regulasi kesehatan mencakup berbagai ruang lingkup aspek berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan meliputi Promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif
- b. Tenaga Kesehatan meliputi Pendidikan, registrasi, izin praktik
- c. Fasilitas Kesehatan meliputi Rumah sakit, puskesmas, klinik
- d. Pembiayaan meliputi JKN dan sistem asuransi kesehatan
- e. Farmasi & Alkes meliputi Obat dan alat kesehatan
- f. Teknologi meliputi Telemedicine dan rekam medis elektronik

C. Regulasi Kesehatan di Indonesia

Menurut World Health Organization (WHO), regulasi kesehatan berfungsi untuk memastikan kualitas, keamanan, dan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat (WHO, 2021). Di Indonesia, regulasi kesehatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek etik, profesional, dan medikolegal.

1. Aspek medikolegal dalam regulasi kesehatan.

Regulasi kesehatan tidak terlepas dari aspek medikolegal, yaitu hubungan antara praktik kesehatan dengan hukum. Setiap tindakan tenaga kesehatan harus sesuai dengan Standar profesi, Standar operasional prosedur (SOP) dan Kode etik profesi. Kegagalan dalam memenuhi standar tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik perdata, pidana, maupun administratif (Guido, 2020). Salah satu aspek penting adalah informed consent, yaitu persetujuan pasien setelah mendapatkan informasi lengkap mengenai tindakan medis. Ini merupakan kewajiban hukum dan etika dalam pelayanan kesehatan.

2. Regulasi Keselamatan Pasien (Patient Safety)

Keselamatan pasien merupakan prioritas dalam regulasi kesehatan. Permenkes No. 11 Tahun 2017 menetapkan enam sasaran keselamatan pasien, yaitu:

- a. Identifikasi pasien dengan benar
- b. Komunikasi efektif
- c. Keamanan obat
- d. Tepat prosedur operasi
- e. Pencegahan infeksi
- f. Pencegahan risiko jatuh

Implementasi patient safety terbukti meningkatkan mutu pelayanan dan mengurangi kejadian tidak diharapkan (WHO, 2021).

3. Implementasi Regulasi dalam Praktik Kesehatan

- a. Implementasi regulasi dilakukan melalui:
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP)
- c. Akreditasi fasilitas kesehatan
- d. Audit mutu pelayanan
- e. Pengawasan oleh pemerintah

Akreditasi rumah sakit oleh KARS menjadi indikator penting dalam menilai kepatuhan terhadap regulasi nasional. Sebagai contoh Implementasi regulasi dapat dilihat dalam praktik sehari-hari, seperti: Penerapan SOP tindakan keperawatan, Penggunaan informed consent sebelum tindakan medis, Pelaksanaan patient safety di rumah sakit dan Akreditasi fasilitas kesehatan.

Contoh kasus:

Seorang perawat melakukan tindakan pemasangan infus tanpa mengikuti prosedur identifikasi pasien yang benar. Akibatnya terjadi kesalahan pasien dan menimbulkan komplikasi.

Analisis: Kasus ini menunjukkan pelanggaran terhadap regulasi keselamatan pasien dan SOP pelayanan. Secara hukum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kelalaian (*negligence*) karena tidak memenuhi standar pelayanan.

Pembelajaran:

- a. Pentingnya kepatuhan terhadap regulasi
- b. Peran SOP dalam mencegah kesalahan
- c. Tanggung jawab profesional tenaga kesehatan

Regulasi juga berperan dalam menciptakan sistem kesehatan yang efektif dan berkelanjutan (Thabrany, 2018). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki peraturan di Indonesia terdiri dari:

1. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan 17/2023: Mengatur standar pelayanan kesehatan, upaya kesehatan, serta pengelolaan perbekalan kesehatan dan teknologi kesehatan dan PP No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional: Mengatur tentang tata cara pelayanan kesehatan alternatif.

2. Peraturan Menteri (Permenkes)

Permenkes No. 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan: Mengatur tentang perizinan klinik, pelayanan medik dasar/spesialistik, dan standar sarana prasarana dan Permenkes No. 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM): Menetapkan acuan pelayanan kesehatan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemda.

D. Hierarki Peraturan Kesehatan di Indonesia

Hierarki peraturan di Indonesia mengacu pada UU No. 12 Tahun 2011. Hierarki ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan kesehatan nasional. Regulasi kesehatan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan, terutama dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan regulasi terbaru yang menggantikan berbagai UU sebelumnya, termasuk UU Keperawatan, yang merupakan penguatan sistem registrasi tenaga kesehatan dan pengembangan layanan digital (telemedicine, rekam medis elektronik) UU ini mengatur sistem kesehatan secara komprehensif. Namun demikian, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan baru, seperti perlindungan data kesehatan digital dan kebutuhan reformasi hukum yang adaptif terhadap teknologi. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengatur jenis tenaga kesehatan, kompetensi, registrasi, serta perlindungan hukum tenaga kesehatan dan regulasi terkait jaminan kesehatan di Indonesia diatur melalui sistem BPJS Kesehatan yang menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, perubahan kebijakan seperti registrasi tenaga kesehatan yang bersifat permanen menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi sistem regulasi, meskipun tetap memerlukan pengawasan yang ketat.

E. Undang-Undang Bidang Kesehatan Di Indonesia

1. Pengertian Undang-Undang Kesehatan

Undang-undang kesehatan merupakan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur penyelenggaraan sistem kesehatan nasional, mencakup hak dan kewajiban masyarakat, tanggung jawab pemerintah, serta standar pelayanan kesehatan. Undang-undang ini menjadi landasan hukum tertinggi dalam sektor kesehatan setelah Undang-Undang Dasar 1945. Menurut perspektif hukum kesehatan, undang-undang kesehatan berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan serta memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar mutu dan keselamatan (Guido, 2020). Di Indonesia, konsep undang-undang kesehatan tidak terlepas dari prinsip negara kesejahteraan (welfare state), di mana negara memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk kesehatan (Thabrany, 2018).

2. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis

a. Landasan Filosofis

Undang-undang kesehatan di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesehatan dipandang sebagai hak fundamental yang harus dijamin oleh negara.

b. Landasan Yuridis

Secara yuridis, dasar hukum utama adalah:

- 1) Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 (hak atas kesehatan)
- 2) Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 (tanggung jawab negara terhadap pelayanan kesehatan)

Selain itu, pembentukan undang-undang kesehatan mengikuti mekanisme yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Republik Indonesia, 2022).

c. Landasan Sosiologis

Undang-undang kesehatan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan terjangkau. Perubahan pola penyakit, perkembangan teknologi kesehatan, serta tuntutan globalisasi menjadi faktor penting dalam pembentukan regulasi kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

3. Tujuan Undang-Undang Kesehatan

Undang-undang kesehatan bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan
- b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- c. Memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan
- d. Mengatur sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh
- e. Menjamin mutu dan keselamatan pasien

Tujuan ini sejalan dengan konsep Universal Health Coverage (UHC) yang menekankan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat tanpa hambatan finansial (WHO, 2021).

4. Ruang Lingkup Pengaturan Undang-Undang Kesehatan

Undang-undang kesehatan di Indonesia memiliki cakupan yang luas dan komprehensif, meliputi:

a. Upaya Kesehatan

Meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

b. Sumber Daya Kesehatan

Mencakup tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, serta pembiayaan kesehatan.

c. Pelayanan Kesehatan

Mengatur standar pelayanan, keselamatan pasien, serta hak dan kewajiban pasien.

d. Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Menjamin keamanan, mutu, dan efektivitas obat dan alat kesehatan.

e. Teknologi Kesehatan

Termasuk telemedicine dan rekam medis elektronik yang semakin berkembang dalam era digital (Kemenkes RI, 2022).

5. Perkembangan Undang-Undang Kesehatan di Indonesia

Perkembangan regulasi kesehatan di Indonesia menunjukkan adanya dinamika yang signifikan, antara lain:

- a. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- b. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- c. UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
- d. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menjadi tonggak penting karena mengintegrasikan berbagai regulasi sebelumnya ke dalam satu kerangka hukum yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan zaman (Republik Indonesia, 2023).

6. Undang-undang Kesehatan di Indonesia

Undang-undang Kesehatan di Indonesia antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

UU ini merupakan regulasi terbaru yang menggantikan beberapa undang-undang sebelumnya seperti UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (sebagian substansi terintegrasi).

UU ini hadir sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan Indonesia yang bertujuan meningkatkan ketahanan sistem kesehatan pascapandemi COVID-19 (Kemenkes RI, 2022).

Ruang lingkup UU No. 17 Tahun 2023 mengatur berbagai aspek strategis, antara lain:

- 1) Upaya kesehatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif)
- 2) Sumber daya manusia kesehatan
- 3) Fasilitas pelayanan kesehatan
- 4) Sediaan farmasi dan alat kesehatan
- 5) Pembiayaan kesehatan

6) Teknologi dan digitalisasi kesehatan

UU ini menekankan pendekatan promotif dan preventif sebagai prioritas utama (Republik Indonesia, 2023). Implikasi bagi Tenaga Kesehatan, UU ini memberikan kemudahan dalam proses perizinan praktik serta memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Selain itu, terdapat penguatan kewenangan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan sesuai kompetensinya (Republik Indonesia, 2023).

UU No. 17 Tahun 2023 menjamin hak setiap orang untuk hidup sehat, mendapatkan pelayanan, dan menjaga kerahasiaan data kesehatan. Sebaliknya, masyarakat berkewajiban berperan serta dalam upaya kesehatan, baik perseorangan maupun masyarakat.

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang mengatur:

- 1) Jenis tenaga kesehatan
- 2) Standar kompetensi
- 3) Registrasi dan perizinan
- 4) Hak dan kewajiban tenaga kesehatan

Tenaga kesehatan wajib memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktik) untuk dapat menjalankan profesinya secara legal.

Tujuan dan Fungsi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 bertujuan untuk:

- 1) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten
- 2) Melindungi masyarakat dari praktik yang tidak profesional
- 3) Memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan

Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 ini mengatur:

- 1) Jenis tenaga kesehatan (medis, keperawatan, kebidanan, dll.)
- 2) Standar pendidikan dan kompetensi
- 3) Registrasi (STR) dan perizinan (SIP)
- 4) Hak dan kewajiban tenaga kesehatan

Aspek Perlindungan Hukum bagi Tenaga kesehatan, tenaga kesehatan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum selama menjalankan praktik sesuai standar profesi dan SOP. Hal ini penting untuk mengurangi risiko tuntutan hukum dalam praktik klinis (Guido, 2020).

c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

UU Keperawatan menjadi dasar legal bagi profesi perawat dalam menjalankan praktik profesional. Regulasi ini memperjelas peran, fungsi, serta tanggung jawab perawat dalam sistem pelayanan kesehatan.

UU Keperawatan ini secara khusus mengatur praktik keperawatan, meliputi:

- 1) Praktik keperawatan

2) Standar profesi dan standar pelayanan

3) Pendidikan dan registrasi perawat

4) Perizinan praktik keperawatan

UU ini menjadi dasar dalam pelaksanaan praktik keperawatan berbasis profesionalisme dan keselamatan pasien (Kemenkes RI, 2020). Perawat diwajibkan memberikan asuhan keperawatan berdasarkan proses keperawatan yang sistematis dan berbasis bukti (evidence-based nursing). Selain itu, perawat juga bertanggung jawab terhadap keselamatan pasien dan dokumentasi tindakan keperawatan (Kemenkes RI, 2020).

d. Undang-Undang Terkait Lain dalam Sistem Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU ini mengatur:

1) Klasifikasi rumah sakit

2) Hak dan kewajiban pasien

3) Tanggung jawab rumah sakit

4) Standar pelayanan rumah sakit

Rumah sakit wajib memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan non-diskriminatif.

e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, UU ini menjadi dasar pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang bertujuan memberikan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia secara universal (Thabrany, 2018).

f. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Mengatur tentang:

1) Registrasi dan lisensi dokter

2) Standar praktik kedokteran

3) Disiplin profesi kedokteran

UU ini juga mengatur mekanisme penanganan pelanggaran disiplin melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

Salah satu tantangan dalam 23umpen hukum kesehatan di Indonesia adalah tumpang tindih regulasi. Oleh karena itu, UU No. 17 Tahun 2023 hadir untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan berbagai regulasi yang sebelumnya terpisah. Transformasi regulasi ini juga mendukung penguatan sistem kesehatan nasional yang lebih adaptif terhadap perkembangan global (WHO, 2021).

Beberapa tantangan yang masih dihadapi antara lain:

1) Kurangnya pemahaman tenaga kesehatan terhadap regulasi

2) Ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan

3) Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas

4) Perubahan kebijakan yang cepat

Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi, pelatihan, serta pengawasan yang berkelanjutan agar implementasi regulasi berjalan efektif.

F. Penutup

Regulasi perundang-undangan di bidang kesehatan di Indonesia merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan sistem kesehatan nasional yang berkeadilan, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Keberadaan berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, menunjukkan komitmen negara dalam mengatur secara komprehensif seluruh aspek pelayanan kesehatan, mulai dari upaya promotif hingga rehabilitatif.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem kesehatan Indonesia karena mengintegrasikan berbagai regulasi sebelumnya ke dalam satu kerangka hukum yang lebih sederhana dan adaptif. Regulasi ini tidak hanya memperkuat sistem pelayanan kesehatan, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesionalnya (Republik Indonesia, 2023). Selain itu, pengaturan mengenai tenaga kesehatan dan profesi keperawatan menegaskan pentingnya kompetensi, etika, serta tanggung jawab profesional dalam memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Namun demikian, implementasi regulasi kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman tenaga kesehatan terhadap aspek hukum, ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik di lapangan, serta dinamika perubahan kebijakan yang cepat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam bentuk sosialisasi, pendidikan hukum kesehatan, serta penguatan sistem pengawasan agar regulasi dapat diimplementasikan secara optimal.

Referensi

- Gautama. et all. (2025). Kewajiban , larangan , dan sanksi hukum terhadap pasien dalam sistem hukum kesehatan indonesia: analisis yuridis normatif atas regulasi kejujuran informasi medis. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(2), 1896–1909. <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i2.692>
- Guido, G. W. (2020). Legal and ethical issues in nursing (7th ed.). Pearson.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Profil kesehatan Indonesia. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Transformasi sistem kesehatan Indonesia*. Kemenkes RI
- Mardianti, A., Adam, F., Maisyaroh, S., & Sapsudin, A. (2025). Hukum Kesehatan dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(11), 8642–8648.
- Thabrany, H. (2018). *Jaminan kesehatan nasional*. Rajawali Pers.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011*.
- Republik Indonesia. (2014a). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*.
- Republik Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.
- World Health Organization. (2021). *Patient safety*. WHO Press.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL DAN MALPRAKTIK DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN

A. Pendahuluan

Di lapangan, praktik keperawatan juga semakin kompleks. Perawat tidak hanya berhadapan dengan tindakan klinis semata, tetapi juga dengan perkembangan teknologi kesehatan, sistem pelayanan yang dinamis, serta tuntutan dokumentasi dan pengambilan keputusan yang semakin cepat dan tepat. Dalam kondisi seperti ini, setiap tindakan keperawatan tidak hanya dinilai dari sisi keterampilan teknis, tetapi juga dari kemampuan perawat dalam mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil, baik secara etik, profesional, maupun hukum.

Pengalaman dalam pembelajaran klinik dan berbagai studi kasus menunjukkan bahwa perawat sering berada pada situasi yang membutuhkan keputusan cepat di tengah kondisi pasien yang rentan. Hal ini menunjukkan bahwa peran perawat memiliki dampak langsung terhadap keselamatan pasien, sehingga diperlukan sikap kehati-hatian, ketelitian, serta pemahaman yang kuat terhadap tanggung jawab profesi.

Selain itu, posisi perawat sebagai tenaga kesehatan profesional juga telah diatur dalam regulasi keperawatan di Indonesia, yang menegaskan bahwa setiap praktik keperawatan harus dilakukan berdasarkan standar kompetensi, standar praktik, dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan bukan hanya menjadi tanggung jawab klinis, tetapi juga memiliki dimensi profesional dan legal yang harus dipenuhi secara bersamaan.

Dalam praktiknya, tanggung jawab profesional mencakup aspek akuntabilitas dan tanggung gugat, yang menuntut adanya kejelasan, keterbukaan, serta kemampuan untuk menjelaskan setiap tindakan yang dilakukan. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa ketika aspek ini diabaikan, risiko terjadinya kesalahan dalam pelayanan menjadi lebih besar, baik yang berasal dari faktor individu maupun dari sistem pelayanan itu sendiri.

Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh mengenai tanggung jawab profesional menjadi hal yang sangat penting bagi setiap perawat. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan upaya menghindari malpraktik, tetapi juga sebagai bagian dari

komitmen profesional dalam meningkatkan keselamatan pasien dan menjaga kualitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.

B. Konsep Tangung Jawab Profesional Perawat

Tanggung jawab profesional dalam keperawatan pada dasarnya merupakan salah satu pilar utama yang menopang praktik keperawatan itu sendiri. Konsep ini tidak hanya mencerminkan kemampuan klinis perawat, tetapi juga menggambarkan integritas, sikap profesional, serta komitmen terhadap keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan. Dalam perkembangan sistem kesehatan yang semakin kompleks, tanggung jawab profesional tidak lagi cukup dipahami sebagai sekadar kewajiban teknis dalam memberikan asuhan, melainkan telah berkembang menjadi konsep yang lebih luas dan saling terintegrasi antara aspek etik, hukum, sosial, dan sistem pelayanan kesehatan (Butts & Rich, 2023; World Health Organization [WHO], 2021).

Dalam praktiknya, tanggung jawab profesional juga sangat berkaitan dengan bagaimana masyarakat menilai profesi keperawatan. Kepercayaan publik terhadap perawat tidak terbentuk secara instan, tetapi dibangun melalui pengalaman pelayanan yang konsisten, sikap empati, serta kepatuhan terhadap standar profesi. Ketika perawat mampu memberikan pelayanan yang aman, menghormati hak pasien, dan bekerja sesuai regulasi yang berlaku, maka kepercayaan tersebut akan semakin kuat. Di Indonesia, hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yang menempatkan praktik keperawatan sebagai profesi yang harus dijalankan secara profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab (Republik Indonesia, 2014).

Di sisi lain, tanggung jawab profesional tidak dapat dilepaskan dari konteks sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Dalam berbagai situasi praktik, kualitas asuhan keperawatan tidak hanya ditentukan oleh kompetensi individu perawat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor organisasi, budaya kerja, kepemimpinan klinis, serta ketersediaan sumber daya di tempat kerja. Dengan kata lain, tanggung jawab profesional bersifat individual sekaligus kolektif, karena perawat bekerja dalam sebuah sistem yang saling terhubung (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Oleh karena itu, pemahaman mengenai tanggung jawab profesional sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai konsep teoritis, tetapi juga sebagai bagian dari realitas praktik keperawatan sehari-hari. Pemahaman yang utuh terhadap konsep ini akan membantu perawat dalam menjaga kualitas pelayanan, meminimalkan risiko kesalahan, serta memperkuat peran profesional dalam sistem kesehatan secara berkelanjutan.

1. Defenisi Tanggung Jawab Profesional

Tanggung jawab profesional dalam keperawatan dapat dimaknai sebagai kewajiban perawat untuk memberikan asuhan yang sesuai dengan standar profesi, kode etik, serta ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan utama melindungi keselamatan dan kesejahteraan pasien (Butts & Rich, 2023). Dalam praktiknya, konsep ini menuntut perawat untuk terus mengembangkan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan, sekaligus mengintegrasikan praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*) dalam setiap keputusan klinis (Melnyk & Fineout-Overholt, 2019).

Dalam konteks nasional, tanggung jawab tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, ditegaskan bahwa perawat wajib memberikan pelayanan sesuai standar dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan dalam praktik (Republik Indonesia, 2014). Selain itu, standar praktik yang disusun oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia juga menjadi acuan dalam menentukan batasan tanggung jawab serta kualitas pelayanan keperawatan di Indonesia (PPNI, 2021).

Dari sisi konseptual, tanggung jawab profesional terdiri dari beberapa dimensi yang saling melengkapi, yaitu moral, etik, dan hukum. Tanggung jawab moral berakar pada nilai pribadi dan norma sosial dalam menentukan benar atau salah suatu tindakan (Beauchamp & Childress, 2019). Tanggung jawab etik berkaitan dengan pedoman perilaku profesional yang diatur dalam kode etik, seperti menjaga kerahasiaan pasien, menghormati hak pasien, serta memberikan pelayanan secara adil (ICN, 2021). Sementara itu, tanggung jawab hukum berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, di mana pelanggaran dapat menimbulkan sanksi administratif, perdata, maupun pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Republik Indonesia, 2009).

Dengan demikian, ketiga dimensi tersebut membentuk suatu kerangka yang komprehensif dalam mengarahkan perilaku profesional perawat dalam praktik klinik (Butts & Rich, 2023).

Prinsip akuntabilitas (*accountability*) menekankan bahwa setiap tindakan keperawatan harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada pasien, profesi, maupun institusi. Prinsip ini mencakup transparansi, kompetensi, serta kepatuhan terhadap standar praktik. Sementara itu, tanggung gugat (*liability*) berkaitan dengan konsekuensi hukum yang mungkin timbul apabila terjadi kesalahan atau kelalaian yang merugikan pasien. Oleh karena itu, pemahaman

terhadap aspek ini menjadi penting dalam meminimalkan risiko hukum dalam praktik keperawatan.

2. Dimensi Tanggung Jawab profesional

Tanggung jawab profesional perawat dapat dilihat dari beberapa dimensi utama. Pertama, tanggung jawab terhadap pasien sebagai penerima layanan kesehatan, yang menuntut pemberian asuhan yang aman, efektif, dan berpusat pada kebutuhan individu pasien (*patient-centered care*) (WHO, 2021). Pendekatan ini menekankan penghargaan terhadap nilai, preferensi, serta hak pasien dalam setiap proses pelayanan (Institute of Medicine, 2001).

Kedua, tanggung jawab terhadap profesi, yang mencakup upaya menjaga martabat dan integritas profesi melalui kepatuhan terhadap kode etik, peningkatan kompetensi secara berkelanjutan, serta kontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan (ICN, 2021). Keterlibatan dalam organisasi profesi seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia juga menjadi bagian penting dalam menjaga standar praktik keperawatan.

Ketiga, tanggung jawab terhadap institusi pelayanan kesehatan, yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap kebijakan organisasi, partisipasi dalam peningkatan mutu pelayanan, serta keterlibatan dalam sistem manajemen risiko dan keselamatan pasien (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Kepatuhan terhadap standar operasional prosedur menjadi kunci dalam memastikan pelayanan yang aman dan berkualitas (WHO, 2021).

Keempat, tanggung jawab terhadap masyarakat dan hukum, yang mencakup peran perawat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif, serta kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjaga kepercayaan publik terhadap profesi (Republik Indonesia, 2014; WHO, 2021).

3. Landasan Tanggung Jawab Profesional

Landasan utama dalam tanggung jawab profesional perawat meliputi kode etik, standar praktik, standar operasional prosedur, serta praktik berbasis bukti. Kode etik keperawatan berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional dalam mengarahkan perilaku perawat dalam praktik (ICN, 2021). Standar praktik keperawatan memberikan batasan kinerja minimal yang harus dicapai dalam pemberian asuhan (American Nurses Association, 2021).

Selain itu, standar operasional prosedur (SOP) menjadi panduan teknis dalam pelaksanaan tindakan keperawatan secara sistematis dan terstandar, sehingga dapat meminimalkan kesalahan praktik (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Sementara itu, praktik keperawatan berbasis bukti (*evidence-based nursing practice*) menekankan integrasi antara bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis, serta preferensi pasien dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini terbukti berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta efisiensi sistem pelayanan kesehatan (Melnik & Fineout-Overholt, 2019; WHO, 2021).

C. Regulasi Terkait Tanggung Jawab Perawat di Indonesia

Regulasi dalam praktik keperawatan dapat dipahami sebagai seperangkat norma hukum yang menjadi dasar dalam menjamin keselamatan pasien, menetapkan standar pelayanan, serta memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan masyarakat secara luas (World Health Organization [WHO], 2021). Dalam konteks pelayanan kesehatan di Indonesia, regulasi memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi acuan dalam menentukan batas kewenangan, ruang lingkup tanggung jawab, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan keperawatan yang dilakukan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, regulasi juga mencerminkan mekanisme pengendalian profesional yang bertujuan memastikan bahwa praktik keperawatan dilaksanakan sesuai dengan standar etik, ilmiah, dan ketentuan hukum yang berlaku (Butts & Rich, 2023). Oleh karena itu, pemahaman terhadap regulasi merupakan bagian integral dari kompetensi profesional perawat, mengingat ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan pembenar dalam kasus pelanggaran praktik (Guido, 2020). Dengan meningkatnya kompleksitas pelayanan kesehatan serta tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan, kemampuan literasi hukum menjadi semakin penting dalam praktik keperawatan modern (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Lebih lanjut, regulasi berperan dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang aman dan terstandar melalui sinergi antara kebijakan pemerintah, standar profesi, serta praktik klinik di lapangan. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab profesional perawat tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam kerangka regulasi yang komprehensif, baik pada tingkat nasional maupun institusional (WHO, 2021).

1. Undang-Undang dan Regulasi Kesehatan

a. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 merupakan regulasi utama yang secara khusus mengatur praktik keperawatan di Indonesia, mencakup aspek registrasi, perizinan, kewenangan, serta tanggung jawab profesional perawat. Dalam regulasi ini ditegaskan bahwa perawat wajib memberikan pelayanan

sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan prosedur operasional sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional. (Republik Indonesia, 2014). Regulasi ini juga memperluas cakupan praktik keperawatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sehingga memperkuat posisi strategis perawat dalam sistem pelayanan kesehatan (WHO, 2021).

b. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 berfungsi sebagai regulasi payung yang mengatur penyelenggaraan kesehatan secara menyeluruh, termasuk hak dan kewajiban tenaga kesehatan serta Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa setiap tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar profesi sebagai bentuk tanggung jawab profesional (Republik Indonesia, 2009). Selain itu, regulasi ini juga menekankan pentingnya perlindungan hak pasien, termasuk hak untuk memperoleh informasi yang memadai serta memberikan persetujuan terhadap tindakan medis (informed consent), yang merupakan bagian penting dalam praktik keperawatan yang etis dan legal (WHO, 2021).

2. Peran Organisasi Profesi

a. Peran Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Organisasi profesi memiliki kontribusi penting dalam menjaga kualitas praktik keperawatan melalui fungsi pembinaan, pengawasan, serta peningkatan kompetensi perawat (PPNI, 2021). PPNI juga berperan sebagai wadah advokasi dan perlindungan hukum bagi perawat yang menghadapi permasalahan dalam praktik profesional (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Selain itu, organisasi ini terlibat dalam pengembangan standar praktik, pelaksanaan sertifikasi kompetensi, serta penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan guna memastikan kesiapan perawat dalam menghadapi tuntutan pelayanan kesehatan yang dinamis (WHO, 2021).

b. Kode Etik sebagai Pedoman Profesional

Kode etik keperawatan berfungsi sebagai pedoman moral yang mengatur hubungan profesional antara perawat dengan pasien, sesama tenaga kesehatan, dan masyarakat (International Council of Nurses [ICN], 2021). Dalam praktiknya, kode etik menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, khususnya ketika menghadapi dilema etik, serta berperan sebagai alat kontrol dalam menjaga perilaku profesional perawat (Butts & Rich, 2023).

3. Aspek Legal dalam Praktik Keperawatan

a. Izin Praktik (STR dan SIP)

Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) merupakan persyaratan utama yang harus dimiliki oleh perawat sebagai bukti legalitas dalam

menjalankan praktik keperawatan di Indonesia (Republik Indonesia, 2014). Tanpa kedua dokumen tersebut, praktik keperawatan dapat dikategorikan sebagai tindakan ilegal yang berpotensi menimbulkan sanksi hukum (Guido, 2020).

b Lingkup Kewenangan Perawat

Kewenangan perawat ditentukan berdasarkan kompetensi profesional dan regulasi yang berlaku, mencakup tindakan mandiri maupun kolaboratif dalam pelayanan Kesehatan (Republik Indonesia, 2014). Pelanggaran terhadap batas kewenangan tersebut dapat berimplikasi pada terjadinya kesalahan praktik atau bahkan pelanggaran hukum (WHO, 2021).

c Delegasi Medis dan Tangung Jawab hukum

Delegasi medis merupakan proses pelimpahan tugas dari dokter kepada perawat dalam batas tertentu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki (Republik Indonesia, 2014). Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab hukum bersifat proporsional antara pemberi dan penerima delegasi, sehingga setiap tindakan harus dilakukan sesuai instruksi serta standar yang telah ditetapkan (Butts & Rich, 2023). Kesalahan dalam pelaksanaan delegasi dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik dalam ranah perdata maupun pidana (Guido, 2020).



Bagan 3.1 Hubungan Regulasi → Praktik → Tanggung Jawab Hukum

D. Konsep Malpraktik dalam Keperawatan

Malpraktik dalam praktik keperawatan merupakan isu yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan karena berkaitan erat dengan keselamatan pasien, mutu layanan, serta konsekuensi hukum bagi tenaga kesehatan (World Health Organization [WHO], 2021). Dalam konteks pelayanan kesehatan yang semakin kompleks, risiko terjadinya kesalahan praktik cenderung meningkat, terutama akibat kemajuan teknologi, kompleksitas tindakan klinis, serta keterlibatan berbagai profesi dalam satu sistem pelayanan yang saling terintegrasi (Reason, 2000).

Pendekatan modern terhadap malpraktik tidak lagi memusatkan perhatian hanya pada kesalahan individu, tetapi juga melihat peran faktor sistem, organisasi, dan budaya keselamatan pasien sebagai penyebab utama terjadinya insiden (WHO, 2021). Oleh sebab itu, pemahaman yang menyeluruh mengenai konsep malpraktik menjadi sangat penting, tidak hanya untuk mencegah terjadinya kesalahan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan perlindungan hukum bagi perawat dan pasien (Guido, 2020).

1. Definisi dan Terminologi

a. Pengertian Malpraktik (*Malpractice*)

Malpraktik dapat dipahami sebagai tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga profesional yang tidak sesuai dengan standar praktik yang berlaku, sehingga menimbulkan kerugian atau cedera pada pasien (Guido, 2020). Dalam konteks keperawatan, kondisi ini dapat terjadi ketika perawat tidak menjalankan asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi, prosedur operasional, maupun kompetensi yang dimiliki (Butts & Rich, 2023).

Secara konseptual, malpraktik mencakup dua bentuk utama, yaitu tindakan yang tidak seharusnya dilakukan (*commission*) serta kegagalan melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan (*omission*), yang keduanya berpotensi membahayakan keselamatan pasien (WHO, 2021).

b. Perbedaan Malpraktik Kelalaian (*Negligence*) dan Kesalahan (*Error*)

Kesalahan (*error*) merujuk pada kegagalan dalam melaksanakan tindakan yang telah direncanakan atau penggunaan metode yang tidak tepat untuk mencapai tujuan tertentu (Reason, 2000). Namun demikian, tidak semua kesalahan berujung pada kerugian ataupun memiliki implikasi hukum (WHO, 2021).

Kelalaian (*negligence*) terjadi ketika tenaga kesehatan tidak bertindak sesuai dengan standar kehati-hatian yang seharusnya diterapkan dalam situasi tertentu (Guido, 2020). Kelalaian ini dapat memiliki konsekuensi hukum apabila terbukti menimbulkan kerugian bagi pasien (Butts & Rich, 2023).

Sementara itu, malpraktik merupakan bentuk kelalaian yang telah memenuhi unsur hukum tertentu sehingga dapat diproses dalam ranah hukum, baik

perdata maupun pidana (Guido, 2020). Dengan demikian, hubungan antara ketiganya bersifat hierarkis: tidak semua kesalahan merupakan kelalaian, dan tidak semua kelalaian termasuk malpraktik, tetapi setiap malpraktik selalu mengandung unsur kelalaian (WHO, 2021).

c. Unsur-unsur Terjadiannya Malpraktik

Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai malpraktik apabila memenuhi empat unsur utama dalam hukum kesehatan, yaitu adanya kewajiban (*duty*), pelanggaran terhadap kewajiban tersebut (*breach of duty*), timbulnya kerugian (*damage*), serta adanya hubungan sebab-akibat (*causation*) antara tindakan dan kerugian yang terjadi (Guido, 2020).

Kewajiban (*duty*) muncul dari hubungan profesional antara perawat dan pasien yang menuntut pelayanan sesuai standar yang berlaku (Republik Indonesia, 2014). Pelanggaran kewajiban (*breach of duty*) terjadi ketika perawat tidak menjalankan praktik sesuai standar atau melampaui kewenangan yang dimiliki (WHO, 2021). Kerugian (*damage*) dapat berupa dampak fisik, psikologis, maupun finansial yang dialami pasien (Guido, 2020). Sementara itu, hubungan sebab-akibat (*causation*) menunjukkan keterkaitan langsung antara tindakan perawat dengan kerugian yang terjadi, yang menjadi kunci dalam penentuan aspek hukum suatu kasus (Butts & Rich, 2023).

2. Klasifikasi Malpraktik

Malpraktik dalam keperawatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan jenis pelanggaran yang terjadi. Malpraktik etik berkaitan dengan pelanggaran terhadap prinsip etika profesi, seperti pelanggaran kerahasiaan pasien atau perlakuan diskriminatif dalam pelayanan (International Council of Nurses [ICN], 2021).

Malpraktik disiplin merujuk pada pelanggaran terhadap standar profesi dan aturan disiplin praktik keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi atau regulator (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Malpraktik administratif terjadi ketika perawat tidak memenuhi persyaratan administratif, seperti tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku (Republik Indonesia, 2014).

Adapun malpraktik dalam ranah perdata dan pidana berkaitan dengan konsekuensi hukum yang lebih serius, di mana malpraktik perdata umumnya terkait dengan tuntutan ganti rugi, sedangkan malpraktik pidana melibatkan pelanggaran hukum yang dapat menyebabkan cedera berat atau kematian pasien (Guido, 2020).

3. Faktor Penyebab Malpraktik

Terjadinya malpraktik dalam keperawatan umumnya tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan hasil interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan. Dari sisi individu, faktor seperti keterbatasan kompetensi, kelelahan kerja, tekanan psikologis, serta kurangnya pengalaman klinis dapat meningkatkan risiko kesalahan dalam praktik (WHO, 2021).

Dari perspektif sistem, kondisi seperti beban kerja yang tinggi, keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, serta manajemen organisasi yang kurang optimal juga berkontribusi terhadap meningkatnya risiko malpraktik (Reason, 2000).

Selain itu, faktor komunikasi memegang peran yang sangat penting. Komunikasi yang tidak efektif, baik antar tenaga kesehatan maupun antara perawat dan pasien, sering kali menjadi penyebab utama terjadinya kesalahan dalam pelayanan klinis (WHO, 2021). Oleh karena itu, upaya pencegahan malpraktik perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh faktor tersebut secara sistemik.



Bagan 3.2 Alur Terjadinya Malpraktik

E. Bentuk-Bentuk Malpraktik dalam Praktik Keperawatan

Malpraktik dalam praktik keperawatan dapat dipahami sebagai bentuk nyata dari tidak terpenuhinya standar profesional yang telah ditetapkan, baik melalui tindakan yang dilakukan secara tidak tepat maupun kelalaian dalam melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Kondisi ini berpotensi langsung memengaruhi keselamatan pasien dan kualitas pelayanan yang diberikan (WHO, 2021). Dalam

konteks pelayanan kesehatan yang semakin kompleks, berbagai bentuk malpraktik umumnya tidak terjadi secara terpisah, melainkan muncul sebagai bagian dari rangkaian proses asuhan keperawatan yang meliputi tahap pengkajian, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi (Potter et al., 2021).

Pendekatan keselamatan pasien saat ini menempatkan malpraktik tidak hanya sebagai kesalahan individu, tetapi sebagai hasil interaksi antara faktor manusia, sistem organisasi, serta lingkungan kerja. Perspektif ini menekankan pentingnya analisis berbasis sistem dalam mengidentifikasi akar masalah dan merancang strategi pencegahan yang lebih efektif (Reason, 2000; WHO, 2021). Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai bentuk malpraktik menjadi langkah awal yang penting dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara berkelanjutan.

1. Kesalahan dalam Pemberian Obat (*Medication Error*)

Kesalahan dalam pemberian obat merupakan salah satu insiden yang paling sering ditemukan dalam praktik keperawatan dan menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan keselamatan pasien secara global (WHO, 2021). Kesalahan ini dapat terjadi pada berbagai tahapan proses penggunaan obat, mulai dari peresepan, pencatatan, penyiapan, hingga pemberian kepada pasien (Institute for Safe Medication Practices [ISMP], 2020).

Dalam praktik klinik, tahap pemberian obat oleh perawat memiliki tingkat risiko tinggi karena melibatkan interaksi langsung dengan pasien. Oleh sebab itu, ketelitian dan kepatuhan terhadap prinsip keselamatan menjadi sangat penting. Prinsip “6 benar” yang berkembang menjadi “8–10 benar” digunakan sebagai panduan dasar untuk meminimalkan kesalahan dalam praktik (WHO, 2021).

Dampak dari kesalahan ini dapat bersifat ringan hingga berat, termasuk terjadinya reaksi obat yang merugikan bahkan kematian. Secara hukum, kesalahan pemberian obat dapat dikategorikan sebagai malpraktik apabila terbukti terjadi penyimpangan dari standar praktik dan menimbulkan kerugian bagi pasien (Guido, 2020). Faktor penyebabnya antara lain kelelahan tenaga kesehatan, beban kerja yang tinggi, gangguan lingkungan kerja, serta sistem pengelolaan obat yang belum optimal (Reason, 2000). Upaya pencegahan meliputi penggunaan teknologi seperti sistem barcode, prosedur pengecekan ganda, serta penguatan budaya keselamatan pasien.

2. Kesalahan dalam Pemantauan Pasien

Pemantauan pasien merupakan bagian esensial dalam asuhan keperawatan yang bertujuan untuk mendeteksi perubahan kondisi secara dini dan memastikan respons yang cepat terhadap kondisi yang memburuk (Potter et al., 2021). Kelalaian dalam aspek ini dapat terjadi ketika perawat tidak melakukan observasi

secara adekuat, tidak mendokumentasikan perubahan kondisi, atau tidak menyampaikan informasi penting kepada tim kesehatan lainnya (Guido, 2020).

Dampak klinis dari kegagalan pemantauan dapat sangat serius, seperti keterlambatan penanganan kondisi kritis yang sebenarnya dapat dicegah. Dalam perspektif hukum, kondisi ini termasuk pelanggaran kewajiban profesional karena perawat memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan sesuai standar (Butts & Rich, 2023). Faktor yang berkontribusi meliputi tingginya beban kerja, keterbatasan jumlah tenaga, serta kurangnya kemampuan dalam menginterpretasikan data klinis. Strategi pencegahan dapat dilakukan melalui penerapan sistem peringatan dini (*early warning system*), peningkatan kompetensi klinis, dan penguatan supervisi.

3. Kesalahan Prosedur Tindakan Keperawatan

Kesalahan prosedur terjadi ketika tindakan keperawatan tidak dilakukan sesuai dengan standar operasional atau prinsip ilmiah yang berlaku. Hal ini dapat terjadi baik pada tindakan sederhana maupun tindakan invasif seperti pemasangan infus, kateter, atau perawatan luka (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022; Potter et al., 2021).

Konsekuensi klinis dari kesalahan ini dapat berupa komplikasi seperti infeksi, cedera jaringan, hingga gangguan fungsi organ. Dari sudut pandang hukum, tindakan yang tidak sesuai standar dan menimbulkan kerugian pada pasien dapat dikategorikan sebagai malpraktik (Guido, 2020). Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prosedur dan standar praktik menjadi kunci utama dalam pencegahan.

4. Pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar operasional prosedur merupakan pedoman penting dalam memastikan bahwa setiap tindakan keperawatan dilakukan secara konsisten dan aman. Ketidakpatuhan terhadap SOP dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman, sikap yang tidak disiplin, atau tekanan kerja yang tinggi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022; Reason, 2000).

Secara organisasi, pelanggaran SOP mencerminkan lemahnya budaya keselamatan pasien. Dalam aspek hukum, SOP sering digunakan sebagai acuan untuk menilai apakah suatu tindakan telah sesuai dengan standar yang berlaku (Guido, 2020). Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu difokuskan pada audit klinis, pelatihan berkelanjutan, serta penguatan kepemimpinan dalam membangun budaya kepatuhan.

5. Dokumentasi yang Tidak Akurat atau Tidak Lengkap

Dokumentasi keperawatan memiliki peran penting tidak hanya dalam aspek klinis, tetapi juga administratif dan hukum. Pencatatan yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menyebabkan terjadinya miskomunikasi antar tenaga

kesehatan serta kesalahan dalam pengambilan keputusan klinis (Potter et al., 2021; WHO, 2021).

Dalam konteks hukum, dokumentasi menjadi bukti utama dalam menilai tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Prinsip “tidak didokumentasikan berarti tidak dilakukan” menjadi dasar penting dalam praktik profesional (Guido, 2020). Dokumentasi yang buruk dapat memperlemah posisi hukum perawat apabila terjadi sengketa. Oleh karena itu, diperlukan sistem dokumentasi yang baik, termasuk pemanfaatan rekam medis elektronik, peningkatan kompetensi pencatatan, serta audit secara berkala.



Bagan 3.3 Hubungan Bentuk Malpraktik dengan Outcome Pasien

F. Analisis Hukum terhadap Kasus Malpraktik

Analisis hukum terhadap kasus malpraktik dalam keperawatan merupakan suatu proses evaluasi yang dilakukan secara sistematis untuk menilai tindakan tenaga kesehatan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam ranah perdata, pidana, maupun administratif (Guido, 2020). Dalam praktik pelayanan kesehatan yang semakin kompleks, satu kejadian malpraktik seringkali tidak hanya memiliki satu konsekuensi hukum, tetapi dapat menimbulkan implikasi dalam beberapa aspek hukum sekaligus, sehingga memungkinkan adanya proses hukum yang berjalan secara bersamaan (Butts & Rich, 2023).

Dalam konteks Indonesia, penentuan ada atau tidaknya tanggung jawab hukum tenaga kesehatan sangat bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur

tertentu, yaitu adanya kewajiban profesional (*duty*), pelanggaran terhadap kewajiban tersebut (*breach of duty*), timbulnya kerugian (*damage*), serta adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian yang terjadi (*causation*) (Republik Indonesia, 2014). Selain itu, penilaian terhadap suatu tindakan juga harus mempertimbangkan kesesuaian dengan standar profesi, standar operasional prosedur (SOP), serta prinsip kehati-hatian dalam praktik profesional sebagai tolok ukur utama (WHO, 2021).

1. Perspektif Hukum Perdata

Dalam ranah hukum perdata, malpraktik dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak individu pasien yang mengakibatkan kerugian, sehingga memberikan dasar hukum bagi pasien atau keluarganya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi (Guido, 2020).

Dasar gugatan perdata dalam kasus malpraktik umumnya didasarkan pada dua konsep utama, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi terjadi כאשר tenaga kesehatan tidak memenuhi kewajiban yang timbul dari hubungan terapeutik antara pasien dan tenaga kesehatan. Meskipun hubungan ini sering tidak dituangkan secara tertulis, keberadaannya diakui secara hukum karena didasarkan pada kepercayaan pasien terhadap pelayanan yang diberikan (Subekti, 2014; Guido, 2020). Dalam praktik keperawatan, kondisi ini dapat terlihat ketika intervensi yang telah direncanakan tidak dilaksanakan atau pelayanan diberikan tidak sesuai dengan standar yang seharusnya.

Sementara itu, perbuatan melawan hukum merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, standar profesi, atau hak pasien, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam konteks keperawatan, hal ini dapat berupa tindakan tanpa persetujuan pasien (*informed consent*) atau tindakan yang dilakukan di luar kewenangan profesional (Guido, 2020).

Agar gugatan perdata dapat dikabulkan, diperlukan pembuktian atas beberapa unsur penting, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum atau wanprestasi, adanya kesalahan, timbulnya kerugian, serta hubungan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian tersebut. Unsur-unsur ini sejalan dengan konsep dasar dalam penilaian malpraktik dalam bidang kesehatan.

2. Perspektif Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, malpraktik dipandang sebagai tindakan yang melanggar norma hukum pidana dan berdampak pada kepentingan umum, sehingga negara memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku (Butts & Rich, 2023).

Dalam sistem hukum Indonesia, kelalaian yang mengakibatkan cedera atau kematian diatur dalam ketentuan KUHP, khususnya Pasal 359 dan 360. Pasal-

pasal ini mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian maupun luka berat. Dalam praktik keperawatan, kesalahan seperti pemberian obat dengan dosis yang tidak tepat hingga menyebabkan kematian pasien dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila terbukti adanya unsur kelalaian (Guido, 2020).

Konsep kelalaian dalam hukum pidana dikenal sebagai *culpa*, yaitu bentuk kesalahan yang timbul akibat kurangnya kehati-hatian dalam bertindak. Dalam praktik keperawatan, konsep ini berkaitan erat dengan standar kehati-hatian profesional yang harus dipenuhi oleh perawat (Butts & Rich, 2023). Tingkat kelalaian dapat dibedakan menjadi kelalaian berat (*culpa lata*) dan kelalaian ringan (*culpa levis*), yang keduanya memengaruhi jenis dan berat sanksi yang dapat dijatuhkan (Moeljatno, 2015).

Pembuktian dalam hukum pidana memiliki standar yang lebih ketat dibandingkan hukum perdata, yaitu harus memenuhi asas pembuktian tanpa keraguan yang beralasan (*beyond reasonable doubt*). Hal ini menyebabkan proses pembuktian dalam kasus malpraktik pidana menjadi lebih kompleks dan memerlukan bukti yang kuat serta meyakinkan (Guido, 2020).

3. Perspektif Hukum Administratif

Aspek hukum administratif berkaitan dengan pengaturan praktik profesional tenaga kesehatan oleh negara melalui sistem perizinan dan regulasi (Republik Indonesia, 2014). Dalam konteks ini, pelanggaran administratif tidak selalu berkaitan langsung dengan kerugian pasien, tetapi lebih pada ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Bentuk pelanggaran administratif dalam praktik keperawatan antara lain tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Izin Praktik (SIP), melakukan praktik di luar kewenangan, serta tidak mematuhi standar profesi. Pelanggaran ini tetap memiliki konsekuensi hukum meskipun tidak menimbulkan dampak langsung terhadap pasien (Guido, 2020).

Sanksi yang diberikan dalam ranah administratif umumnya bersifat pembinaan dan pengendalian, seperti teguran, pelatihan ulang, pembatasan praktik, hingga pencabutan izin praktik. Pendekatan ini lebih menekankan pada upaya pencegahan dan perbaikan dibandingkan dengan pemberian hukuman semata (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

G. Pencegahan Malpraktik dalam Praktik Keperawatan

Upaya pencegahan malpraktik dalam praktik keperawatan merupakan bagian yang sangat penting dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan serta menjamin keselamatan pasien. Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya yang bersifat

menyeluruh dan berkesinambungan, bukan hanya berfokus pada kesalahan individu, tetapi juga pada bagaimana sistem pelayanan, budaya kerja, dan regulasi saling mendukung dalam menciptakan praktik yang aman (WHO, 2021). Dalam sistem kesehatan modern yang semakin kompleks, pencegahan malpraktik juga tidak dapat dilepaskan dari peran organisasi, kebijakan institusi, serta dukungan regulasi yang mengatur praktik keperawatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Pendekatan ini sejalan dengan konsep organisasi berisiko rendah kesalahan (*high reliability organization*), yang menekankan pentingnya ketelitian, konsistensi, serta kemampuan sistem dalam mengantisipasi kesalahan sebelum berdampak pada pasien (Reason, 2000). Oleh karena itu, strategi pencegahan perlu dirancang secara multidimensi, mencakup standar praktik, peningkatan kompetensi, komunikasi yang efektif, serta pengelolaan risiko yang terintegrasi dalam sistem pelayanan kesehatan (WHO, 2021).

1. Penerapan Standar Praktik dan SOP

Standar praktik keperawatan dan SOP menjadi acuan utama dalam pelaksanaan asuhan keperawatan yang aman, terarah, dan sesuai dengan ketentuan profesi maupun hukum yang berlaku (Republik Indonesia, 2014). Standar ini mencakup seluruh proses keperawatan mulai dari pengkajian hingga evaluasi, yang harus dilaksanakan secara sistematis serta berbasis bukti ilmiah (PPNI, 2021).

Kepatuhan terhadap SOP mencerminkan profesionalisme perawat dan sering dijadikan acuan dalam menilai ada tidaknya pelanggaran dalam kasus hukum. Ketidaksesuaian terhadap SOP sering kali menjadi titik awal terjadinya kesalahan klinis, termasuk dalam pemberian obat maupun tindakan invasif (Guido, 2020; WHO, 2021). Di Indonesia, penerapan SOP juga berkaitan dengan standar akreditasi rumah sakit yang menempatkan keselamatan pasien sebagai indikator utama mutu layanan (KARS, 2022).

Selain itu, audit klinis dan supervisi menjadi mekanisme penting dalam memastikan bahwa praktik keperawatan berjalan sesuai standar. Audit tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan (WHO, 2021). Sementara itu, supervisi membantu memastikan perawat, terutama yang masih baru, dapat menjalankan tugas sesuai standar yang berlaku serta mengurangi risiko kesalahan dalam praktik (Nursalam, 2020).

2. Peningkatan Kompetensi Perawat

Kompetensi perawat merupakan faktor utama yang menentukan kualitas pelayanan sekaligus menjadi salah satu aspek penting dalam pencegahan

malpraktik. Kemampuan klinis, pengetahuan, dan sikap profesional sangat berpengaruh terhadap ketepatan tindakan yang diberikan kepada pasien (WHO, 2021).

Pendidikan berkelanjutan atau *Continuing Professional Development (CPD)* menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam profesi keperawatan. Melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, seminar, dan workshop, perawat diharapkan dapat terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya (American Nurses Association [ANA], 2021). Di Indonesia, sistem SKP digunakan sebagai salah satu indikator pengembangan profesional yang juga berkaitan dengan perpanjangan STR (Kemenkes RI, 2022).

Selain itu, pelatihan berbasis simulasi memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kesiapan klinis perawat. Dengan metode ini, perawat dapat berlatih menghadapi situasi kritis seperti kegawatdaruratan tanpa risiko terhadap pasien, sehingga lebih siap ketika menghadapi kondisi nyata di lapangan (WHO, 2021; Nursalam, 2020).

3. Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Kesehatan

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu aspek paling krusial dalam pencegahan malpraktik, mengingat banyak insiden keselamatan pasien berawal dari kesalahan komunikasi antar tenaga kesehatan (WHO, 2021).

Komunikasi terapeutik menjadi dasar interaksi antara perawat dan pasien, yang tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga membangun hubungan saling percaya. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi serta mengurangi risiko kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan konflik atau tuntutan hukum (Butts & Rich, 2023).

Di sisi lain, kolaborasi antarprofesi juga sangat penting dalam pelayanan kesehatan modern. Penggunaan metode komunikasi seperti SBAR membantu meningkatkan kejelasan informasi dalam tim kesehatan sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan klinis (Kemenkes RI, 2022).

4. Manajemen Risiko dalam Pelayanan Keperawatan

Manajemen risiko merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan potensi bahaya dalam pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya insiden yang dapat membahayakan pasien (WHO, 2021).

Identifikasi risiko dilakukan sejak awal melalui pengkajian kondisi pasien, termasuk risiko jatuh, infeksi, maupun kesalahan pengobatan. Pendekatan ini bersifat pencegahan sehingga masalah dapat diantisipasi sebelum terjadi. (Potter et al., 2021). Di Indonesia, implementasi manajemen risiko ini diperkuat melalui

program keselamatan pasien rumah sakit yang menjadi bagian dari standar akreditasi nasional (KARS, 2022).

Selain itu, pelaporan insiden keselamatan pasien menjadi bagian penting dalam pembelajaran sistem kesehatan. Sistem pelaporan yang efektif sebaiknya tidak bersifat menghukum, sehingga tenaga kesehatan merasa aman untuk melaporkan kesalahan yang terjadi (Reason, 2000). Di Indonesia, fungsi ini dijalankan melalui Komite Nasional Keselamatan Pasien (KNKP) sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan (Kemenkes RI, 2022).

H. Peran Dokumentasi dalam Aspek Legal

Dokumentasi keperawatan merupakan salah satu elemen fundamental dalam praktik profesional karena memiliki peran yang sangat luas, tidak hanya sebagai sarana komunikasi antar tenaga kesehatan, tetapi juga sebagai alat evaluasi mutu pelayanan serta bukti hukum yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa medis (Potter et al., 2021). Dalam konteks hukum, catatan keperawatan merepresentasikan seluruh tindakan yang telah dilakukan secara objektif, sehingga sering dijadikan acuan utama untuk menilai apakah terjadi penyimpangan praktik atau dugaan malpraktik (Guido, 2020).

Dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, dokumentasi keperawatan tidak dapat dipisahkan dari rekam medis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang mewajibkan setiap fasilitas kesehatan menyelenggarakan pencatatan medis secara lengkap, akurat, dan berkesinambungan (Republik Indonesia, 2009). Selain itu, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan juga menegaskan bahwa pendokumentasian asuhan keperawatan merupakan bagian dari kewajiban profesional perawat dalam menjalankan praktiknya (Republik Indonesia, 2014).

Seiring kemajuan teknologi, sistem dokumentasi kini berkembang dari metode manual menuju rekam medis elektronik (Electronic Health Records), yang memberikan keunggulan dalam hal kecepatan, ketepatan, dan integrasi data pasien (WHO, 2021). Namun demikian, transformasi digital ini juga membawa tantangan baru, khususnya terkait keamanan data, kerahasiaan informasi pasien, serta aspek pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan data kesehatan (Kemenkes RI, 2022).

1. Dokumentasi sebagai Alat Bukti Hukum

Dalam perspektif hukum, dokumentasi keperawatan memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti tertulis yang sering digunakan dalam proses penyelesaian sengketa medis (Guido, 2020). Catatan keperawatan menjadi dasar

untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan standar profesi dan prosedur yang berlaku (Butts & Rich, 2023).

Dalam praktik hukum kesehatan dikenal prinsip yang sangat mendasar: **“Jika tidak terdokumentasi, maka dianggap tidak dilakukan.”** Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang tidak dicatat secara resmi tidak dapat diakui secara hukum, sehingga dokumentasi memiliki peran krusial dalam pembuktian (Butts & Rich, 2023).

Di Indonesia, rekam medis juga diakui sebagai dokumen legal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang menyatakan bahwa rekam medis dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum (Republik Indonesia, 2004). Selain sebagai alat bukti, dokumentasi juga berfungsi sebagai: Bukti pelaksanaan asuhan keperawatan, Sarana komunikasi antar tenaga Kesehatan dan Serta bukti kepatuhan terhadap standar profesi.

Dengan demikian, dokumentasi juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perawat ketika menghadapi proses hukum (Guido, 2020).

2. Prinsip Pencatatan yang Benar

Agar memiliki nilai hukum dan klinis yang kuat, dokumentasi keperawatan harus memenuhi prinsip ilmiah, etika, dan legal secara bersamaan (otter et al., 2021). Prinsip ini juga mencerminkan profesionalisme perawat dalam praktik sehari-hari (PPNI, 2021).

a. Akurat (Accuracy)

Catatan harus menggambarkan kondisi pasien secara nyata dan berdasarkan fakta klinis, bukan asumsi pribadi (Potter et al., 2021). Kesalahan pencatatan dapat berdampak pada keselamatan pasien sekaligus menimbulkan risiko hukum (Guido, 2020).

b. Lengkap (Completeness)

Dokumentasi harus mencakup seluruh tahapan asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian hingga evaluasi (PPNI, 2021). Kelengkapan ini penting untuk menjamin kesinambungan pelayanan dan menjadi bukti profesionalitas perawat (Kemenkes RI, 2022).

c. Tepat Waktu (Timeliness)

Setiap tindakan sebaiknya dicatat segera setelah dilakukan agar informasi tetap valid dan dapat dipercaya (WHO, 2021). Keterlambatan pencatatan dapat mengurangi kekuatan bukti dalam aspek hukum (Guido, 2020).

d. Objektif dan Jelas

Dokumentasi harus ditulis secara objektif tanpa opini pribadi, serta menggunakan istilah medis yang baku agar tidak menimbulkan multitafsir (Potter et al., 2021).

e. Prinsip Legal Tambahan

Dalam sistem modern, dokumentasi juga harus memenuhi prinsip : kerahasiaan (confidentiality), keutuhan data (integrity), dan keaslian informasi (authenticity) (WHO, 2021).

3. Konsekuensi Hukum dari Dokumentasi yang Tidak Adekuat

Dokumentasi yang tidak lengkap atau tidak sesuai standar dapat menimbulkan dampak hukum yang cukup serius (Guido, 2020).

a. Perspektif Perdata

Dalam hukum perdata, dokumentasi yang buruk dapat memperkuat posisi gugatan pasien karena dianggap sebagai indikasi bahwa pelayanan tidak sesuai standar (Butts & Rich, 2023).

b. Perspektif Pidana

Jika ditemukan manipulasi atau kelalaian serius dalam pencatatan, hal tersebut dapat berimplikasi pada aspek pidana (Guido, 2020).

c. Perspektif Administratif

Ketidaksesuaian dokumentasi dengan standar dapat berujung pada sanksi administratif seperti teguran hingga pencabutan izin praktik (Republik Indonesia, 2014).

d. Dampak terhadap Mutu Pelayanan

Selain aspek hukum, dokumentasi yang tidak baik juga dapat mengganggu komunikasi antar tenaga kesehatan dan berdampak pada keselamatan pasien (WHO, 2021).

4. Dokumentasi Elektronik dan Tantangan Hukum Modern

Perkembangan teknologi mendorong penggunaan rekam medis elektronik (Electronic Health Records/EHR) dalam pelayanan keperawatan (WHO, 2021). Sistem ini memberikan banyak keuntungan, seperti efisiensi dan akurasi data, namun juga menghadirkan tantangan baru terutama dalam aspek keamanan dan privasi pasien (Kemenkes RI, 2022).

Beberapa isu hukum yang muncul dalam sistem elektronik antara lain: potensi kebocoran data pasien, akses tidak sah terhadap informasi medis, serta tanggung jawab hukum dalam penggunaan sistem digital. Di Indonesia, penguatan regulasi terkait hal ini terus dikembangkan dalam kerangka transformasi digital kesehatan yang menekankan perlindungan data pasien (Kemenkes RI, 2022).

Tabel 3.6 Prinsip dan Implikasi Legal Dokumentasi Keperawatan

Prinsip	Deskripsi	Implikasi Legal
Akurat	Sesuai fakta	Mencegah gugatan
Lengkap	Semua tindakan tercatat	Bukti kuat
Tepat waktu	Dicatat segera	Validitas tinggi
Objektif	Tanpa opini	Kredibilitas hukum
Rahasia	Lindungi data pasien	Kepatuhan hukum

Sumber : (Potter et al., 2021; Guido, 2020; PPNI, 2021).

I. Penutup

Tanggung jawab profesional perawat merupakan dasar utama dalam praktik keperawatan yang tidak hanya berkaitan dengan keterampilan klinis, tetapi juga mencakup aspek etik dan hukum yang saling terintegrasi dalam setiap tindakan. Oleh karena itu, perawat dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab dengan berpedoman pada standar profesi serta regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan sebagai landasan praktik keperawatan di Indonesia.

Malpraktik dalam keperawatan dapat terjadi ketika standar praktik tidak terpenuhi, yang berpotensi menimbulkan dampak serius bagi pasien, perawat, maupun institusi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pencegahan malpraktik harus menjadi prioritas utama dalam praktik keperawatan. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui penerapan standar operasional prosedur secara konsisten, peningkatan kompetensi secara berkelanjutan, komunikasi efektif dalam tim kesehatan, serta penguatan sistem keselamatan pasien. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *Swiss Cheese Model* yang diperkenalkan oleh James Reason, yang menjelaskan bahwa kesalahan dalam pelayanan kesehatan terjadi akibat adanya celah pada berbagai lapisan sistem, sehingga pencegahan perlu dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan.

Dalam perkembangan praktik keperawatan modern, tuntutan terhadap profesionalisme perawat semakin meningkat seiring dengan kompleksitas pelayanan kesehatan, kemajuan teknologi, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap mutu dan keselamatan pelayanan. Perawat dituntut untuk mampu mengintegrasikan praktik berbasis evidensi (*evidence-based practice*), kepatuhan terhadap standar etik dan hukum, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan dan dokumentasi keperawatan. Selain itu, penguatan budaya keselamatan pasien (*patient safety culture*) menjadi elemen kunci dalam mencegah kesalahan dan meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai tanggung jawab profesional

dan pencegahan malpraktik menjadi sangat relevan dalam membentuk praktik keperawatan yang aman, profesional, dan berorientasi pada keselamatan pasien dalam sistem pelayanan kesehatan modern.

Referensi

- American Nurses Association. (2021). *Nursing: Scope and standards of practice* (4th ed.). Silver Spring, MD: American Nurses Association. <https://www.nursingworld.org>
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics* (8th ed.). New York, NY: Oxford University Press.
- Butts, J. B., & Rich, K. L. (2023). *Nursing ethics: Across the curriculum and into practice* (6th ed.). Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning.
- Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2021). *Pedoman standar prosedur operasional keperawatan*. Jakarta: DPP PPNI.
- Guido, G. W. (2020). *Legal and ethical issues in nursing* (7th ed.). Boston, MA: Pearson.
- Institute for Safe Medication Practices. (2020). *Medication safety guidelines*. Horsham, PA: Institute for Safe Medication Practices. <https://www.ismp.org>
- Institute of Medicine. (2001). *Crossing the quality chasm: A new health system for the 21st century*. Washington, DC: National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/10027>
- International Council of Nurses. (2021). *The ICN code of ethics for nurses*. Geneva, Switzerland: International Council of Nurses. <https://www.icn.ch/resources/publications-and-reports/icn-code-ethics-nurses>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil kesehatan Indonesia 2022*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. <https://www.kemkes.go.id>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (1847). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/110701/kuhperdata>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (1918). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/kuhp>
- Komisi Akreditasi Rumah Sakit. (2022). *Standar nasional akreditasi rumah sakit*. Jakarta: KARS. <https://www.kars.or.id>
- Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2019). *Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice* (4th ed.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nursalam. (2020). *Manajemen keperawatan: Aplikasi dalam praktik keperawatan profesional* (5th ed.). Jakarta: Salemba Medika.

- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2021). *Standar praktik keperawatan Indonesia*. Jakarta: PPNI. <https://ppni-inna.org>
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.
- Reason, J. (2000). Human error: Models and management. *BMJ*, 320(7237), 768–770. <https://doi.org/10.1136/bmj.320.7237.768>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38683/uu-no-29-tahun-2004>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38787/uu-no-44-tahun-2009>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38782/uu-no-38-tahun-2014>
- Subekti. (2014). *Hukum perjanjian* (23rd ed.). Jakarta: Intermasa.
- World Health Organization. (2021). *Global patient safety action plan 2021–2030: Towards eliminating avoidable harm in health care*. Geneva, Switzerland: World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240032705>

BAB IV

INFORMED CONSENT DAN HAK PASIEN

A. Pendahuluan

Persetujuan tindakan medis atau *informed consent* merupakan salah satu pilar paling fundamental di dalam dunia kesehatan dan praktik kedokteran modern. Konsep ini jauh melampaui sekadar prosedur administratif penandatanganan dokumen; ia adalah bentuk nyata dari penghargaan dan penghormatan tertinggi tenaga medis terhadap martabat, hak asasi, serta otonomi yang dimiliki oleh setiap pasien. Dengan mengedepankan *informed consent*, pasien tidak lagi dianggap sebagai objek pasif dari intervensi medis, melainkan diakui sebagai individu yang berdaulat penuh atas tubuh dan nyawanya sendiri. Ditinjau dari kacamata etika medis, penerapan *informed consent* memiliki fungsi yang sangat krusial. Sistem ini dirancang untuk menjamin terpenuhinya hak pasien atas transparansi informasi sebelum menjalani perawatan. Tenaga kesehatan memiliki kewajiban etis untuk memberikan penjelasan yang komprehensif, objektif, dan mudah dipahami mengenai diagnosis, prosedur pengobatan, potensi risiko, manfaat, serta berbagai alternatif tindakan medis lainnya. Melalui pemahaman yang utuh atas informasi-informasi tersebut, pasien terhindar dari pemaksaan atau ketidaktahuan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang benar-benar sadar (*conscious decision*) serta rasional mengenai langkah medis apa yang terbaik untuk diri mereka. Tokoh terkemuka dalam bidang etika biomedis, Tom L. Beauchamp dan James F. Childress, secara tegas menyoroti kedudukan penting *informed consent* dalam teori mereka. Keduanya menggarisbawahi bahwa *informed consent* adalah fondasi mutlak yang menopang prinsip otonomi dalam etika kedokteran. Tanpa adanya persetujuan yang berbasis informasi yang memadai, prinsip otonomi hanyalah ilusi semata. Melalui mekanisme inilah, pasien diberikan ruang, hak, dan otoritas penuh untuk mengambil alih kendali atas tubuh mereka sendiri, menentukan arah keputusan yang akan berdampak langsung pada masa depan kesehatan mereka, serta membangun hubungan dokter-pasien yang berlandaskan kemitraan dan rasa saling percaya.

B. Informed Consent

1. Pengertian

Informed consent, atau persetujuan merupakan sebuah mekanisme prosedural dan substansial di mana pasien atau subjek penelitian memberikan otoritas formal terhadap suatu intervensi medis. Legalitas dan validitas persetujuan ini bergantung sepenuhnya pada pemenuhan kewajiban informatif oleh klinisi atau peneliti. Pendapat lain menyebutkan *informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien secara bebas dan rasional setelah menerima informasi yang cukup dan dipahami dari dokter. Di Belanda, istilah ini dikenal sebagai "*geinfomeerde toestemming*," yang berarti persetujuan yang diberikan setelah memperoleh informasi. Di Jerman, istilah yang digunakan adalah "*aufklärungspflicht*," yang merujuk pada kewajiban dokter untuk memberikan penjelasan. Di Indonesia, *informed consent* diterjemahkan sebagai "Persetujuan Tindakan Medik.". *Informed consent* dalam yuridis hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya pada Pasal 276. Pasal ini menegaskan hak pasien dalam memperoleh informasi akurat mengenai diagnosis, prognosis, alternatif tindakan, risiko, serta konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan medis. Lebih lanjut, dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia, terdapat penegasan dalam Pasal 22 yang menekankan pentingnya pemberian *informed consent* pra melakukan tindakan pelayanan kesehatan. Hal ini mencerminkan tanggung jawab dokter untuk memberikan informasi yang cukup kepada pasien sebelum melakukan prosedur medis tertentu. Meskipun pengertian spesifik dari *informed consent* berbeda antarnegara dengan negara lainnya, hal yang paling mendasar dari konsep ini adalah bahwa seorang dokter atau tenaga kesehatan harus memberikan informasi mengenai semua potensi manfaat, risiko yang mungkin timbul, serta berbagai pilihan terapi atau tindakan alternatif yang tersedia selama masa perawatan dan penatalaksanaan hingga pemulihan dan jangka panjang.

Penjelasan tersebut wajib mencakup spektrum informasi yang komprehensif, meliputi urgensi dan tujuan prosedur, proyeksi manfaat klinis, identifikasi risiko serta efek samping yang mungkin timbul (baik dalam probabilitas tinggi maupun rendah), hingga penyajian alternatif terapeutik lainnya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi asimetri informasi yang dapat mencederai kualitas keputusan yang diambil. Secara konseptual, doktrin ini berakar pada pengakuan terhadap kedaulatan individu dalam menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*). Pasien memiliki hak konstitusional dan etis untuk mengambil keputusan secara independen, bebas dari segala bentuk koersi, manipulasi, maupun pengaruh yang tidak patut (*undue influence*). Keputusan

yang diambil haruslah berbasis pada pemahaman yang teriluminasi (*informed decision-making*), di mana individu secara rasional mampu mengonstruksi preferensi kesehatan mereka berdasarkan data medis yang objektif yang telah dipaparkan sebelumnya.

Dalam perspektif tenaga medis dan peneliti, *informed consent* bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah kewajiban etis (*deontological duty*) untuk mengedepankan transparansi dan kejujuran intelektual. Penyampaian informasi harus dilakukan dengan metodologi komunikasi yang aksesibel, memastikan bahwa subjek mampu mengasimilasi seluruh aspek material dari tindakan medis tersebut. Kegagalan dalam memberikan informasi yang jelas dan akurat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap standar profesi serta pengabaian terhadap prinsip integritas individu yang menjadi subjek tindakan.

Sebagai kesimpulan, *informed consent* merupakan kristalisasi dari prinsip otonomi yang menempati posisi sentral dalam struktur etika biomedis modern. Prinsip ini berfungsi sebagai proteksi terhadap integritas fisik dan psikis individu, sekaligus menggeser paradigma hubungan dokter-pasien dari model paternalistik menuju model kemitraan yang deliberatif. Dengan menghormati otonomi pasien, praktik medis tidak hanya berfokus pada efikasi klinis semata, tetapi juga pada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan yang bersifat absolut.

2. Dasar Hukum *Informed Consent*

Secara yuridis, *informed consent* di Indonesia memiliki landasan hukum yang sangat kuat, baik dalam tataran undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis serta perlindungan hak bagi pasien. Berikut adalah uraian komprehensif mengenai dasar hukum *informed consent* di Indonesia:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-undang ini merupakan regulasi terbaru (Omnibus Law) yang mengintegrasikan berbagai aturan kesehatan sebelumnya.

- 1) Pasal 273: Menegaskan bahwa setiap tindakan medis yang memiliki risiko tinggi harus mendapatkan persetujuan tertulis yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah menerima penjelasan yang cukup. Pasal 273 UU Kesehatan 2023 menetapkan standar ketat bagi tindakan medis yang diklasifikasikan sebagai "risiko tinggi". Legislasi ini mengamanatkan bahwa persetujuan harus dinyatakan dalam bentuk tertulis. Kewajiban ini muncul setelah pasien atau keluarga terdekat memperoleh "penjelasan yang cukup". Terminologi "cukup" di sini diinterpretasikan secara akademis

sebagai terpenuhinya unsur informatif yang mencakup diagnosis, prognosis, serta risiko inheren dari tindakan tersebut.

- 2) Pasal 277: Mengatur hak pasien untuk mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya, termasuk tindakan medis yang akan dilakukan, serta hak untuk memberikan persetujuan atau penolakan. Pasal 277 memperluas spektrum hak pasien dengan menegaskan bahwa setiap individu berhak atas transparansi data kesehatan pribadinya. Hal ini mencakup Hak Akses Informasi: Pasien berhak mengetahui hakikat dari tindakan medis yang diusulkan. Hak Determinasi: Pasien memiliki wewenang absolut untuk memberikan persetujuan (*consent*) atau menyatakan penolakan (*refusal*) terhadap rencana terapi tanpa adanya intimidasi atau konsekuensi hukum yang merugikan bagi posisi tawar pasien.

b. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 290/MENKES/PER/III/2008

Peraturan ini secara spesifik mengatur tata cara dan aspek teknis pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran.

- 1) Sifat Persetujuan: Menjelaskan bahwa persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan. Namun, tindakan medis yang mengandung risiko tinggi wajib diberikan secara tertulis dan ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Regulasi ini mengklasifikasikan persetujuan menjadi dua kategori berdasarkan derajat risiko tindakan:

Persetujuan Implisit atau Lisan: Untuk tindakan-tindakan medis rutin yang memiliki tingkat risiko minimal.

Persetujuan Eksplisit Tertulis: Wajib dilakukan untuk tindakan invasif, pembedahan, atau prosedur yang secara signifikan dapat mengubah fisiologis pasien. Penandatanganan dokumen ini oleh subjek yang kompeten secara hukum merupakan bukti autentik yang melindungi dokter dari tuduhan malpraktik di kemudian hari.

- 2) Kapasitas Subjek: Mengatur siapa saja yang berhak memberikan persetujuan (pasien dewasa yang kompeten) dan bagaimana prosedurnya jika pasien tidak kompeten (diwakili oleh wali atau keluarga terdekat). PMK ini juga mengelaborasi aspek kapasitas hukum (*legal capacity*). Pasien dewasa yang sadar dan kompeten secara mental adalah pemberi persetujuan utama. Namun, dalam kondisi di mana pasien tidak kompeten (misalnya di bawah umur, gangguan jiwa, atau dalam keadaan tidak sadar), regulasi ini mengatur hirarki perwakilan yang ketat, mulai dari wali sah hingga keluarga terdekat (istri/suami, orang tua, atau anak kandung), guna memastikan kepentingan terbaik pasien (*best interest of the patient*) tetap terjaga.

c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yaitu dalam konteks subjek penelitian, *informed consent* diatur untuk melindungi manusia yang menjadi objek penelitian. Persetujuan harus diberikan tanpa paksaan dan setelah subjek memahami segala aspek penelitian, termasuk dampak kesehatan yang mungkin timbul. Dalam dimensi penelitian dan pengembangan kesehatan, *informed consent* memiliki urgensi yang berbeda dibandingkan dengan praktik klinis rutin. PP No. 39 Tahun 1995 menjadi instrumen proteksi bagi manusia yang menjadi subjek penelitian. Prinsip-Prinsip Utama dalam Penelitian:

- 1) Voluntarisme: Persetujuan wajib diberikan tanpa adanya unsur paksaan (*coercion*) atau iming-iming material yang berlebihan.
- 2) Pemahaman Holistik: Subjek harus memahami secara menyeluruh desain penelitian, prosedur eksperimental, serta potensi dampak kesehatan jangka panjang yang mungkin belum terpetakan sepenuhnya. Hal ini krusial untuk mencegah eksploitasi terhadap subjek penelitian atas nama kemajuan ilmu pengetahuan.

d. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)

Secara etik, *informed consent* diatur dalam Pasal 13 KODEKI yang menyatakan bahwa setiap dokter harus menjaga pemeriksaan dan pengobatan sebagai rahasia pasien, namun tetap wajib memberikan informasi yang diperlukan agar pasien dapat memberikan persetujuan yang sah. Secara normatif, selain tunduk pada hukum positif (*ius constitutum*), profesi kedokteran juga terikat pada kode etik. Pasal 13 KODEKI menegaskan bahwa *informed consent* adalah kewajiban moral.

- 1) Keseimbangan Privasi dan Transparansi: Meskipun dokter wajib menjaga kerahasiaan medis pasien, kewajiban memberikan informasi terkait tindakan adalah pengecualian yang harus dipenuhi agar pasien dapat memberikan persetujuan yang sah secara etik.
- 2) Integritas Individu: KODEKI memandang *informed consent* sebagai bentuk pengakuan bahwa pasien adalah subjek moral yang memiliki hak atas integritas fisiknya, bukan sekadar entitas biologis yang diobati secara mekanistik.

3. Tujuan dan elemen substansi dalam *Informed Consent*

Tujuan fundamental *informed consent* tidak hanya pemenuhan kewajiban administratif dan legal formal akan tetapi merupakan sebuah instrumen etis untuk mentransformasi secara radikal posisi pasien dalam relasi terapeutik. Secara historis, interaksi medis kerap didominasi oleh paradigma paternalistik, di mana tenaga medis memegang otoritas absolut dengan asumsi dasar bahwa

"dokter paling mengetahui apa yang terbaik bagi pasien". Doktrin *informed consent* mendekonstruksi hierarki tradisional tersebut. Melalui pendekatan ini, pasien tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif yang sekadar menerima asuhan klinis, melainkan diangkat derajatnya sebagai subjek hukum dan entitas moral yang memiliki kedaulatan utuh atas tubuhnya sendiri. Secara umum fungsi *informed consent* adalah:

- a. Proteksi dari pasien dan subyek;
- b. Mencegah terjadinya penipuan atau paksaan;
- c. Menimbulkan rangsangan kepada profesi medis untuk mengadakan introspeksi terhadap diri sendiri;
- d. Promosi dari keputusan-keputusan rasional;
- e. Keterlibatan masyarakat (dalam memajukan prinsip otonomi sebagai suatu nilai social dan mengadakan pengawasan dalam penyelidikan biomedik.

Melalui penyediaan informasi yang transparan, objektif, dan komprehensif, pasien didorong secara sistematis untuk mengasumsikan peran proaktif dalam setiap fase pengambilan keputusan medis. Konsep ini melahirkan sebuah model komunikasi yang dikenal sebagai *shared decision-making* (SDM). Dalam kerangka SDM, terjadi sebuah konvergensi keahlian yang bersifat dua arah yaitu:

- a. Kepakaran Klinis: Tenaga medis menyumbangkan kepakarannya terkait ilmu kedokteran berbasis bukti (*evidence-based medicine*), pemahaman patofisiologi, analisis risiko, serta opsi terapeutik yang tersedia.
- b. Kepakaran Personal: Pasien membawa "kepakarannya" atas pengalaman hidupnya sendiri, yang mencakup nilai-nilai spiritual, batasan toleransi terhadap rasa sakit, kondisi sosio-ekonomi, serta orientasi kualitas hidup yang ingin dicapai.

Secara filosofis, mekanisme ini bertujuan secara tegas untuk mencegah terjadinya intervensi medis yang bersifat unilateral atau sepihak dari pihak penyedia layanan kesehatan. Tindakan unilateral dalam kedokteran kontemporer sebaik apa pun niat klinis di baliknya dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak asasi, karena mengabaikan fakta bahwa seluruh dampak fisik dan psikologis dari tindakan tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pasien. *Informed consent* berfungsi sebagai "katup pengaman" yang menetralkan potensi dominasi profesi (*medical coercion*), memastikan bahwa tidak ada pisau bedah yang digoreskan atau obat berisiko yang diinjeksikan tanpa adanya konsensus yang teriluminasi oleh pemahaman.

Pada muaranya, *informed consent* menghasilkan sebuah keputusan kolaboratif yang terlegitimasi secara moral dan hukum. Keputusan yang lahir dari proses ini bukanlah sekadar penerapan kaku dari algoritma medis atau pedoman

klinis standar, melainkan sebuah rencana perawatan (*care plan*) yang telah dikalibrasi secara khusus untuk merefleksikan nilai-nilai intrinsik, keyakinan, serta preferensi pribadi pasien. Dengan menghormati dan mengintegrasikan otonomi individu ke dalam tata laksana klinis, ilmu kedokteran tidak hanya menjalankan fungsinya dalam menyembuhkan penyakit, tetapi juga menunaikan kewajiban tertingginya dalam merawat martabat kemanusiaan.

Sebuah *informed consent* tidak dapat direduksi menjadi sekadar prosedur penandatanganan formulir administratif. Secara yuridis dan etis, proses ini dipandang valid dan memenuhi standar kualitas klinis yang paripurna apabila di dalamnya terdapat dialektika komunikasi yang mencakup lima elemen substansial berikut:

a. Karakteristik, Signifikansi, dan Anatomi Prosedur

Langkah pertama dalam diskursus persetujuan mensyaratkan adanya demistifikasi informasi medis. Dokter memiliki kewajiban etis untuk memaparkan penjelasan yang mendalam mengenai hakikat dan signifikansi dari tindakan yang diusulkan. Pemaparan ini harus mencakup:

- 1) Rasionalisasi Klinis: Mengapa prosedur tersebut mutlak atau perlu dilakukan berdasarkan diagnosis terkini.
- 2) Teknis Pelaksanaan: Penjelasan mengenai tahapan prosedur secara kronologis (pra-tindakan, pelaksanaan, dan pasca-tindakan), dikemas dalam bahasa yang dapat diakses oleh pemahaman awam tanpa menghilangkan esensi medisnya.
- 3) Durasi dan Pemulihan: Estimasi waktu pelaksanaan prosedur serta proyeksi masa konvalesensi (pemulihan) yang dibutuhkan hingga pasien dapat kembali pada fungsi fisiologis dan sosial yang optimal.

b. Komparasi Alternatif Terapeutik dan Skenario *Do-Nothing*

Penghormatan terhadap otonomi pasien tidak akan terwujud jika pasien hanya dihadapkan pada satu pilihan tunggal yang bersifat imperatif. Oleh karena itu, tenaga medis wajib menyajikan peta jalan terapeutik yang komprehensif:

- 1) Penyajian Opsi Substitusi: Memaparkan seluruh opsi klinis lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara *evidence-based medicine* (kedokteran berbasis bukti), baik berupa terapi konservatif, medikamentosa, maupun pendekatan bedah lainnya.
- 2) Proyeksi *Natural History of Disease*: Pasien harus diedukasi mengenai konsekuensi logis, risiko pemburukan patologis, dan ancaman terhadap kualitas hidup apabila ia menggunakan haknya untuk menolak seluruh intervensi medis yang ditawarkan (*no treatment option* atau *refusal of treatment*).

c. Analisis Risiko-Manfaat dan Pemaparan Ketidakpastian (*Uncertainty*)

Keputusan medis yang rasional membutuhkan kalkulasi yang objektif. Elemen ini menuntut kejujuran intelektual dari pihak penyedia layanan kesehatan dalam menyampaikan:

- 1) Proporsionalitas Risiko: Identifikasi komplikasi yang mungkin terjadi, mulai dari efek samping ringan yang lazim hingga risiko fatal yang jarang terjadi (probabilitas vs. signifikansi dampak).
- 2) Proyeksi Efikasi: Penjelasan mengenai tujuan akhir yang diharapkan (kuratif, paliatif, atau diagnostik) secara realistis tanpa memberikan garansi keberhasilan yang berlebihan (*over-promising*).
- 3) Variabilitas Biologis: Pengakuan terhadap batasan ilmu kedokteran, di mana respons biologis setiap individu bersifat unik (*idiosinkrasi*), sehingga selalu terdapat ruang bagi ketidakpastian klinis yang berada di luar kendali operator medis.

d. Verifikasi Pemahaman dan Asimilasi Kognitif Pasien

Informed consent adalah sebuah dialog, bukan monolog. Oleh karena itu, beban pembuktian pemahaman berada di pundak tenaga medis. Elemen ini mengharuskan adanya:

- 1) Evaluasi Subjektif dan Objektif: Dokter harus mengukur sejauh mana pasien telah mengasimilasi dan memproses informasi yang kompleks tersebut.
- 2) Metode *Teach-Back*: Sering kali diperlukan teknik komunikasi interaktif di mana pasien diminta untuk mengulang atau menjelaskan kembali pemahamannya menggunakan bahasanya sendiri. Hal ini krusial untuk memitigasi ilusi komunikasi, bias kognitif, hambatan literasi kesehatan, atau persepsi yang keliru sebelum keputusan final diambil.

e. Manifestasi Penerimaan Pasien Berbasis Voluntarisme

Elemen terakhir ini merupakan puncak atau muara dari seluruh rangkaian diskursus *informed consent*. Manifestasi persetujuan ini harus memenuhi syarat mutlak hukum perikatan dan bioetika:

- 1) Kebebasan Kehendak (*Voluntarism*): Konfirmasi akhir harus dipastikan keluar dari kesadaran penuh pasien, sama sekali terbebas dari unsur koersi (paksaan fisik/psikis), manipulasi informasi, maupun pengaruh yang tidak wajar (*undue influence*) dari pihak keluarga, institusi, atau dokter itu sendiri.
- 2) Otoritas Penuh: Pernyataan eksplisit bahwa pasien, atas kemauan mandiri dan evaluasi rasionalnya, menerima dan memberikan otoritas hukum kepada tim medis untuk melaksanakan rencana tindakan yang telah disepakati. Formulir persetujuan tertulis yang ditandatangani pada tahap ini

hanyalah alat bukti administratif dari kesepakatan moral dan intelektual yang telah tercapai.

C. Hak dan Kewajiban Pasien

Undang-Undang Kesehatan terbaru mengukuhkan keseimbangan hubungan hukum antara pasien dan fasilitas pelayanan kesehatan melalui penetapan hak dan kewajiban yang bersifat resiprokal. Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi martabat pasien, dan memastikan efektivitas pelayanan medis. Hak pasien merupakan instrumen perlindungan terhadap integritas fisik dan psikis individu. Berdasarkan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, hak-hak tersebut mencakup:

1. Hak atas Transparansi Informasi: Pasien berhak memperoleh data yang akurat mengenai kondisi patologis kesehatannya. Informasi ini menjadi landasan bagi pasien dalam memahami status medis mereka tanpa adanya hal-hal yang disembunyikan.
2. Hak atas Edukasi Pelayanan: Pasien berhak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai jenis pelayanan, risiko, dan manfaat dari prosedur yang akan dijalani. Hal ini berkaitan erat dengan proses *informed consent*.
3. Hak atas Pelayanan Standar dan Bermutu: Negara menjamin bahwa pelayanan yang diterima pasien harus memenuhi tiga kriteria utama: sesuai dengan kebutuhan medis pasien (*medical necessity*), mematuhi standar profesi tenaga medis, dan menjaga mutu pelayanan yang akuntabel.
4. Kedaulatan dalam Penolakan atau Persetujuan: Pasien memiliki hak mutlak untuk menyetujui atau menolak intervensi medis, kecuali dalam kondisi darurat tertentu seperti pencegahan wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB) di mana kepentingan publik berada di atas hak individu.
5. Aksesibilitas Rekam Medis: Pasien memiliki wewenang untuk mengakses konten informasi yang tercatat dalam rekam medis mereka, yang mencerminkan prinsip kepemilikan data pribadi.
6. Hak atas Opini Kedua (*Second Opinion*): Untuk menjamin objektivitas diagnosis, pasien berhak mencari pendapat dari tenaga medis lain yang memiliki kompetensi serupa.
7. Hak Konstitusional Lainnya: Perlindungan hukum tambahan yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan terkait lainnya di Indonesia.

Kewajiban pasien bukan sekadar formalitas, melainkan prasyarat bagi keberhasilan tindakan medis dan keselamatan pasien itu sendiri. Pasal 277 menguraikan kewajiban tersebut sebagai berikut:

1. Kejujuran dan Integritas Informasi: Pasien wajib memberikan data medis yang jujur, akurat, dan komprehensif (termasuk riwayat alergi, obat-obatan yang dikonsumsi, dan riwayat penyakit keluarga). Kegagalan dalam memberikan informasi yang jujur dapat menghambat ketepatan diagnosis dan membahayakan nyawa pasien.
2. Kepatuhan terhadap Protokol Medis: Pasien berkewajiban untuk mematuhi setiap instruksi, rencana pengobatan, dan nasihat yang diberikan oleh tenaga kesehatan demi mencapai hasil klinis yang optimal.
3. Ketaatan Administratif dan Tata Tertib: Setiap pasien wajib tunduk pada regulasi internal dan ketentuan yang berlaku di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) guna menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama.
4. Kewajiban Finansial: Sebagai bentuk imbal balik atas jasa profesional dan penggunaan fasilitas, pasien berkewajiban memberikan imbalan atau kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengaturan dalam Pasal 276 dan 277 UU No. 17 Tahun 2023 mencerminkan bahwa pelayanan kesehatan adalah sebuah kontrak terapeutik yang didasarkan pada rasa saling percaya (*mutual trust*). Pemenuhan hak pasien sangat bergantung pada pelaksanaan kewajiban pasien, begitu pula sebaliknya. Keseimbangan ini merupakan fondasi utama dalam meminimalkan sengketa medik dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara nasional.

D. Peran Perawat dalam Meningkatkan Kemandirian dan Kesehatan Keluarga

Kegagalan dalam memahami peran perawat sering kali bersumber dari ketidakjelasan batas wewenang. Secara yuridis, *informed consent* melibatkan dua domain profesional yang berbeda namun saling bersinggungan:

1. Domain Medis (Otoritas *Disclosure*)

Kewajiban untuk melakukan pengungkapan informasi material (*material risk disclosure*) yang mencakup diagnosis medis, sifat prosedur bedah/invasif, alternatif terapi, dan risiko komplikasi merupakan wewenang eksklusif dan tanggung jawab mutlak dari dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP). Perawat tidak memiliki kompetensi legal untuk memberikan penjelasan primer mengenai tindakan medis, dan segala bentuk delegasi wewenang edukasi primer dari dokter ke perawat dalam hal ini adalah cacat hukum.

2. Domain Keperawatan (Otoritas Verifikasi dan Asuhan)

Wewenang perawat terletak pada evaluasi respons biopsikososial pasien terhadap informasi yang telah diberikan oleh dokter. Perawat bertanggung jawab penuh atas penjelasan terkait *asuhan keperawatan* (misalnya: manajemen nyeri pasca-operasi, mobilisasi, atau perawatan luka), namun untuk tindakan *medis*,

peran perawat dibatasi pada ranah verifikasi, fasilitasi komunikasi, dan penilaian kelayakan kognitif.

Mengacu pada standar keperawatan internasional dan regulasi kesehatan nasional, peran perawat dalam pelaksanaan *informed consent* dapat didekonstruksi ke dalam empat fungsi esensial:

1. Perawat sebagai Penilai Kapasitas Kognitif dan Psikososial (*Cognitive & Psychosocial Assessor*)

Sebelum sebuah persetujuan dianggap valid, pasien harus memiliki kapasitas pengambilan keputusan (*decision-making capacity*). Perawat berada di posisi yang paling strategis untuk melakukan asesmen ini karena perawat berinteraksi dengan pasien secara kontinu selama 24 jam.

- a. Asesmen Klinis: Perawat wajib mengevaluasi apakah pasien berada di bawah pengaruh agen farmakologis (seperti analgesik opioid, sedatif, atau anestesi) yang dapat mengganggu kemampuan rasionalisasi mereka.
- b. Asesmen Psikologis: Tingkat ansietas (kecemasan) yang ekstrem atau nyeri akut (*severe pain*) dapat memicu pasien untuk menyetujui apa pun demi mengakhiri penderitaan mereka dengan cepat. Persetujuan dalam kondisi ini berpotensi mencederai asas voluntarisme. Perawat berkewajiban mengidentifikasi hambatan ini dan, jika perlu, menunda proses penandatanganan hingga kondisi psikologis pasien stabil.

2. Perawat sebagai Katalisator Komunikasi dan Edukator Sekunder

Pasca-penjelasan oleh DPJP, sering kali pasien mengalami disonansi kognitif akibat penggunaan jargon medis yang tidak dapat dipahami. Keengganan atau ketakutan pasien untuk bertanya langsung kepada dokter menciptakan celah komunikasi.

- a. Penerjemah Kontekstual: Perawat bertindak sebagai interpreter yang menyederhanakan terminologi medis ke dalam bahasa awam tanpa mendistorsi substansi informasi.
- b. Metode *Teach-Back*: Perawat mengimplementasikan teknik *teach-back* untuk memvalidasi pemahaman. Dengan menanyakan, "*Berdasarkan penjelasan dokter tadi, bisakah Bapak menjelaskan kembali kepada saya apa yang akan dilakukan di ruang operasi nanti?*", perawat dapat mendeteksi adanya miskonsepsi. Apabila ditemukan defisit pemahaman yang substansial, perawat dilarang memberikan informasi medis tambahan; sebaliknya, perawat wajib memfasilitasi komunikasi ulang antara pasien dan dokter.

3. Perawat sebagai Advokat dan Pelindung Hak (*Patient Advocate*)

Dalam fungsi advokasinya, perawat adalah representasi dari perisai moral pasien. Jika perawat mengidentifikasi bahwa persetujuan yang diberikan oleh

pasien bersifat semu (misalnya pasien menyetujui karena takut dokter akan marah jika ia menolak), perawat memiliki justifikasi etis dan profesional untuk mengintervensi. Dalam hal Hak Penolakan Perawat harus memastikan pasien menyadari hak prerogatifnya untuk menarik kembali persetujuan (*withdrawal of consent*) kapan saja sebelum prosedur dimulai, tanpa takut akan ancaman penghentian layanan kesehatan secara keseluruhan.

4. Perawat sebagai Saksi Legal yang Autentik (*Legal Witness*)

Tanda tangan perawat dalam formulir *informed consent* memiliki bobot hukum yang sangat spesifik dan kerap disalahtafsirkan. Eksistensi tanda tangan tersebut tidak mengindikasikan bahwa perawat memvalidasi kelengkapan atau kebenaran substansi medis yang disampaikan dokter. Secara yurisprudensi, kesaksian perawat memvalidasi tiga parameter hukum mutlak:

- a. Otentisitas Subjek: Konfirmasi bahwa penandatanganan benar-benar merupakan pasien yang bersangkutan atau wali hukum yang sah secara regulasi.
- b. Kapasitas Mental: Kesaksian bahwa pada saat pena digoreskan, pasien dalam keadaan sadar (kompos mentis) dan kompeten.
- c. Absensi Koersi: Pembuktian bahwa tidak terdapat paksaan, intimidasi, atau manipulasi dari pihak mana pun selama proses penandatanganan berlangsung.

Akan tetapi dalam implementasinya, perawat kerap dihadapkan pada dilema moral (*moral distress*) yang diakibatkan oleh benturan antara otonomi profesi dan hierarki struktural rumah sakit.

- a. Fenomena *Blanket Consent*: Adanya instruksi tidak etis dari atasan medis yang mendelegasikan tugas pemberian informasi spesifik kepada perawat karena keterbatasan waktu dokter.
- b. Hegemoni Profesi: Ketakutan perawat untuk menginterupsi atau menunda jadwal operasi ketika menyadari bahwa pasien belum sepenuhnya memahami prosedur, dikarenakan potensi teguran dari dokter bedah. Dalam mengatasi dinamika ini, institusi pelayanan kesehatan dituntut untuk menciptakan lingkungan *psychological safety* yang mendukung otonomi keperawatan, di mana perawat dapat menyuarakan kekhawatiran etis tanpa ancaman retribusi.

E. Penutup

Doktrin *informed consent* merupakan pilar fundamental dalam bioetika modern yang menuntut sinergitas interprofesional. Secara konklusif, kewajiban pemaparan intervensi medis mutlak merupakan ranah yurisdiksi kedokteran, sementara peran perawat berpusat pada orkestrasi pemenuhan hak asasi pasien.

Sebagai penilai kognitif, komunikator sekunder, saksi legal, dan advokat utama, perawat berfungsi sebagai benteng terakhir yang memastikan bahwa setiap persetujuan medis tidak hanya sah di mata hukum perikatan, tetapi juga terlegitimasi secara moral dan etis. Pengabaian terhadap peran strategis perawat dalam proses ini sama dengan mereduksi martabat kemanusiaan pasien di bawah dominasi sistem medis.

Referensi

- Ardinata, M. (2020). Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ham*, 11(2), 319-332.
- Barama, Mamesah. (2021). Aspek Hukum Malpraktik Kedokteran dalam Perundang-Undangan di Indonesia. *Lex Privatum Vol.IX/No.9/Ags.*
- Busro. (2018). Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) dalam Pelayanan Kesehatan. *Law & Justice Journal*.
- Chaeria, Busthami, Djanggih. (2020). Implikasi Kedudukan Tenaga Medis (Informed Consen) Terhadap Pertanggungjawaban Rumah Sakit. *Petitum*.
- Daeng, Azriyani, Tsai, Helen, Sarmalina, Saragih. (2023). Analisis Yuridis Kelalaian Medis (Malpraktik) yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan. *Journal Of Social Science Research*.
- Dewanto YP, Beta AG, Idha AW. (2021) Materi Penunjang Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal. Jilid II. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Herniwati, Rospita AS, Anggraeni EK. (2020). Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Hidayat, R. A. (2017). Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan yang Optimal. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 16(2), 127-134.
- Ikhsan, Christianto. (2022). Urgensi Informed Consent Sebagai Pencegahan Tindak Pidana oleh Dokter. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*.
- Irmawati M, Isna BI. (2022). Manajemen Informasi Kesehatan (Pengelolaan Rekam Medis). Edisi Revisi. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Kikhau, Fallo. (2023). Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dan Pasien. *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Kusnadi, K. (2023). Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) dalam Perspektif Hukum. *Journal Iuris Scientia*, 1(1), 36-44.

- Lestari. (2023). Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) Sebagai Bagian Perjanjian Terapeutik di Puskesmas Desa Sungai Jambat Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (Doctoral Dissertation, Universitas Jambi).
- Sidi, R. (2020). Kedudukan Informed Consent pada Pelayanan Pasien di Rumah Sakit. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 214-219.
- Siregar, R. A. (2020). *Bahan Ajar Hukum Kesehatan. Jilid I*. Jakarta: UKI Press. Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Widodo, S., & Kurniawati, I. (2018). "Patient Perceptions of Informed Consent: A Study in Surabaya General Hospital." *Indonesian Journal of Healthcare Studies*, 14(1), 67–79.

BAB V

ETIKA DALAM PRAKTEK DIGITAL DAN MEDIA SOSIAL

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi selama dua dekade terakhir telah menciptakan paradigma baru dalam sistem pelayanan kesehatan global. Transformasi digital ini tidak hanya mencakup penggunaan rekam medis elektronik dan telemedicine, tetapi juga meluas ke penggunaan aplikasi kesehatan berbasis mobile dan media sosial. Perubahan ini menuntut perawat sebagai tenaga kesehatan profesional untuk mampu beradaptasi secara efektif, aman, dan berlandaskan etika profesional.

Media sosial telah menjadi platform utama dalam komunikasi publik dan edukasi kesehatan. Melalui platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter, perawat memiliki peluang besar untuk menjangkau masyarakat secara luas dan cepat. Mereka dapat melakukan edukasi mengenai pencegahan penyakit, promosi gaya hidup sehat, serta meningkatkan literasi kesehatan masyarakat. Menurut O'Connor et al. (2023), penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi dalam keperawatan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat peran perawat sebagai agen perubahan di masyarakat.

Namun, penggunaan media sosial juga menimbulkan tantangan etika yang signifikan. Informasi yang disebarluaskan secara tidak tepat atau tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan misinformasi, yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan merusak reputasi profesi keperawatan. Selain itu, pelanggaran privasi dan kerahasiaan pasien menjadi isu utama, terutama ketika data atau cerita pasien dibagikan tanpa izin. Menurut Chan et al. (2021), dunia digital memperluas batas-batas etika keperawatan yang selama ini berfokus pada interaksi langsung, sehingga prinsip-prinsip seperti kerahasiaan, privasi, kejujuran, dan tanggung jawab harus diinterpretasikan ulang untuk konteks digital yang bersifat cepat, luas, dan permanen.

Lebih jauh lagi, batas antara kehidupan profesional dan pribadi menjadi semakin kabur di dunia digital. Perawat harus mampu menjaga profesionalisme dan integritas mereka di platform media sosial, menghindari konflik etika yang dapat timbul dari interaksi yang tidak tepat. World Health Organization (WHO, 2021)

menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan tentang etika digital dalam keperawatan untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, aman, dan sesuai dengan standar etika profesi.

Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam mengenai etika digital menjadi sangat penting. Perawat perlu mengembangkan kompetensi dalam mengelola informasi secara etis dan bertanggung jawab di media sosial dan platform digital lainnya. Strategi implementasinya meliputi pelatihan etika digital, penguatan kebijakan privasi dan kerahasiaan, serta pengawasan terhadap penggunaan media sosial dalam praktik keperawatan.

B. Konsep Dasar Etik Digital Dalam Keperawatan

Etika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai, norma, serta prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan individu maupun sosial. Dalam konteks keperawatan, etika memiliki peran fundamental sebagai landasan dalam pengambilan keputusan klinis, interaksi terapeutik dengan pasien, serta dalam menjaga profesionalisme tenaga kesehatan. Etika keperawatan tidak hanya berkaitan dengan tindakan klinis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan seperti penghormatan terhadap martabat manusia, empati, keadilan, serta tanggung jawab profesional terhadap pasien dan masyarakat (International Council of Nurses, 2021).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, praktik keperawatan mengalami transformasi menuju sistem pelayanan berbasis digital. Hal ini melahirkan konsep baru yang dikenal sebagai *etika digital* (*digital ethics*), yaitu seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku individu dalam penggunaan teknologi digital. Etika digital mencakup berbagai aspek penting seperti perlindungan data pribadi, keamanan informasi, transparansi penggunaan teknologi, serta tanggung jawab dalam penyebaran informasi di ruang digital (Gerke et al., 2020; Floridi et al., 2021).

Dalam praktik keperawatan modern, etika digital menjadi sangat relevan karena perawat kini tidak hanya berinteraksi secara langsung dengan pasien, tetapi juga melalui berbagai platform digital seperti rekam medis elektronik, telehealth, dan media sosial. Oleh karena itu, perawat dituntut untuk mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip etika tradisional dengan konteks digital yang lebih kompleks dan dinamis. Misalnya, dalam penggunaan rekam medis elektronik, perawat harus memastikan bahwa data pasien tersimpan dengan aman dan hanya diakses oleh pihak yang berwenang, guna mencegah pelanggaran kerahasiaan informasi kesehatan (Keskinbora, 2020).

Selain itu, komunikasi digital melalui media sosial juga menuntut adanya standar etika yang tinggi. Perawat harus mampu membedakan antara ranah profesional dan personal, serta menghindari penyebaran informasi yang dapat menimbulkan misinterpretasi atau merugikan pasien. Dalam hal ini, prinsip *professional boundary* menjadi sangat penting untuk menjaga integritas profesi (O'Connor et al., 2023).

Konsep etika digital dalam keperawatan juga tidak terlepas dari prinsip bioetika utama, yaitu *autonomy*, *beneficence*, *non-maleficence*, dan *justice*. Prinsip *autonomy* mengharuskan perawat menghormati hak pasien dalam menentukan pilihan terkait penggunaan teknologi kesehatan. Prinsip *beneficence* dan *non-maleficence* menekankan bahwa penggunaan teknologi harus memberikan manfaat dan tidak menimbulkan risiko bagi pasien. Sementara itu, prinsip *justice* menuntut adanya keadilan dalam akses terhadap layanan kesehatan digital (Yang & Jang, 2025).

Lebih lanjut, perkembangan teknologi digital juga memunculkan tantangan baru dalam bentuk *digital vulnerability*, yaitu kondisi di mana individu menjadi rentan terhadap penyalahgunaan data, pelanggaran privasi, serta paparan informasi yang tidak akurat. Dalam konteks ini, perawat memiliki peran penting sebagai *advocate* bagi pasien untuk melindungi hak-hak mereka dalam lingkungan digital (WHO, 2021).

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah konsep *digital footprint* atau jejak digital. Setiap aktivitas yang dilakukan di ruang digital akan terekam dan dapat diakses kembali di masa depan. Hal ini memiliki implikasi serius terhadap reputasi profesional perawat. Konten yang tidak sesuai dengan etika dapat merusak citra profesi serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan (Ventola, 2021).

Oleh karena itu, diperlukan kesadaran etis yang tinggi serta kemampuan literasi digital yang memadai bagi perawat dalam menjalankan praktiknya. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan kritis dalam mengevaluasi informasi serta memahami implikasi etis dari setiap tindakan yang dilakukan di ruang digital (Setiawan & Pratama, 2022).

Dengan demikian, etika dalam konteks digital merupakan bagian integral dari praktik keperawatan modern yang tidak dapat dipisahkan. Integrasi antara nilai-nilai etika klasik dengan tantangan teknologi digital menjadi kunci dalam menjaga profesionalisme, keamanan pasien, serta kualitas pelayanan kesehatan di era transformasi digital.

C. Pedoman Etika Penggunaan Media Sosial bagi Perawat

Pedoman etika dalam penggunaan media sosial merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa aktivitas digital perawat tetap berada dalam koridor profesional, aman, dan bertanggung jawab. Seiring meningkatnya penggunaan media sosial dalam praktik keperawatan, diperlukan standar yang jelas agar perawat tidak terjebak dalam pelanggaran etika yang dapat merugikan pasien maupun profesi (International Council of Nurses, 2021).

Salah satu pedoman utama adalah menjaga kerahasiaan pasien (*confidentiality*). Perawat dilarang membagikan informasi pasien dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui foto, video, atau cerita klinis yang dapat mengidentifikasi pasien. Bahkan informasi yang tampak anonim tetap berpotensi dikenali jika dikombinasikan dengan data lain (*re-identification risk*) (Gerke et al., 2020).

Selain itu, perawat harus menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam penggunaan media sosial. Misalnya, mempromosikan produk kesehatan tanpa dasar ilmiah atau tanpa transparansi dapat merusak integritas profesional. Perawat harus memastikan bahwa setiap informasi yang dibagikan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun komersial (O'Connor et al., 2023).

Penggunaan bahasa yang sopan dan profesional juga menjadi aspek penting dalam interaksi digital. Komunikasi di media sosial harus mencerminkan etika profesi, tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, maupun komentar yang merendahkan pihak lain. Hal ini penting untuk menjaga citra profesi keperawatan di mata publik (Ventola, 2021).

Selanjutnya, perawat wajib memastikan keakuratan informasi (*accuracy*) sebelum membagikannya. Informasi kesehatan yang tidak valid dapat menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan oleh masyarakat. Oleh karena itu, perawat harus mengacu pada sumber ilmiah terpercaya dan praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*) (Chan et al., 2021).

Pedoman lain yang tidak kalah penting adalah mematuhi kebijakan institusi dan regulasi yang berlaku. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan biasanya memiliki kebijakan terkait penggunaan media sosial oleh tenaga kesehatan. Kepatuhan terhadap kebijakan ini penting untuk menjaga keamanan informasi serta menghindari konsekuensi hukum (WHO, 2021).

Dengan menerapkan pedoman-pedoman tersebut, perawat dapat memanfaatkan media sosial secara optimal tanpa melanggar etika profesi. Pedoman ini juga berfungsi sebagai perlindungan bagi perawat dalam menghadapi risiko hukum dan sosial di era digital.

D. Prinsip-Prinsip Etika dalam Penggunaan Media Digital

Prinsip-prinsip etika dalam keperawatan tetap menjadi fondasi utama dalam setiap tindakan profesional, termasuk dalam penggunaan teknologi digital. Transformasi digital dalam pelayanan kesehatan tidak mengubah nilai dasar etika, tetapi justru memperluas kompleksitas penerapannya. Oleh karena itu, perawat dituntut untuk mampu mengadaptasi prinsip-prinsip etika klasik ke dalam konteks digital yang dinamis, cepat, dan memiliki jangkauan luas (Bayram et al., 2026).

Dalam praktik keperawatan digital, penerapan prinsip etika menjadi semakin krusial karena interaksi tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui media elektronik seperti rekam medis digital, telehealth, dan media sosial. Berikut adalah prinsip-prinsip utama yang harus dijunjung tinggi:

1. Kerahasiaan (Confidentiality)

Kerahasiaan merupakan prinsip fundamental dalam praktik keperawatan yang menuntut perawat untuk menjaga seluruh informasi pasien dari akses yang tidak sah. Dalam konteks digital, tantangan terhadap kerahasiaan semakin meningkat seiring dengan penggunaan sistem informasi kesehatan berbasis elektronik.

Data pasien yang tersimpan dalam sistem digital memiliki risiko kebocoran akibat serangan siber, kesalahan sistem, maupun kelalaian pengguna. Oleh karena itu, perawat harus memahami pentingnya penggunaan sistem keamanan seperti *password protection*, enkripsi data, serta pembatasan akses berdasarkan kewenangan (Gerke et al., 2020).

Pelanggaran terhadap kerahasiaan tidak hanya berdampak pada kerugian pasien secara psikologis dan sosial, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius sesuai dengan regulasi perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan dalam era digital merupakan bentuk tanggung jawab profesional sekaligus kewajiban hukum (Republik Indonesia, 2022).

2. Privasi (Privacy)

Privasi berkaitan dengan hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka, termasuk bagaimana data tersebut dikumpulkan, digunakan, dan disebarluaskan. Dalam praktik digital, privasi menjadi isu yang sangat sensitif karena data kesehatan termasuk dalam kategori data pribadi yang bersifat rahasia.

Perawat harus memastikan bahwa setiap penggunaan teknologi digital, seperti telemedicine atau aplikasi kesehatan, telah memenuhi standar perlindungan privasi. Hal ini mencakup persetujuan pasien (*informed consent*), transparansi penggunaan data, serta perlindungan terhadap akses pihak ketiga yang tidak berwenang (Floridi et al., 2021).

Pelanggaran privasi dapat mengurangi kepercayaan pasien terhadap tenaga kesehatan serta sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlindungan privasi harus menjadi prioritas utama dalam setiap praktik digital keperawatan.

3. Profesionalisme (Professionalism)

Profesionalisme dalam keperawatan mencerminkan sikap, perilaku, dan standar moral yang harus dijunjung tinggi oleh perawat dalam menjalankan tugasnya. Dalam era digital, profesionalisme tidak hanya tercermin dalam interaksi langsung, tetapi juga dalam aktivitas di media sosial dan platform digital lainnya.

Perawat harus mampu menjaga batas antara kehidupan profesional dan personal (*professional boundaries*), serta menghindari perilaku yang dapat merusak citra profesi. Misalnya, mengunggah konten yang tidak pantas, menyampaikan opini tanpa dasar ilmiah, atau berinteraksi dengan pasien secara tidak profesional melalui media sosial dapat menimbulkan dampak negatif (O'Connor et al., 2023).

Selain itu, perawat harus menyadari bahwa setiap tindakan dan komunikasi digital berpotensi diakses oleh publik dan dapat bertahan lama, sehingga penting untuk selalu berpikir matang sebelum memposting sesuatu. Pengelolaan yang bijak terhadap media sosial membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi keperawatan dan memastikan bahwa citra profesional tetap terjaga (International Council of Nurses [ICN], 2021).

Penggunaan Teknologi secara Tepat dan Bertanggung Jawab

Selain itu, profesionalisme juga mencakup kemampuan dalam menggunakan teknologi secara tepat guna, serta menjaga integritas dalam penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat.

4. Akuntabilitas (Accountability)

Dalam era digital, akuntabilitas menjadi semakin penting karena informasi yang disebarakan melalui media sosial, website, atau platform digital lainnya dapat dengan cepat menyebar dan memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Perawat harus memastikan bahwa setiap informasi kesehatan yang dibagikan telah melalui proses verifikasi dan didukung oleh bukti ilmiah (*evidence-based practice*). Penyebaran data yang tidak akurat, menyesatkan, atau tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan kesalahan pengambilan keputusan oleh masyarakat, merugikan pasien, dan merusak kredibilitas profesi keperawatan secara umum (Yang & Jang, 2025).

Selain itu, perawat harus menyadari bahwa setiap konten digital yang mereka unggah atau bagikan harus mencerminkan integritas profesional. Mereka

harus mampu mempertanggungjawabkan sumber dan isi informasi tersebut, serta menghindari penyebaran berita palsu atau klaim yang tidak terbukti secara ilmiah. Tindakan ini mendukung kepercayaan publik terhadap profesi keperawatan dan memastikan bahwa peran mereka sebagai penyedia informasi terpercaya tetap terjaga.

Akuntabilitas dalam Penggunaan Teknologi dan Dokumentasi Digital

Penggunaan teknologi seperti sistem rekam medis elektronik (Electronic Medical Records/EMR) juga memerlukan tingkat akuntabilitas yang tinggi. Perawat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua data dan catatan medis yang dibuat dan diakses bersifat akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumentasi yang tepat dan dapat ditelusuri penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan klinis. Selain itu, data digital harus dilindungi dari akses tidak sah sesuai dengan regulasi privasi dan keamanan data (Health Insurance Portability and Accountability Act/HIPAA, 2020).

Pengelolaan data yang bertanggung jawab tidak hanya mendukung pengambilan keputusan klinis yang tepat, tetapi juga melindungi hak pasien dan menjaga kepercayaan terhadap sistem layanan kesehatan. Perawat harus memahami prosedur keamanan data dan mengikuti kebijakan institusi dalam pengelolaan rekam medis elektronik.

5. Kejujuran (Veracity)

Kejujuran merupakan prinsip etika fundamental dalam keperawatan yang menekankan pentingnya penyampaian informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan antara perawat dan pasien, serta menjaga integritas profesi keperawatan secara keseluruhan.

Peran Kejujuran dalam Penyampaian Informasi

Dalam era digital, di mana berbagai informasi kesehatan dapat diakses dan disebarluaskan dengan cepat melalui media sosial, website, dan platform digital lainnya, prinsip kejujuran menjadi semakin penting dan menantang. Perawat memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada pasien maupun masyarakat bersifat valid, berdasarkan bukti ilmiah, dan tidak menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman.

Penyebaran informasi yang tidak benar, hoaks kesehatan, atau klaim yang tidak berbasis bukti dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat, termasuk penanganan yang salah, pengobatan yang tidak tepat, dan hilangnya kepercayaan terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, perawat

harus melakukan verifikasi terhadap sumber informasi, menghindari penyebaran berita palsu, dan selalu mengutamakan prinsip kejujuran dalam setiap komunikasi digital maupun langsung (Chan et al., 2021).

Kejujuran dan Hubungan Terapeutik

Kejujuran juga berperan penting dalam membangun dan memelihara hubungan terapeutik yang kokoh antara perawat dan pasien. Pasien cenderung merasa aman dan nyaman ketika mereka merasa mendapatkan informasi yang jujur dan transparan dari tenaga kesehatan. Tanpa kepercayaan ini, hubungan terapeutik tidak dapat berjalan secara efektif, dan proses perawatan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, kejujuran merupakan fondasi utama dalam membangun komunikasi yang efektif dan etis dalam praktik keperawatan.

Tantangan dan Strategi Meningkatkan Kejujuran di Era Digital

Tantangan utama dalam era digital adalah munculnya berbagai informasi yang tidak diverifikasi dan terkadang menyesatkan. Perawat harus mampu memilah informasi yang benar dan menyampaikan secara jujur tanpa menimbulkan kekhawatiran yang tidak perlu atau menyebarkan ketidakpastian. Pelatihan literasi digital dan etika komunikasi digital menjadi penting untuk meningkatkan kemampuan perawat dalam menyampaikan informasi yang benar dan bertanggung jawab.

Selain itu, pengembangan standar operasional prosedur (SOP) dan pedoman etika dalam penggunaan media digital dapat membantu perawat menjaga kejujuran dan integritas dalam setiap aktivitas komunikasi online.

E. Peran perawat Dalam Penerapan Etika Digital dan Media Sosial

Perkembangan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan telah memperluas peran perawat tidak hanya sebagai pemberi asuhan langsung, tetapi juga sebagai aktor penting dalam pengelolaan informasi dan komunikasi kesehatan di ruang digital. Dalam konteks ini, perawat dituntut untuk mampu menerapkan prinsip-prinsip etika secara konsisten dalam setiap aktivitas digital, baik dalam penggunaan rekam medis elektronik, telemedicine, maupun media sosial. Peran ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan tetap aman, berkualitas, serta menghormati hak pasien (World Health Organization [WHO], 2021).

1. Perawat sebagai Pengelola Data Pasien (Data Manager)

Perawat memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola data kesehatan pasien, terutama dalam sistem digital seperti rekam medis elektronik. Dalam menjalankan peran ini, perawat wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data pasien dengan menerapkan prinsip *confidentiality* dan *data protection*.

Pengelolaan data pasien harus dilakukan sesuai dengan standar keamanan informasi, seperti penggunaan kata sandi, enkripsi data, serta pembatasan akses hanya kepada pihak yang berwenang. Hal ini penting untuk mencegah kebocoran data dan penyalahgunaan informasi kesehatan yang bersifat sensitif (Gerke et al., 2020).

Di Indonesia, tanggung jawab ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur bahwa setiap tenaga kesehatan wajib menjaga kerahasiaan data pribadi pasien serta memperoleh persetujuan sebelum melakukan pengolahan data. Dengan demikian, perawat berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan data pasien di era digital.

2. Perawat sebagai Edukator Kesehatan (Health Educator)

Dalam era digital, perawat memiliki peran strategis sebagai edukator kesehatan yang memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi kesehatan kepada masyarakat. Perawat dapat menggunakan media seperti Instagram, TikTok, atau webinar untuk memberikan edukasi mengenai pencegahan penyakit, gaya hidup sehat, serta manajemen penyakit kronis.

Namun, dalam menjalankan peran ini, perawat harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan bersifat akurat, berbasis bukti (*evidence-based*), dan tidak menyesatkan. Penyebaran informasi yang tidak valid dapat menimbulkan misinformasi yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat (Chan et al., 2021).

Selain itu, perawat juga harus mempertimbangkan aspek budaya dan bahasa agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Peran ini menunjukkan bahwa perawat tidak hanya berkontribusi dalam pelayanan kuratif, tetapi juga dalam upaya promotif dan preventif melalui media digital (O'Connor et al., 2023).

3. Perawat sebagai Advokat Pasien (Patient Advocate)

Perawat memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak pasien, termasuk dalam konteks digital. Peran advokasi ini mencakup memastikan bahwa pasien memahami penggunaan teknologi dalam pelayanan kesehatan, seperti telemedicine, serta risiko yang mungkin timbul, termasuk kebocoran data dan penyalahgunaan informasi.

Perawat juga harus memastikan bahwa pasien memberikan persetujuan yang jelas (*informed consent*) sebelum data mereka digunakan atau dibagikan dalam sistem digital. Hal ini berkaitan dengan prinsip otonomi pasien yang

menekankan hak individu dalam menentukan keputusan terkait kesehatannya (International Council of Nurses [ICN], 2021).

Selain itu, perawat dapat berperan dalam melaporkan pelanggaran etika atau kebocoran data yang merugikan pasien, serta membantu pasien dalam memperjuangkan hak mereka. Dengan demikian, perawat berfungsi sebagai pelindung pasien dalam menghadapi kompleksitas sistem kesehatan digital.

4. Perawat sebagai Pengambil Keputusan Etis (Ethical Decision Maker)

Dalam praktik digital, perawat sering dihadapkan pada situasi yang memerlukan pengambilan keputusan etis, terutama ketika menghadapi dilema yang tidak memiliki jawaban yang jelas. Misalnya, apakah perawat boleh merespons pertanyaan pasien melalui media sosial, atau bagaimana menyikapi informasi kesehatan yang viral tetapi belum terverifikasi.

Dalam situasi tersebut, perawat harus mampu menggunakan *ethical reasoning* dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip etika seperti *beneficence* (memberikan manfaat), *non-maleficence* (tidak merugikan), *autonomy* (menghormati pilihan pasien), dan *justice* (keadilan) (Floridi et al., 2021).

Kemampuan dalam mengambil keputusan etis sangat penting untuk menjaga profesionalisme serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi keperawatan. Oleh karena itu, perawat perlu terus meningkatkan kompetensi dalam etika digital melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.

F. Integrasi Prinsip Etika dalam Praktik Digital

Penerapan prinsip-prinsip etika dalam praktik keperawatan digital tidak dapat dilakukan secara parsial atau terpisah, melainkan harus terintegrasi secara menyeluruh dalam setiap aspek pelayanan kesehatan. Transformasi digital telah mengubah cara perawat berinteraksi dengan pasien, mengelola data, serta mengambil keputusan klinis. Oleh karena itu, integrasi etika menjadi elemen kunci untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi tetap sejalan dengan nilai-nilai profesional keperawatan (World Health Organization [WHO], 2021).

Salah satu aspek utama dalam integrasi etika digital adalah penguatan kesadaran etis (*ethical awareness*) pada perawat. Kesadaran etis merupakan kemampuan untuk mengenali situasi yang memiliki implikasi moral serta memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan di ruang digital. Dalam praktiknya, perawat harus mampu mengidentifikasi potensi pelanggaran etika, seperti risiko kebocoran data, penyebaran informasi yang tidak akurat, maupun interaksi yang melampaui batas profesional. Kemampuan ini menjadi penting karena lingkungan digital bersifat cepat, luas, dan memiliki dampak jangka panjang melalui jejak digital (*digital footprint*) (Floridi et al., 2021).

Selain kesadaran etis, integrasi etika digital juga menuntut adanya kompetensi literasi digital yang memadai. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat dan aplikasi, tetapi juga kemampuan kritis dalam mengevaluasi informasi serta memahami implikasi etis dari penggunaan teknologi. Perawat harus mampu membedakan informasi yang valid dan tidak valid, serta memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada pasien maupun masyarakat telah melalui proses verifikasi ilmiah (Setiawan & Pratama, 2022). Dengan demikian, literasi digital menjadi fondasi dalam mendukung praktik keperawatan yang aman dan berbasis bukti (*evidence-based practice*).

Integrasi prinsip etika juga harus diwujudkan dalam penerapan prinsip-prinsip bioetika, yaitu autonomy, beneficence, non-maleficence, dan justice, dalam konteks digital. Prinsip autonomy menuntut perawat untuk menghormati hak pasien dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan teknologi kesehatan, termasuk persetujuan penggunaan data (*informed consent*). Prinsip beneficence dan non-maleficence mengharuskan perawat untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi memberikan manfaat dan tidak menimbulkan risiko bagi pasien. Sementara itu, prinsip justice menekankan pentingnya keadilan dalam akses terhadap layanan kesehatan digital (International Council of Nurses [ICN], 2021).

Selain peran individu perawat, organisasi pelayanan kesehatan juga memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung integrasi etika digital. Institusi harus menyediakan kebijakan yang jelas dan komprehensif terkait penggunaan teknologi dan media sosial oleh tenaga kesehatan. Kebijakan ini mencakup pedoman perlindungan data, standar komunikasi digital, serta prosedur penanganan pelanggaran etika. Tanpa adanya regulasi yang jelas, penerapan etika digital akan sulit dilakukan secara konsisten (Gerke et al., 2020).

Lebih lanjut, organisasi perlu menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan terkait etika digital dan literasi teknologi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi perawat dalam menghadapi perkembangan teknologi yang terus berubah. Program pelatihan dapat mencakup keamanan data, etika komunikasi digital, serta penggunaan sistem informasi kesehatan secara aman dan efektif (WHO, 2021).

Selain itu, integrasi etika digital juga memerlukan dukungan sistem teknologi yang aman dan andal. Sistem informasi kesehatan harus dirancang dengan memperhatikan aspek keamanan, seperti enkripsi data, autentikasi pengguna, serta pembatasan akses berdasarkan kewenangan. Hal ini penting untuk mencegah kebocoran data dan menjaga kepercayaan pasien terhadap sistem pelayanan kesehatan digital (Gerke et al., 2020).

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan etika digital. Institusi perlu melakukan audit secara berkala untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi telah sesuai dengan standar etika dan regulasi yang berlaku. Pengawasan ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi potensi risiko serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, integrasi prinsip etika dalam praktik digital merupakan tanggung jawab bersama antara individu perawat dan organisasi pelayanan kesehatan. Pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa teknologi digital digunakan secara aman, profesional, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Integrasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi keperawatan di era digital.

G. Pemanfaatan Media Sosial dalam Keperawatan

Media sosial telah berkembang menjadi salah satu instrumen utama dalam transformasi digital pelayanan kesehatan. Dalam praktik keperawatan modern, media sosial tidak lagi sekadar sarana komunikasi, tetapi telah menjadi platform strategis dalam mendukung upaya promotif, preventif, edukatif, hingga pengembangan profesional. Pemanfaatan media sosial memungkinkan perawat untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas, cepat, dan efisien dibandingkan metode konvensional, sehingga berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Chan et al., 2021).

Dalam aspek promotif, media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi terkait gaya hidup sehat. Perawat dapat membagikan konten edukatif mengenai pola makan seimbang, pentingnya aktivitas fisik, manajemen stres, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Penyampaian informasi melalui media sosial memiliki keunggulan dalam bentuk visualisasi yang menarik, seperti infografis, video pendek, dan animasi, sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini mendukung peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan secara mandiri (O'Connor et al., 2023).

Sementara itu, dalam aspek preventif, media sosial berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyakit. Perawat dapat memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan informasi mengenai imunisasi, deteksi dini penyakit kronis, pencegahan penyakit menular, serta edukasi terkait faktor risiko kesehatan. Kampanye kesehatan berbasis media sosial terbukti efektif dalam menjangkau kelompok masyarakat yang sulit dijangkau melalui metode tradisional, sehingga berkontribusi dalam menurunkan angka kejadian penyakit (World Health Organization [WHO], 2021).

Selain itu, media sosial juga memiliki peran signifikan dalam meningkatkan literasi kesehatan (*health literacy*) masyarakat. Literasi kesehatan merupakan kemampuan individu dalam memahami informasi kesehatan dan menggunakannya untuk mengambil keputusan yang tepat. Di era digital, masyarakat sering terpapar berbagai informasi kesehatan yang belum tentu valid, sehingga peran perawat sebagai sumber informasi terpercaya menjadi sangat penting. Perawat harus mampu menyajikan informasi yang akurat, berbasis bukti, dan mudah dipahami agar masyarakat tidak terjebak dalam misinformasi atau hoaks kesehatan (Chan et al., 2021).

Dalam konteks profesional, media sosial juga berfungsi sebagai sarana pengembangan kompetensi perawat. Melalui platform digital, perawat dapat mengikuti webinar, pelatihan daring, serta diskusi ilmiah dengan tenaga kesehatan dari berbagai negara. Hal ini memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang dapat meningkatkan kualitas praktik keperawatan. Selain itu, media sosial juga mendukung kolaborasi interprofesional yang menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan modern (Ventola, 2021).

Lebih lanjut, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai platform untuk diseminasi ilmu pengetahuan dan praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*). Perawat dapat berbagi hasil penelitian, pengalaman klinis, serta inovasi dalam praktik keperawatan kepada komunitas profesional maupun masyarakat luas. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga memperkuat peran perawat sebagai agen perubahan dalam sistem kesehatan (O'Connor et al., 2023).

Namun demikian, pemanfaatan media sosial dalam keperawatan juga menghadirkan berbagai tantangan dan risiko yang perlu dikelola dengan baik. Salah satu risiko utama adalah penyebaran informasi yang tidak akurat atau tidak berbasis bukti, yang dapat menimbulkan misinformasi dan membahayakan masyarakat. Selain itu, pelanggaran privasi dan kerahasiaan pasien menjadi isu yang sangat krusial, terutama ketika perawat membagikan informasi klinis tanpa persetujuan yang jelas (Gerke et al., 2020).

Perawat juga harus berhati-hati dalam menjaga profesionalisme di ruang digital, termasuk dalam membatasi interaksi dengan pasien di media sosial serta menghindari konflik kepentingan. Konten yang dibagikan harus mencerminkan integritas profesional dan tidak merusak citra profesi keperawatan. Hal ini penting karena setiap aktivitas digital akan meninggalkan jejak digital (*digital footprint*) yang dapat memengaruhi reputasi perawat dalam jangka panjang (Ventola, 2021).

Oleh karena itu, pemanfaatan media sosial dalam keperawatan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan aspek etika, regulasi, serta tanggung jawab

profesional. Perawat perlu memiliki kemampuan literasi digital yang baik, termasuk dalam menyaring informasi, mengevaluasi sumber, serta memahami implikasi etis dari setiap tindakan yang dilakukan di ruang digital (Setiawan & Pratama, 2022).

Dengan demikian, media sosial merupakan alat yang sangat potensial dalam mendukung praktik keperawatan modern, khususnya dalam aspek promotif, preventif, edukatif, dan pengembangan profesional. Namun, pemanfaatannya harus diimbangi dengan kesadaran etika yang tinggi, kompetensi digital yang memadai, serta komitmen terhadap nilai-nilai profesional agar manfaat yang diperoleh dapat maksimal tanpa menimbulkan risiko yang merugikan.

H. Risiko dan Tantangan Etika di Era Digital

Meskipun teknologi digital dan media sosial memberikan berbagai manfaat dalam praktik keperawatan, penggunaannya juga menghadirkan sejumlah risiko dan tantangan etika yang kompleks. Risiko ini tidak hanya berdampak pada individu perawat, tetapi juga pada pasien, institusi pelayanan kesehatan, serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi keperawatan (Ahmed et al., 2020).

Salah satu risiko utama adalah pelanggaran privasi dan kerahasiaan pasien. Dalam era digital, data kesehatan pasien tersimpan dalam sistem elektronik yang rentan terhadap akses tidak sah, baik akibat kesalahan manusia maupun serangan siber. Kurangnya kesadaran etika dan pemahaman tentang keamanan data dapat meningkatkan risiko kebocoran informasi yang bersifat sensitif (Gerke et al., 2020).

Risiko lainnya adalah penyebaran informasi kesehatan yang tidak akurat atau tidak berbasis bukti. Media sosial memungkinkan siapa saja untuk menyebarkan informasi tanpa proses verifikasi yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan misinformasi dan disinformasi yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Perawat sebagai tenaga profesional memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan telah melalui proses validasi ilmiah (Chan et al., 2021).

Selain itu, terdapat tantangan berupa kaburnya batas antara hubungan profesional dan personal. Interaksi antara perawat dan pasien melalui media sosial dapat menimbulkan konflik etika apabila tidak dikelola dengan baik. Misalnya, menerima permintaan pertemanan dari pasien atau berkomunikasi di luar konteks profesional dapat mengganggu hubungan terapeutik dan menimbulkan bias (O'Connor et al., 2023).

Konsep jejak digital (digital footprint) juga menjadi tantangan tersendiri. Setiap aktivitas yang dilakukan di media digital akan terekam dan dapat diakses kembali di masa depan. Konten yang tidak sesuai dengan etika dapat merusak reputasi

profesional perawat serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi keperawatan (Ventola, 2021).

Selain itu, fenomena cyberbullying juga menjadi risiko yang semakin meningkat di era digital. Tenaga kesehatan dapat menjadi sasaran kritik, intimidasi, atau bahkan pelecehan di media sosial. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan mental perawat serta kinerja profesional mereka (Ahmed et al., 2020).

Faktor utama yang menyebabkan berbagai pelanggaran etika tersebut adalah rendahnya literasi digital dan kurangnya pemahaman mengenai etika profesional dalam konteks digital. Banyak tenaga kesehatan yang belum mendapatkan pelatihan khusus terkait penggunaan teknologi secara etis dan aman (Setiawan & Pratama, 2022).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan berbagai upaya strategis, antara lain:

Peningkatan literasi digital tenaga Kesehatan, Pelatihan etika digital secara berkelanjutan, Penguatan regulasi dan kebijakan institusi, Pengawasan penggunaan media sosial oleh tenaga kesehatan dan Penguatan budaya profesionalisme dalam organisasi. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan risiko dan tantangan etika dalam praktik digital dapat diminimalkan, sehingga teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip etika keperawatan.

I. Aspek Hukum dalam Praktik Digital Keperawatan

Penggunaan teknologi digital dalam praktik keperawatan tidak hanya memiliki implikasi etika, tetapi juga konsekuensi hukum yang signifikan. Dalam era digital, data kesehatan pasien dikategorikan sebagai data pribadi yang bersifat sensitif dan dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, setiap tenaga kesehatan, termasuk perawat, wajib memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku (World Health Organization, 2021).

Salah satu aspek hukum utama adalah perlindungan data pribadi. Data kesehatan pasien harus disimpan, diakses, dan digunakan sesuai dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan. Pelanggaran terhadap perlindungan data ini dapat berujung pada sanksi administratif, perdata, maupun pidana, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi .

Selain itu, penggunaan sistem digital seperti rekam medis elektronik dan telemedicine juga menuntut adanya keamanan sistem informasi (*information security*). Perawat harus memahami prosedur penggunaan sistem secara benar, termasuk pengamanan akses, penggunaan kata sandi, serta pencegahan kebocoran data akibat kelalaian (Gerke et al., 2020).

Aspek hukum lainnya adalah tanggung jawab profesional (legal accountability). Setiap tindakan yang dilakukan dalam praktik digital, termasuk dokumentasi elektronik dan komunikasi daring, memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti. Oleh karena itu, perawat harus memastikan bahwa setiap dokumentasi dilakukan secara akurat, lengkap, dan sesuai standar (Nursalam, 2020).

Selain itu, perawat juga harus berhati-hati dalam penggunaan media sosial, karena konten yang dibagikan dapat menimbulkan implikasi hukum, seperti pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, atau penyebaran informasi yang menyesatkan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas digital memiliki konsekuensi hukum yang nyata dan tidak dapat diabaikan (Ventola, 2021).

Dengan memahami aspek hukum dalam praktik digital, perawat dapat melindungi diri, pasien, serta institusi dari potensi pelanggaran hukum. Kepatuhan terhadap regulasi merupakan bagian integral dari profesionalisme dalam praktik keperawatan modern.

J. Strategi Peningkatan Literasi Digital Perawat

Literasi digital merupakan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi secara efektif, kritis, dan etis. Dalam praktik keperawatan modern, literasi digital menjadi kompetensi esensial yang harus dimiliki oleh setiap perawat untuk menghadapi perkembangan teknologi kesehatan yang semakin pesat (O'Connor et al., 2023).

Salah satu strategi utama dalam meningkatkan literasi digital adalah melalui pendidikan berkelanjutan (*continuous education*). Perawat perlu mengikuti pelatihan, seminar, dan workshop yang berkaitan dengan teknologi kesehatan, keamanan data, serta etika digital. Pendidikan berkelanjutan memungkinkan perawat untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru (WHO, 2021).

Selain itu, pelatihan teknologi kesehatan juga menjadi penting, terutama dalam penggunaan sistem informasi kesehatan seperti rekam medis elektronik, telehealth, dan aplikasi kesehatan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis sekaligus kesadaran terhadap aspek etika dan keamanan (Setiawan & Pratama, 2022).

Strategi berikutnya adalah integrasi literasi digital dalam kurikulum pendidikan keperawatan. Mahasiswa keperawatan perlu dibekali dengan kompetensi digital sejak dini, sehingga siap menghadapi tantangan praktik di era digital. Kurikulum yang adaptif akan menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional (Bayram et al., 2026).

Selain itu, diperlukan penguatan kebijakan institusi yang mendukung penggunaan teknologi secara aman dan etis. Institusi pelayanan kesehatan harus menyediakan pedoman, sistem keamanan, serta mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan penerapan literasi digital secara optimal (WHO, 2021).

Dengan literasi digital yang baik, perawat tidak hanya mampu menggunakan teknologi secara efektif, tetapi juga dapat melindungi pasien, menjaga etika profesi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

K. Penutup

Etika dalam praktik digital merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga profesionalisme keperawatan di era modern. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pelayanan kesehatan, sehingga menuntut perawat untuk beradaptasi tanpa mengabaikan nilai-nilai etika yang menjadi dasar profesi (International Council of Nurses, 2021).

Pemanfaatan teknologi digital, termasuk media sosial, harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika seperti kerahasiaan, privasi, profesionalisme, akuntabilitas, dan kejujuran. Selain itu, perawat juga harus memahami aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi, serta memiliki literasi digital yang memadai untuk menghadapi berbagai tantangan di era digital.

Penerapan etika digital yang baik tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, tetapi juga berperan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi keperawatan. Kepercayaan ini merupakan modal utama dalam membangun hubungan terapeutik yang efektif antara perawat dan pasien (WHO, 2021).

Dengan demikian, integrasi antara etika, teknologi, dan profesionalisme menjadi kunci utama dalam mewujudkan praktik keperawatan yang aman, berkualitas, dan berorientasi pada keselamatan pasien di era transformasi digital.

Referensi

- Ahmed, W., Vidal-Alaball, J., Downing, J., & López Seguí, F. (2020). COVID-19 and the 5G conspiracy theory: Social network analysis of Twitter data. *Journal of Medical Internet Research*, 22(5), e19458. <https://doi.org/10.2196/19458>
- Bayram, A., Bal, B., Chiappinotto, S., & Palese, A. (2026). Digital ethics in nursing: A scoping review. *International Nursing Review*, 73(1), e70141.
- Chan, A. K. M., Nickson, C. P., Rudolph, J. W., Lee, A., & Joynt, G. M. (2021). Social media for rapid knowledge dissemination: Early experience from the COVID-19

- pandemic. *Medical Education*, 55(1), 137–143.
<https://doi.org/10.1111/medu.14338>
- Chan, Z. C. Y., Cheung, K., & Lee, K. K. (2021). Ethical considerations for social media use in nursing practice. *Nursing Ethics*, 28(4), 512–523.
<https://doi.org/10.1177/09697330211008887>
- Floridi, L., et al. (2021). The ethics of digital health: From principles to practice. *The Lancet Digital Health*, 3(6), e370–e371. [https://doi.org/10.1016/S2589-7500\(21\)00082-3](https://doi.org/10.1016/S2589-7500(21)00082-3)
- Floridi, L., Cowls, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., & Vayena, E. (2021). AI4People—An ethical framework for a good AI society. *Minds and Machines*, 31(1), 1–14. <https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5>
- Gerke, S., Minssen, T., & Cohen, G. (2020). Ethical and legal challenges of artificial intelligence-driven healthcare. *Nature Medicine*, 26(1), 47–55.
<https://doi.org/10.1038/s41591-019-0548-6>
- International Council of Nurses. (2021). *The ICN code of ethics for nurses*. <https://www.icn.ch>
- Keskinbora, K. H. (2019). *Medical ethics considerations on artificial intelligence*. *Journal of Clinical Neuroscience*, 64, 277–282. <https://doi.org/10.1016/j.jocn.2019.03>.
- Nursalam. (2020). *Manajemen keperawatan: Aplikasi dalam praktik keperawatan profesional* (Edisi ke-5). Salemba Medika.
- O'Connor, S., Zhang, M., Honey, M., Lee, J. J., & O'Donoghue, J. (2023). Social media in nursing and midwifery practice: Opportunities and challenges. *Journal of Nursing Management*, 31(3), 456–464. <https://doi.org/10.1111/jonm.13709>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
- Setiawan, D., & Pratama, A. (2022). Literasi digital tenaga kesehatan dalam menghadapi transformasi layanan kesehatan. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 25(2), 85–92.
<https://jki.ui.ac.id>
- Ventola, C. L. (2021). Social media and health care professionals: Benefits, risks, and best practices. *Pharmacy and Therapeutics*, 46(1), 38–44.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7807838/>

- World Health Organization. (2021a). *Global strategy on digital health 2020–2025*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240020924>
- World Health Organization. (2021b). *Ethics and governance of artificial intelligence for health*. <https://iris.who.int/handle/10665/341996>
- Yang, H. M., & Jang, Y. E. (2025). Ethics of nursing in the digital age: A contemporary perspective. *BMC Medical Ethics*, 26, 143. <https://doi.org/10.1186/s12910-025-01043-2>

BAB VI

KONFLIK ETIK DALAM PRAKTIK KLINIK

A. Pendahuluan

Etika profesi keperawatan merupakan fondasi utama praktik yang bermartabat karena keperawatan berakar pada kewajiban etis untuk menghormati martabat dan integritas individu (Haahr et al., 2020). Nilai profesional seperti menjaga kerahasiaan dan hak privasi pasien dinilai sangat penting oleh perawat klinik dan terkait dengan mutu asuhan yang aman dan etis (Poorchangizi et al., 2017). Penguatan nilai profesional dan empati terbukti meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan etis perawat dalam situasi klinik kompleks (Du et al., 2022). Sebagai profesi yang telah diatur oleh hukum dan kode etik, perawat tidak hanya memiliki kewajiban moral dan profesional, tetapi juga hak yang harus dilindungi oleh hukum. Landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam situasi darurat kesehatan masyarakat antara lain Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang terbaru membuat ketentuan yang lebih komprehensif mengenai sistem kesehatan nasional. Perlindungan hukum tenaga kesehatan, serta tanggung jawab profesi dalam menghadapi krisis kesehatan.

Konflik etik dalam keperawatan muncul dari dilema terkait rencana perawatan, benturan nilai dengan dokter atau keluarga, isu privasi pasien, dan kendala organisasi seperti standar dan beban kerja tinggi (Rainer et al., 2018). Perbedaan nilai antara perawat, pasien, keluarga, dan kebijakan rumah sakit, termasuk keterbatasan sumber daya, sering memicu dilema dan moral distress yang berdampak pada kesejahteraan perawat, kualitas perawatan, dan niat untuk meninggalkan profesi (Hou et al., 2021). Tinjauan menegaskan bahwa pendidikan etika yang terstruktur, metode aktif (diskusi kasus, simulasi, refleksi tertulis), dan pelatihan berkelanjutan dapat meningkatkan kompetensi etis dan ketangguhan moral, serta mencegah moral distress (Zhu et al., 2026). Implementasi pedoman etika yang jelas dan dukungan konsultasi etika menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan beretika (Koskenvuori et al., 2019).

Isu konflik etik menjadi lebih nyata pada dokumentasi keperawatan, di mana perawat menghadapi pertimbangan antara menghormati otonomi pasien dan tugas profesional untuk mencatat data secara lengkap dan akurat. Dalam situasi demikian, perawat kadang harus menyeimbangkan klaim privasi pasien dengan kebutuhan

dokumentasi yang bermanfaat untuk kesinambungan perawatan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek administratif pun dapat menjadi sumber dilema moral dalam praktik klinik.

Selain tantangan kasus klinik spesifik, konflik etik berdampak pada pengalaman moral perawat secara pribadi, termasuk munculnya moral distress, yaitu keadaan di mana perawat mengetahui tindakan etis yang tepat namun terhambat oleh faktor eksternal dalam melakukan tindakan tersebut. Moral distress yang berkepanjangan dapat memicu kelelahan profesional, penurunan kepuasan kerja, bahkan keluar dari profesi keperawatan jika tidak dikelola secara efektif.

Selain itu, pemahaman konflik etik menjadi relevan untuk institusi layanan kesehatan dalam mengembangkan budaya klinik yang mendukung keputusan etis. Lingkungan yang kondusif secara etis dapat membantu perawat mengidentifikasi konflik lebih awal, mengakses sumber daya dukungan etika, dan mengurangi tekanan moral yang berkepanjangan. Institusi perlu menyediakan mekanisme refleksi dan konsultasi etis sebagai bagian dari kualitas pelayanan klinik.

Peningkatan kompetensi etis juga diperkuat oleh literatur yang mengadvokasi pendekatan pluralistik atau "*moral ecology*", di mana etika tidak hanya dipandang sebagai prinsip abstrak tetapi juga terjalin dengan nilai individu, norma organisasi, dan tuntutan konteks sosial. Pendekatan semacam ini memperkaya strategi pengambilan keputusan perawat dan membantu menghadapi konflik etik yang kompleks dengan perspektif yang lebih luas. Karena itu, studi dan pemahaman konflik etik dalam keperawatan menjadi urgent untuk memperkuat kualitas asuhan klinik yang bermartabat, manusiawi, dan profesional. Konflik etik bukan sekadar fenomena yang tidak terhindarkan, tetapi juga kesempatan bagi perawat untuk berkembang secara moral dan memperkuat kontribusi profesionalnya dalam pelayanan kesehatan yang adil dan efektif.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan etika medis, khususnya prinsip otonomi pasien, adalah seringnya terjadi pelanggaran oleh tenaga kesehatan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Pelanggaran yang umum muncul adalah intervensi medis yang dilakukan perawat atau tenaga kesehatan lainnya tanpa persetujuan pasien terlebih dahulu. Situasi ini sering terjadi karena asumsi bahwa pasien menyerahkan kendali penuh atas proses pemulihan kepada penyedia layanan kesehatan, yang menunjukkan minimnya pemahaman terhadap pentingnya prinsip informed consent.

Kesenjangan antara standar etik dan praktik di lapangan juga menjadi masalah signifikan. Meskipun tenaga kesehatan berupaya bertindak profesional, implementasi kode etik tidak selalu konsisten. Dalam beberapa kasus, pasien yang sadar dan kompeten untuk mengambil keputusan tetap tidak menandatangani

formulir persetujuan tindakan medis, atau formulir tersebut ditandatangani pihak lain, bahkan ada yang tidak dilakukan sama sekali. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip otonomi pasien dan menimbulkan risiko hukum serta etis.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, institusi layanan kesehatan perlu memperkuat edukasi etika profesi bagi seluruh tenaga kesehatan, menerapkan prosedur operasional standar (SOP) yang ketat terkait izin tindakan medis, serta melakukan pengawasan internal secara konsisten. Peningkatan kualitas layanan yang berorientasi pada hak pasien tidak hanya mendukung prinsip otonomi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik dan profesionalisme institusi sebagai penyedia layanan kesehatan terpercaya.

B. Jenis Konflik Etik dalam Praktik Keperawatan

Dalam praktik keperawatan klinik, konflik etik merupakan fenomena nyata dan kompleks yang perlu dikenali serta dikelola secara sistematis. Konflik ini muncul ketika perawat menghadapi keputusan klinik yang melibatkan pertentangan antara prinsip moral, nilai pribadi, dan tuntutan profesional, sehingga menimbulkan ketegangan dalam pengambilan keputusan dan dapat mengancam kesejahteraan perawat maupun kualitas asuhan pasien (Liu et al., 2023). Secara konseptual, konflik etik ditandai oleh respons emosional, nilai yang tidak kompatibel, kepentingan yang saling bersaing, dan kewajiban yang ambigu di lingkungan kerja keperawatan (Aljabery et al., 2024).

Identifikasi berbagai jenis konflik etik dalam praktik klinik memiliki signifikansi yang strategis, tidak hanya untuk memahami kompleksitas situasi yang dihadapi perawat, tetapi juga untuk memperkuat kemampuan mereka dalam merespons secara etis dan profesional. Ketidakepekaan atau kurangnya pemahaman terhadap dinamika konflik etik dapat memperburuk konsekuensi psikologis maupun organisasional, termasuk meningkatnya moral distress, burnout, moral residue, serta erosi identitas profesional. Dampak tersebut secara langsung dapat menurunkan kepuasan kerja, sekaligus memengaruhi kualitas dan mutu asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien. (Čartolovni et al., 2021). Dengan demikian, kemampuan mengenali, membedakan, dan menginterpretasikan konflik etik menjadi landasan bagi keputusan klinik yang efektif dan hubungan terapeutik yang bermartabat antara perawat dan pasien (Rizkianti et al., 2025).

Dampak konflik etik tidak hanya dirasakan oleh perawat sebagai individu, tetapi juga oleh pasien dan tim kesehatan secara keseluruhan. Lingkungan kerja dengan iklim etika yang negatif dan kolaborasi antarprofesi yang buruk berkaitan dengan meningkatnya konflik dalam tim, komunikasi yang tidak harmonis, moral distress yang lebih tinggi, dan penurunan kinerja keperawatan serta kualitas

perawatan pasien (Pakkanen et al., 2022). Konflik yang tidak tertangani berkontribusi pada disfungsi tim, menurunkan kepercayaan pasien, serta mengganggu kerja sama profesional dalam tim multidisiplin (Hamric & Blackhall, 2007).

Keberadaan konflik etik mencerminkan kompleksitas peran perawat di tengah tuntutan sistem kesehatan yang terus berubah. Konflik sering muncul ketika nilai organisasi, kebijakan pelayanan, dan kebutuhan klinik tidak selaras, sehingga perawat harus melakukan “negosiasi moral” dalam menjalankan tugas (Haahr et al., 2020). Literatur menunjukkan bahwa konflik etik dan moral distress bukan hanya hambatan, tetapi juga dapat menjadi peluang untuk refleksi etis, penguatan moral resilience, perbaikan proses kerja, dan peningkatan kualitas pelayanan bila didukung oleh iklim etika yang positif, kolaborasi efektif, dan dukungan organisasi (Rushton, 2023).

1. Konflik antara Perawat dengan Pasien atau Keluarga Pasien

Konflik etik antara perawat dengan pasien atau keluarga merupakan fenomena kompleks dalam praktik keperawatan klinik. Konflik ini sering muncul ketika prinsip moral dan kewajiban profesional perawat berhadapan dengan otonomi, nilai, atau preferensi pasien yang berbeda, termasuk dalam konteks keputusan akhir hayat dan perawatan paliatif (Geng et al., 2024). Otonomi pasien sebagai hak untuk membuat keputusan terkait perawatan diri dapat menimbulkan dilema ketika perawat harus menyeimbangkan keselamatan pasien dengan penghormatan terhadap keputusan tersebut, terutama pada pasien lanjut usia dan pasien dengan harapan hidup terbatas (Frank et al., 2022). Dalam situasi ini, perawat tidak hanya berperan sebagai pemberi layanan, tetapi juga sebagai mediator dan advokat kesehatan yang menyampaikan informasi tentang risiko, manfaat, dan alternatif tindakan secara jelas, sekaligus berupaya melindungi martabat dan integritas pasien (Victorino et al., 2025). Hambatan komunikasi, perbedaan budaya, dan bahasa, serta rendahnya literasi kesehatan dapat memperumit hubungan terapeutik, meningkatkan risiko kesalahpahaman, konflik dengan pasien/keluarga, dan memunculkan dilema moral dalam praktik sehari-hari (Anzini et al., 2025).

Proses *informed consent* sering menjadi pusat konflik antara perawat, pasien, dan keluarga. Perawat berkewajiban menyampaikan informasi secara jelas dan objektif agar pasien dapat mengambil keputusan yang berpusat pada pasien dan benar-benar dipahami (Kwame & Petrucka, 2021). Namun dalam praktik, pasien dapat menolak prosedur atau tidak sepenuhnya memahami konsekuensi tindakan medis, sementara keluarga kadang meminta informasi disembunyikan dari pasien, sehingga menambah kompleksitas etik. Kondisi ini menimbulkan dilema moral bagi perawat yang harus menghormati otonomi pasien, menjaga

keselamatan klinik, dan tetap patuh pada standar profesional, di tengah keterbatasan waktu dan beban kerja tinggi yang diketahui berkontribusi terhadap distress moral dan kelelahan etik.

Penolakan pasien terhadap perawatan yang bersifat kritis menempatkan perawat pada konflik antara prinsip *beneficence* dan otonomi pasien. *Beneficence* menuntut perawat melakukan yang terbaik bagi pasien, sementara penghormatan otonomi mengharuskan menerima keputusan pasien meskipun berisiko memperburuk kondisi kesehatan. Berbagai studi menunjukkan bahwa situasi ketika perawat mengetahui tindakan yang dianggap paling tepat secara etik tetapi terhalang oleh keputusan pasien, keluarga, atau struktur organisasi berhubungan dengan munculnya moral distress, yang ditandai perasaan tidak berdaya, frustrasi, dan terpaksa berkompromi dengan nilai profesional (Usberg et al., 2021). Dalam konteks ini, penguatan keterampilan komunikasi empatik, pelibatan pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan, serta dukungan organisasi dan kolaborasi interprofesional dipandang penting untuk mengurangi konflik etik dan moral distress pada perawat.

Isu privasi dan kerahasiaan pasien juga sering menimbulkan konflik. Informasi medis pasien harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan standar etika, tetapi kebutuhan tim medis untuk mengakses data demi kelancaran perawatan dapat bertentangan dengan keinginan pasien. Perawat berperan penting dalam menegosiasikan keseimbangan ini, memastikan data yang sensitif hanya dibagikan kepada pihak yang relevan dan dengan persetujuan pasien, sambil tetap menjaga kesinambungan perawatan yang berkualitas. Hambatan ini menjadi semakin kompleks ketika keluarga pasien menuntut akses ke informasi, sehingga perawat harus mampu menjelaskan batas-batas hukum dan etika dengan penuh empati.

Komunikasi yang buruk sering memperburuk konflik etik antara perawat dan pasien atau keluarganya. Ketidaktepatan informasi, miskonsepsi tentang prosedur, atau penggunaan istilah medis yang tidak dipahami pasien dapat memunculkan kebingungan dan resistensi terhadap perawatan. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif, termasuk teknik penjelasan sederhana dan penggunaan bahasa yang sesuai konteks budaya pasien, dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap rekomendasi klinis. Dengan demikian, komunikasi menjadi alat penting untuk mereduksi potensi konflik dan mendukung pengalaman pasien yang lebih manusiawi dan aman.

Perbedaan budaya dan nilai-nilai individu juga menjadi faktor utama munculnya konflik. Dalam beberapa budaya, keluarga memiliki peran dominan

dalam pengambilan keputusan perawatan, sementara pasien memiliki tingkat otonomi yang berbeda-beda. Ketidaksesuaian antara norma budaya pasien dan praktik keperawatan dapat menimbulkan ketegangan, terutama dalam kasus perawatan akhir hidup atau prosedur invasif. Perawat perlu memiliki sensitivitas budaya yang tinggi, mampu mendengarkan perspektif keluarga dan pasien, serta menyesuaikan strategi komunikasi untuk membangun kesepahaman yang menghormati nilai semua pihak.

Literasi kesehatan pasien juga mempengaruhi frekuensi konflik antara perawat dan pasien. Pasien yang memiliki pemahaman terbatas mengenai terminologi medis dan risiko prosedur mungkin menolak tindakan tertentu tanpa alasan yang jelas bagi tenaga medis. Dalam kondisi seperti ini, perawat berperan penting sebagai edukator yang menjembatani kesenjangan pengetahuan, menggunakan penjelasan yang jelas dan visualisasi bila perlu, sehingga pasien dapat membuat keputusan yang terinformasi. Strategi ini mendukung pengambilan keputusan yang etis dan mengurangi ketegangan antara pasien dan perawat.

Tekanan kerja dan beban tanggung jawab perawat juga berkontribusi terhadap konflik etik. Lingkungan klinik yang padat, jadwal yang ketat, dan kebutuhan untuk merawat banyak pasien sekaligus sering membuat perawat kesulitan menyediakan waktu cukup untuk diskusi etis yang mendalam dengan pasien atau keluarga. Hal ini dapat meningkatkan risiko salah komunikasi, miskonsepsi, dan potensi resistensi pasien terhadap perawatan. Oleh karena itu, organisasi kesehatan perlu menyediakan dukungan struktural untuk memungkinkan perawat menjalankan komunikasi etis dan mendalam dengan pasien.

Konflik antara perawat dengan pasien atau keluarga kerap muncul ketika keputusan pasien dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan dirinya sendiri atau bertentangan dengan penilaian profesional tentang kepentingan terbaik pasien. Dalam situasi seperti ini, perawat dihadapkan pada dilema antara menghormati otonomi pasien dan memastikan keselamatan serta keberlangsungan perawatan, terutama ketika ada perbedaan pandangan antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan mengenai tindakan yang paling tepat (Jia, 2024).

Berbagai studi etika keperawatan menunjukkan bahwa untuk menangani konflik semacam ini tanpa mengorbankan prinsip profesional maupun hak pasien, perawat memerlukan keterampilan refleksi etis, kemampuan berargumentasi dan berdialog tentang nilai, pengetahuan mengenai hak dan kewajiban hukum, serta keterampilan komunikasi interpersonal yang peka terhadap konteks klinik dan relasi kekuasaan. Dukungan organisasi, pendidikan

etika yang berkelanjutan, dan akses pada konsultasi etik turut memperkuat kapasitas perawat dalam menghadapi konflik tersebut.

Konflik etik antara perawat dan pasien atau keluarga merupakan bagian inheren dari praktik klinik modern, terutama ketika otonomi pasien, kepentingan keselamatan, kerahasiaan, komunikasi, dan perbedaan budaya saling berinteraksi dan menimbulkan dilema moral. Dalam konteks ini, perawat berperan sebagai mediator etis yang menyeimbangkan prinsip-prinsip etika, menghormati hak pasien, sekaligus mempertahankan kualitas perawatan dan keadilan distribusi sumber daya (Liu et al., 2023). Pendekatan yang humanis, komunikasi yang terbuka dan jujur, serta sensitivitas budaya terbukti penting untuk mengurangi ketegangan, mencegah kerusakan hubungan, dan menjaga hubungan terapeutik yang konstruktif antara perawat, pasien, dan keluarga.

2. Konflik antara Perawat dengan Rekan Sejawat

Konflik etik antara perawat dan rekan sejawat, termasuk dokter serta tenaga kesehatan profesional lain, merupakan bagian dari dinamika kerja yang kompleks di lingkungan pelayanan kesehatan. Perbedaan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan tanggung jawab profesional memengaruhi cara pandang terhadap prioritas dan tujuan perawatan, sehingga mudah menimbulkan perbedaan penilaian mengenai apa yang disebut sebagai “perawatan yang baik” bagi pasien (Larsman et al., 2024). Dalam situasi ini, perawat berada pada posisi “di antara” pasien, dokter, dan tuntutan organisasi, berperan sebagai penghubung informasi sekaligus pelaksana tindakan, sehingga sering terpapar konflik etik yang bersumber dari koordinasi yang kurang, kolaborasi yang tidak seimbang, dan kebutuhan untuk berkompromi secara profesional.

Perbedaan prioritas dan tujuan profesional menjadi salah satu sumber utama konflik antar anggota tim. Dokter dapat lebih menekankan intervensi medis kuratif, sementara perawat sering menyoroti aspek holistik, kenyamanan, dan martabat pasien (Almudaini et al., 2024). Ketidaksesuaian orientasi dan tujuan ini terbukti berkaitan dengan penurunan efektivitas tim, kualitas koordinasi antarprofesi, dan keselamatan pasien.

Perbedaan interpretasi terhadap pedoman perawatan juga memicu konflik. Pedoman yang sama dapat dipahami berbeda bergantung pada pengalaman, pelatihan, dan orientasi profesional, misalnya dalam penentuan keberlanjutan terapi agresif, manajemen nyeri, atau batasan intervensi yang dianggap futile. Perbedaan ini, bila tidak dikomunikasikan secara terbuka, meningkatkan potensi ketegangan interpersonal dan moral distress di antara anggota tim.

Pengalaman kerja dan posisi dalam hirarki turut membentuk perspektif dalam pengambilan keputusan. Tenaga kesehatan yang lebih berpengalaman

kadang lebih berhati-hati atau terpengaruh budaya unit, sedangkan tenaga baru cenderung berpegang ketat pada pedoman berbasis bukti (Kateb et al., 2025). Studi kualitatif dan telaah interprofesional menunjukkan bahwa kurangnya forum diskusi yang aman dan setara, serta dominasi hierarki, memperbesar risiko konflik karena anggota tim membuat asumsi sendiri terhadap keputusan rekan sejawat dan merasa suara profesionalnya tidak cukup didengar (Silverman et al., 2022).

Komunikasi yang kurang efektif sering menjadi faktor utama konflik antar rekan sejawat. Instruksi yang tidak jelas, informasi yang terlambat, atau penggunaan terminologi yang berbeda dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berdampak pada proses kerja. Meta-analisis menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk di antara tenaga kesehatan terkait langsung dengan peningkatan konflik interpersonal dan risiko kesalahan. Perawat sering harus berperan aktif dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan dipahami dengan benar oleh seluruh anggota tim.

Koordinasi tim yang tidak optimal dapat memperburuk konflik. Ketika peran dan tanggung jawab anggota tim tidak jelas, terjadi tumpang tindih atau pengabaian tugas yang dapat menimbulkan ketidakpuasan. Survei terhadap staf kesehatan menunjukkan bahwa persepsi ketidakjelasan peran berkorelasi dengan meningkatnya konflik dan menurunnya kepuasan kerja. Perawat sering menghadapi dilema antara menegaskan pandangan profesional atau menyesuaikan diri dengan keputusan dominan demi kelancaran kerja tim. Ketidakseimbangan peran juga menjadi pemicu konflik. Perawat sering berada dalam posisi untuk melaksanakan keputusan, tetapi tidak selalu terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Kondisi ini menimbulkan dilema etis ketika perawat memiliki pandangan berbeda namun merasa tidak memiliki ruang untuk menyuarakannya. Fenomena ini mencerminkan konflik struktural yang dapat memengaruhi kolaborasi profesional.

Struktur hierarki organisasi kesehatan turut memengaruhi konflik. Organisasi dengan kultur hierarki yang kuat cenderung menempatkan suara dokter atau profesi tertentu lebih dominan, sementara perawat mungkin memiliki keterbatasan dalam menyampaikan keprihatinan etis. Studi menunjukkan bahwa hierarki dapat menghambat komunikasi terbuka dan menurunkan efektivitas kolaborasi antarprofesi. Tekanan kerja menjadi faktor penting lain yang memperburuk konflik. Beban kerja tinggi, keterbatasan waktu, dan tuntutan administratif mengurangi kesempatan untuk diskusi etis atau koordinasi antar tim. Penelitian menunjukkan bahwa tekanan kerja yang tinggi berhubungan dengan meningkatnya konflik interpersonal dan menurunnya kolaborasi. Perawat

dituntut menavigasi tekanan ini sambil mempertahankan profesionalisme dan integritas etis dalam setiap keputusan.

Kompetensi komunikasi interprofesional menjadi kunci dalam mengelola konflik. Keterampilan menyampaikan pendapat secara jelas, mendengarkan secara aktif, dan memahami perspektif rekan sejawat dapat mengurangi ketegangan dalam tim. Studi longitudinal membuktikan bahwa pelatihan komunikasi interprofesional meningkatkan efektivitas kolaborasi dan menurunkan frekuensi konflik. Pendekatan ini mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih harmonis, menghormati peran profesional masing-masing, dan memfasilitasi pelayanan yang aman dan etis.

3. Konflik dengan Kebijakan Fasilitas Kesehatan

Konflik antara ketentuan administratif dan kebutuhan pasien merupakan masalah yang sering dihadapi fasilitas kesehatan modern. Berbagai kebijakan institusi kerap dirancang untuk menjamin efisiensi operasional, standarisasi layanan, dan kepatuhan regulasi, tetapi pada saat yang sama dapat membatasi kemampuan tenaga kesehatan untuk merespons kebutuhan spesifik pasien secara individual (Michaels & Maheswaran, 2023). Keterbatasan waktu, ruang, dan sumber daya seperti kurangnya staf dan alat, sering memaksa tenaga kesehatan lebih menekankan kepatuhan prosedur dan target administratif dibandingkan penyesuaian perawatan terhadap kondisi unik pasien (Booth et al., 2024).

Konsekuensinya, konflik ini dapat menurunkan kualitas pelayanan yang diterima pasien, terutama dalam situasi mendesak yang membutuhkan keputusan cepat dan fleksibilitas klinik. Ketika kebijakan dan prosedur tidak memberi kelonggaran, tenaga kesehatan mungkin terpaksa mengikuti alur administratif yang memperlambat penanganan pasien kritis, sehingga menimbulkan ketegangan antara tenaga medis, pasien, dan keluarga yang mengharapkan respons yang lebih sigap dan berpusat pada pasien (Dzeng et al., 2023).

Konflik antara ketentuan administratif dan kebutuhan pasien menjadi semakin kompleks ketika terjadi di tengah keterbatasan sumber daya. Rumah sakit harus mengelola kekurangan tempat tidur, alat medis, dan tenaga kesehatan, sementara kebijakan triase, pembiayaan, dan prioritas layanan dapat memperkuat ketidakselarasan antara kebutuhan klinik dan alokasi sumber daya. Dalam konteks ini, keputusan yang didorong oleh efisiensi atau regulasi dapat mengakibatkan penundaan bagi pasien dengan kebutuhan mendesak atau tinggi kompleksitas.

Selain memengaruhi mutu pelayanan, konflik kebijakan–kebutuhan pasien juga menambah beban emosional dan moral distress bagi tenaga kesehatan.

Ketika profesional merasa “tidak dapat menjadi tenaga kesehatan yang mereka inginkan” karena dibatasi kebijakan, kekurangan staf, atau kurangnya dukungan administrasi, muncul rasa frustrasi, ketidakberdayaan, dan keinginan untuk meninggalkan tempat kerja (Bhati et al., 2023). Tekanan untuk sekaligus memenuhi standar regulasi, target administratif, dan tanggung jawab moral kepada pasien menjadikan dukungan organisasi, partisipasi klinisi dalam perumusan kebijakan, dan perbaikan komunikasi klinis-administratif sangat penting untuk meminimalkan konflik dan mempertahankan kualitas asuhan

Konflik antara etika profesional dan regulasi institusi semakin memperburuk tekanan yang dialami tenaga kesehatan. Kewajiban profesional untuk mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pasien kerap berbenturan dengan kebijakan institusional yang menekankan efisiensi, pengendalian biaya, dan logika “bisnis”, termasuk pembatasan penggunaan obat, tempat tidur, atau prosedur tertentu, yang dapat menghambat pemberian perawatan yang dianggap klinis perlu dan aman bagi pasien (Beadle et al., 2024). Ketegangan ini tidak hanya menurunkan kualitas perawatan dan keselamatan pasien, tetapi juga memengaruhi keputusan klinis dan memicu moral distress ketika tenaga kesehatan tahu apa yang secara etis benar namun terhalang oleh kebijakan atau keterbatasan sumber daya.

Konflik juga muncul ketika kebijakan administrasi tidak cukup mempertimbangkan kondisi klinis spesifik dan kebutuhan individual pasien. Kebijakan yang kaku, sangat terfokus pada standar prosedur, dokumentasi, dan pemenuhan regulasi sering kali mengabaikan urgensi klinis, mengurangi ruang diskresi profesional, serta menimbulkan ketidakpuasan pasien dan keluarga yang merasa tidak memperoleh perawatan yang layak. Dalam konteks fasilitas dengan sumber daya terbatas, ketidakseimbangan alokasi staf, tempat tidur, dan perlengkapan medis memperdalam ketidakadilan akses layanan dan meningkatkan ketegangan antara pasien, keluarga, dan petugas kesehatan.

Penyelesaian konflik memerlukan kebijakan yang lebih fleksibel dan adaptif, berorientasi pada nilai etis, keselamatan pasien, dan realitas praktik. Literatur menekankan pentingnya: pelibatan klinisi dalam penyusunan kebijakan; penguatan pendidikan etika dan pelatihan pengambilan keputusan dalam kondisi keterbatasan; pengurangan beban administratif yang tidak perlu; serta pengembangan kerangka alokasi sumber daya yang transparan dan berkeadilan. Pendekatan semacam ini dapat membantu menyelaraskan regulasi institusi dengan etika profesional dan meningkatkan kualitas serta keadilan pelayanan. Peningkatan penggunaan teknologi dalam fasilitas kesehatan dapat membantu mengurangi beberapa masalah yang timbul akibat keterbatasan sumber daya.

Sistem manajemen yang lebih efisien dan pemanfaatan teknologi medis yang lebih baik, seperti telemedicine atau sistem pemantauan pasien jarak jauh, dapat memberikan lebih banyak fleksibilitas bagi petugas kesehatan dalam memberikan perawatan. Kolaborasi yang lebih baik antara tenaga medis, pengelola rumah sakit, dan pembuat kebijakan juga sangat penting untuk menciptakan solusi yang lebih adil dan efektif dalam mengatasi konflik antara ketentuan administratif dan kebutuhan pasien.

Pada akhirnya, penting untuk memahami bahwa kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan pasien akan memperburuk konflik yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih manusiawi dalam merancang kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan regulasi dan efisiensi, tetapi juga kesejahteraan pasien sebagai prioritas utama. Dengan demikian, kolaborasi yang lebih erat antara semua pihak yang terlibat sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih adil, responsif, dan berorientasi pada pasien.

4. Faktor Pemicu Konflik Etik dalam Praktik Klinik Keperawatan

Konflik etik dalam praktik klinik keperawatan muncul ketika prinsip moral, kewajiban profesional, dan kebutuhan pasien saling bersinggungan. Setiap tindakan yang dilakukan perawat tidak hanya dipandu oleh kompetensi klinis, tetapi juga oleh prinsip etika, hak pasien, dan regulasi yang berlaku. Dalam konteks ini, konflik etik menjadi isu penting karena dapat memengaruhi kualitas pelayanan, keselamatan pasien, dan kesejahteraan tenaga kesehatan itu sendiri. Memahami faktor-faktor pemicu konflik etik merupakan langkah awal yang penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan pelayanan keperawatan yang bermutu.

a. Beban Kerja Tinggi

Beban kerja tinggi merupakan faktor signifikan yang memicu konflik etik. Perawat sering harus menangani banyak pasien dalam waktu terbatas, sehingga waktu untuk memberikan perhatian individual kepada pasien berkurang. Beban kerja yang tinggi dapat menimbulkan stres dan kelelahan kerja, mempengaruhi kemampuan kognitif dan emosional perawat dalam mengambil keputusan etis. Dalam praktiknya, dilema muncul ketika perawat harus memilih antara menyelesaikan tugas dengan cepat atau memberikan pelayanan yang sesuai prinsip etika, termasuk hak pasien atas informasi dan partisipasi dalam keputusan klinis.

b. Situasi Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja yang dinamis dan menuntut sering menimbulkan konflik etik. Ketidakpastian, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya koordinasi antar tim

kesehatan dapat memaksa perawat menghadapi dilema dalam prioritas perawatan. Tekanan dari manajemen fasilitas kesehatan untuk mencapai target kinerja tertentu dapat mengaburkan batas antara tindakan administrasi yang “aman” dan tindakan yang “benar secara etis.” Lingkungan kerja yang tidak mendukung ini memperkuat potensi terjadinya konflik antara tanggung jawab profesional dan kebutuhan pasien.

c. Kurangnya Komunikasi Efektif

Komunikasi yang tidak efektif antar perawat, perawat dengan dokter, maupun perawat dengan pasien dapat menimbulkan kesalahpahaman dan interpretasi yang berbeda terkait tindakan klinik. Informasi yang tidak jelas atau terbatas berpotensi merendahkan otonomi pasien dan memicu keputusan yang tidak sesuai prinsip etika. Hal ini sering diperburuk oleh jadwal kerja yang padat dan asumsi bahwa pasien telah memahami kondisi serta pilihan perawatan mereka.

d. Ketidaksesuaian Regulasi dan Kebijakan

Standar operasional prosedur (SOP) dan kebijakan fasilitas kesehatan yang kompleks atau tidak realistis sering menjadi sumber dilema etika. Perawat dapat menghadapi konflik antara mengikuti aturan administratif secara ketat atau bertindak demi kepentingan etis pasien. Ketidaksesuaian ini menunjukkan perlunya penyelarasan antara regulasi internal dan realitas praktik klinik, termasuk implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. UU ini menegaskan hak pasien, tanggung jawab perawat, dan kewajiban untuk menyediakan pelayanan yang bermutu serta etis.

Walaupun UU No. 17 Tahun 2023 memberikan landasan hukum bagi praktik etis perawat, interpretasi terhadap regulasi baru ini terkadang menimbulkan ketidakpastian. SOP di fasilitas kesehatan sering belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kerangka hukum tersebut. Perawat di lapangan bisa mengalami dilema ketika menghadapi situasi klinik yang membutuhkan keputusan cepat, sementara aturan hukum dan SOP belum sepenuhnya sinkron.

e. Perbedaan Prioritas Antara Kebijakan Makro dan Praktik Klinik

Konflik juga timbul dari perbedaan prioritas antara kebijakan kesehatan publik dan kebutuhan pasien secara individual. Perawat harus menyeimbangkan tuntutan pencapaian target kinerja atau produktivitas dengan hak pasien untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketidakseimbangan ini dapat memunculkan dilema etis karena setiap pilihan membawa konsekuensi terhadap kualitas layanan dan kepuasan pasien.

f. Stres dan Kelelahan Kerja

Stres dan kelelahan akibat beban tinggi dan tekanan lingkungan kerja menurunkan kapasitas perawat untuk mengambil keputusan etis secara konsisten. Penurunan kemampuan ini mempengaruhi kualitas informasi yang diberikan kepada pasien serta pertimbangan etis dalam memilih tindakan klinik yang paling sesuai.

g. Kurangnya Koordinasi Antar Tim

Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar tim kesehatan memperburuk potensi konflik etika. Perbedaan persepsi mengenai prioritas tindakan, tanggung jawab, dan interpretasi SOP dapat menimbulkan dilema antara kewajiban profesional dan kebutuhan pasien. Mekanisme komunikasi yang efektif dan kolaborasi tim menjadi penting untuk meminimalkan konflik dan memastikan pelayanan sesuai prinsip etika.

h. Tekanan Administratif dan Target Produktivitas

Tekanan untuk memenuhi indikator kinerja atau target produktivitas dapat bertentangan dengan prinsip etika yang mengutamakan hak pasien. Perawat sering dihadapkan pada dilema memilih antara mematuhi tuntutan manajemen atau memberikan perawatan yang memaksimalkan kesejahteraan pasien. Hal ini menunjukkan bagaimana tuntutan administratif dapat menjadi pemicu konflik etik di praktik klinik.

Faktor-faktor pemicu konflik etik dalam praktik keperawatan tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait. Beban kerja tinggi, lingkungan kerja yang menuntut, komunikasi yang kurang efektif, serta ketidaksesuaian regulasi dan SOP membentuk kompleksitas yang menantang perawat untuk menjalankan praktik klinik secara etis. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting untuk merancang strategi intervensi, SOP, dan pendidikan etika yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan penghormatan terhadap hak pasien.

C. Dinamika dan Tantangan Konflik Etik dalam Praktik Keperawatan

Dalam praktik keperawatan, tenaga kesehatan tidak hanya menghadapi tugas teknis, tetapi juga dilema moral yang bersumber dari tuntutan etika, hukum, dan disiplin profesi (Maryanto & Triadi, 2025). Norma etika profesi dirumuskan dalam kode etik dan prinsip bioetik (otonomi, beneficence, non-maleficence, justice) sebagai pedoman untuk melindungi hak pasien dan menjaga integritas profesi (Yusuf et al., 2022). Norma hukum, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan sektoral lain memberikan kerangka legal bagi pemenuhan hak pasien, mutu, dan keselamatan pelayanan (Fahmi et al., 2025).

Sementara itu, norma disiplin profesi dan lembaga penegak disiplin, mengatur sanksi atas pelanggaran etik dan standar praktik untuk menjaga martabat serta kepercayaan publik terhadap tenaga kesehatan (Duarte et al., 2024).

Konflik etik sering muncul dari kompleksitas pengambilan keputusan klinik, ketika perawat atau tenaga kesehatan harus menyeimbangkan beberapa prinsip etika secara bersamaan. Teori etika prinsip yang mencakup otonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice memberikan landasan sistematis untuk mengevaluasi opsi tindakan, tetapi dalam praktik sering terjadi ketegangan, misalnya antara keinginan pasien dan kewajiban profesional untuk melindungi kehidupan atau mencegah bahaya (Intana Aji Safrima et al., 2024).

Kompleksitas tersebut diperkuat oleh dinamika organisasi dan budaya kerja di fasilitas kesehatan. Budaya organisasi, struktur hierarkis, dan tekanan manajerial pada efisiensi dapat berbenturan dengan nilai pribadi dan komitmen perawat yang berfokus pada kebutuhan pasien, sehingga menimbulkan distress moral, hambatan dalam bertindak etis, dan konflik internal dalam pengambilan keputusan. Salah satu manifestasi nyata dari konflik etis adalah moral distress, yang didefinisikan Jameton sebagai pengalaman psikologis ketika seseorang mengetahui tindakan terbaik secara moral, tetapi terhambat oleh batasan organisasi untuk melaksanakannya. Ketika perawat tidak dapat bertindak sesuai penilaian moralnya karena kebijakan, tekanan administratif, atau keterbatasan sumber daya, muncul rasa frustrasi, berkurangnya kekuatan moral, dan konflik batin berkepanjangan (Restika et al., 2020).

Moral distress tidak hanya menciptakan tekanan emosional individu, tetapi juga berkontribusi pada penurunan mutu pelayanan. Kajian menunjukkan bahwa moral distress berdampak luas terhadap kesehatan fisik dan mental perawat, menurunkan kualitas asuhan, kepuasan kerja, dan berhubungan dengan burnout serta peningkatan keinginan untuk keluar dari profesi. Dampaknya dapat merembet ke keselamatan pasien karena perawat merasa tertekan dan kurang mampu mengambil keputusan yang optimal secara klinis dan moral.

Fenomena *burnout* sering muncul ketika moral distress dibiarkan tanpa mitigasi. Burnout merupakan respons kronis terhadap stres kerja yang terus-menerus, ditandai kelelahan emosional, depersonalisasi terhadap pasien, dan berkurangnya rasa pencapaian profesional. Pada perawat kesehatan jiwa, moral distress yang tidak teratasi terbukti berhubungan dengan tingkat burnout, meskipun dengan kekuatan hubungan yang lemah (Auliannisa et al., 2023). Dalam konteks keperawatan, burnout memperburuk konflik etik karena mengikis kapasitas perawat untuk berempati, berpikir kritis, dan mempertahankan standar etika yang tinggi di tengah beban kerja berat.

Ketegangan antara kepatuhan pada aturan, kebijakan rumah sakit, dan kebutuhan pasien merupakan tantangan nyata dalam praktik klinik. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan pedoman profesi menekankan hak pasien atas informasi, persetujuan, dan pelayanan yang manusiawi dan bermutu, namun kebijakan internal yang kaku sering kali mempersempit ruang bagi perawat untuk bertindak fleksibel demi kebutuhan individual pasien, sehingga memicu dilema etis.

Organisasi kesehatan perlu menyadari bahwa konflik etik bukan sekadar persoalan individual, tetapi merupakan hasil interaksi antara sistem klinik, kebijakan, budaya organisasi, dan struktur sosial di fasilitas pelayanan. Ketika organisasi gagal menyediakan dukungan etika, mekanisme diskusi kasus etik, atau pelatihan pengambilan keputusan etis, perawat menjadi semakin rentan terhadap konflik internal dan tekanan batin yang tidak terkelola dengan baik. Praktik yang responsif terhadap konflik etik mencakup dialog terbuka, pembentukan tim etika, dukungan emosional, kerja sama tim multidisiplin, serta ruang refleksi profesional di lingkungan kerja (Rizkianti et al., 2025).

Perawat dapat mengembangkan strategi adaptif untuk menghadapi dinamika konflik etik melalui refleksi moral, keterampilan komunikasi interprofesional, dan kolaborasi yang kuat dengan tim klinik. Pemahaman teoretis tentang etika yang dipadukan dengan pengalaman klinik memungkinkan perawat menavigasi dilema etis dengan lebih baik, sekaligus meminimalkan dampak negatif pada kesejahteraan pribadi dan mutu pelayanan pasien. Pendidikan etika klinik dan pelatihan berkelanjutan berperan penting dalam membangun ketahanan moral dan strategi koping adaptif pada perawat.

Sebagai profesi moral, keperawatan menuntut kemampuan perawat mengintegrasikan nilai profesional dengan tuntutan praktik nyata di klinik. Nilai seperti otonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice tidak hanya prinsip abstrak, tetapi pedoman yang harus diwujudkan dalam setiap keputusan klinik untuk menjamin kualitas pelayanan dan kepuasan pasien (Nengsih et al., 2022). Konflik etik dalam keperawatan bukan fenomena teoritis, melainkan realitas berulang dalam pengalaman perawat di lini depan pelayanan, yang memengaruhi kualitas dan keselamatan asuhan. Tanpa perhatian serius terhadap faktor organisasi, budaya kerja, dan dukungan etika, implementasi norma etika dan hukum seperti dalam UU No. 17 Tahun 2023 tidak akan memadai untuk menjamin pelayanan yang manusiawi, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

D. Strategi Penyelesaian Konflik Etik

Konflik etik menjadi bagian yang tak terpisahkan dari praktik keperawatan karena setiap keputusan klinik melibatkan pertimbangan moral, hak pasien, dan regulasi hukum. Perawat menghadapi situasi di mana kepentingan pasien kadang berbenturan dengan kebijakan rumah sakit atau keterbatasan sumber daya. Tekanan ini menuntut perawat untuk menyeimbangkan nilai profesional dengan realitas praktik klinik sehari-hari. Strategi penyelesaian konflik etik harus dirancang untuk menjaga integritas profesi sekaligus memenuhi hak pasien secara optimal.

Pelanggaran etik tidak selalu berarti pelanggaran hukum, sebaliknya pelanggaran hukum tidak selalu merupakan pelanggaran etik. pelanggaran etik tenaga kesehatan dipergunakan untuk menyebut kelakuan (conduct) yang tidak sesuai dengan mutu profesional yang tinggi, kebiasaan dan cara-cara atau kebijakan yang lazim digunakan. Melanggar etik tenaga kesehatan berarti juga melanggar prinsip-prinsip moral, nilai dan kewajiban-kewajiban sehingga perlu diambil tindakan-tindakan yang bersifat pembinaan. Penilaian pelanggaran etik dilakukan oleh Majelis Kehormatan Etika Profesi.

Penetapan kategori berat ringannya pelanggaran etik yang dilakukan tenaga kesehatan didasarkan atas kriteria sebagai berikut:

1. Akibat yang ditimbulkan terhadap keselamatan pasien
2. Akibat yang ditimbulkan terhadap kehormatan profesi
3. Akibat yang ditimbulkan terhadap kepentingan umum
4. Itikad baik terkandung dalam menyelesaikan masalah
5. Motivasi yang mendasarkan timbulnya masalah atau kasus
6. Situasi lingkungan yang mendasari timbulnya kasus
7. Pendapat dan pandangan Biro Hukum dan Pembelaan anggota (BHP2A).

Penting bagi perawat untuk mulai dengan identifikasi konflik secara sistematis. Hal ini mencakup pengenalan dilema yang muncul, pihak-pihak yang terlibat, dan prinsip etika yang bersinggungan, seperti otonomi pasien, beneficence, dan non-maleficence. Pemetaan konflik secara tepat membantu perawat merencanakan langkah tindakan yang mempertimbangkan berbagai kepentingan. Analisis awal ini juga meminimalkan risiko kesalahan interpretasi dan mempermudah komunikasi dengan tim interprofesional.

Refleksi moral menjadi tahap penting setelah identifikasi masalah. Perawat menilai nilai pribadi, prinsip etika profesi, dan norma hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Evaluasi ini membantu menimbang risiko dan manfaat setiap tindakan, serta merumuskan keputusan yang sejalan dengan standar etika dan hukum. Proses refleksi mendorong perawat

berpikir kritis dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari setiap pilihan klinik.

Strategi berikutnya adalah kolaborasi tim interprofesional. Diskusi dengan dokter, perawat lain, konsultan etika, dan manajemen memungkinkan pertukaran perspektif dan konsensus dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi ini juga membantu mengurangi beban moral individu perawat dan meningkatkan kualitas keputusan klinik. Dengan keterlibatan semua pihak, risiko kesalahan penilaian dan konflik internal dapat diminimalkan, sehingga pelayanan kepada pasien tetap optimal. Penggunaan mekanisme mediasi etika atau tim konsultasi etika dapat membantu kasus yang sulit diselesaikan secara internal. Tim konsultasi etika bertindak sebagai pihak netral yang mengevaluasi kasus berdasarkan prinsip etika, regulasi hukum, dan konteks klinik. Rekomendasi yang diberikan tim ini membantu perawat bertindak secara moral tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap SOP dan kebijakan institusi. Strategi ini juga dapat mengurangi moral distress dan meningkatkan rasa aman di tempat kerja.

Komunikasi yang efektif menjadi strategi penting untuk mencegah dan menyelesaikan konflik. Perawat yang mampu menjelaskan risiko, manfaat, dan alternatif tindakan kepada pasien dan keluarga, serta berkoordinasi dengan tim interprofesional, dapat meminimalkan miskomunikasi. Keterampilan komunikasi yang baik memfasilitasi *informed consent* yang sah dan membangun hubungan berbasis kepercayaan. Hal ini memungkinkan perawat bertindak etis tanpa menimbulkan ketegangan tambahan dengan pasien atau rekan kerja.

Pendidikan etika berkelanjutan memberikan perawat pemahaman mendalam tentang dilema moral dan cara menanganinya secara sistematis. Pelatihan ini mencakup analisis kasus nyata, penerapan teori etika, dan simulasi pengambilan keputusan klinik. Perawat yang terlatih dapat menghadapi dilema etik dengan strategi adaptif yang mempertimbangkan hak pasien, norma hukum, dan standar profesi. Pendidikan etika juga memperkuat ketahanan moral perawat di lingkungan kerja yang kompleks dan penuh tekanan.

Dokumentasi dan evaluasi tindakan menjadi strategi praktis yang membantu perawat menjaga akuntabilitas dan transparansi. Pencatatan alasan pengambilan keputusan, pertimbangan etis, dan langkah mitigasi risiko menjadi bahan refleksi dan pembelajaran. Evaluasi berkala terhadap kasus konflik etik dapat memperbaiki SOP dan prosedur internal, sehingga dilema serupa di masa depan dapat diminimalkan. Dokumentasi juga memberikan perlindungan hukum bagi perawat dalam menghadapi situasi kritis.

Perawat dapat memanfaatkan strategi *coping personal* untuk menghadapi tekanan emosional akibat konflik etik. Teknik seperti refleksi pribadi, mentoring,

dukungan kelompok, dan manajemen stres membantu menjaga kesejahteraan mental. Strategi ini penting agar perawat tetap mampu membuat keputusan etis dan mempertahankan kualitas pelayanan. *Coping* yang efektif juga mengurangi risiko *burnout*, sehingga perawat dapat melaksanakan tugas profesional dengan lebih konsisten. Budaya organisasi yang mendukung etika profesional memperkuat strategi penyelesaian konflik. Institusi kesehatan perlu menyediakan ruang diskusi etis, refleksi profesional, dan kebijakan yang fleksibel sesuai situasi klinik. Lingkungan yang mendukung etika memungkinkan perawat bertindak dengan integritas, menjaga kesejahteraan psikologis, dan memberikan pelayanan yang manusiawi serta profesional. Budaya organisasi semacam ini juga mendorong penerapan prinsip etika secara berkelanjutan dalam praktik sehari-hari.

E. Penutup

Menjadi tenaga kesehatan bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga tentang keberanian moral dan tanggung jawab etis. Setiap keputusan yang diambil di ruang klinik membawa dampak nyata bagi kehidupan pasien, dan sering kali menuntut perawat untuk berpikir cepat, bijak, dan berempati. Konflik etik adalah bagian alami dari profesi ini, dan mengenal, menghadapi, serta menyelesaikannya dengan tepat menjadi inti dari praktik keperawatan yang bermutu.

Perawat dihadapkan pada dilema ketika prinsip moral pribadi bertabrakan dengan kebijakan rumah sakit, keterbatasan sumber daya, atau kebutuhan pasien yang kompleks. Menghadapi situasi seperti ini memerlukan kemampuan refleksi, pemahaman mendalam tentang prinsip etika profesional, serta keberanian untuk mengambil keputusan yang adil dan manusiawi. Pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi landasan hukum yang memperkuat kepastian tindakan dan melindungi hak pasien. Lingkungan kerja yang mendukung etika dapat menjadi perisai bagi perawat dalam menghadapi dilema moral. Ruang diskusi, tim konsultasi etika, dan budaya organisasi yang menghargai integritas memungkinkan perawat untuk mengambil keputusan secara kolaboratif. Budaya yang mengedepankan refleksi etis bukan hanya mempermudah pengambilan keputusan, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri dan ketenangan batin bagi tenaga kesehatan.

Strategi adaptif seperti refleksi moral, komunikasi efektif, pendidikan etika berkelanjutan, dan coping personal menjadi alat penting untuk menghadapi tekanan dan moral distress. Perawat yang mampu mengelola stres dan mempraktikkan strategi ini dapat mempertahankan kualitas pelayanan, mengurangi risiko *burnout*, dan tetap konsisten bertindak sesuai nilai etika. Strategi-strategi ini membantu perawat menavigasi kompleksitas dunia klinik tanpa kehilangan arah

profesional. Dokumentasi, evaluasi, dan kolaborasi tim interprofesional memperkuat fondasi pengambilan keputusan etis. Mencatat alasan, pertimbangan moral, dan langkah mitigasi risiko tidak hanya menjaga akuntabilitas, tetapi juga menjadi bahan pembelajaran bagi tim. Proses ini memastikan setiap tindakan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan perhatian terhadap kesejahteraan pasien dan integritas profesi.

Akhirnya, penyelesaian konflik etik adalah perjalanan bersama antara perawat, pasien, dan institusi kesehatan. Dengan kesadaran moral, dukungan organisasi, dan penerapan strategi reflektif dan kolaboratif, perawat dapat menghadapi dilema etis dengan integritas, empati, dan keberanian. Praktik keperawatan yang demikian bukan hanya profesional dan terpercaya, tetapi juga menginspirasi, menjadikan pelayanan kesehatan lebih manusiawi, dan memastikan hak serta martabat pasien selalu terjaga.

Referensi

- Aljabery, M., Coetzee-Prinsloo, I., van der Wath, A., & Al-Hmairat, N. (2024). Characteristics of Moral Distress From Nurses' Perspectives: An Integrative Review. *International Journal of Nursing Sciences*, 11(5), 578–585. <https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2024.10.005>
- Almudaini, A. F., Alhajjimohammed, M. M., Alanazi, F. O., Alnasser, O. M., Alkhateeb, A. I., Arishi, N. H., Alkhawajah, S. H., & Alamri, D. A. (2024). Ethical Conflicts Between Healthcare Providers and Institutional Policies. *Journal of Posthumanism*, 4(2). <https://doi.org/10.63332/joph.v4i2.3060>
- Anzini, A., Caggianelli, G., Tomasin, R. P., Segala, A., Giangrazi, S., Paccagnella, C., Mancin, S., Petrelli, F., Vanzi, V., Cangelosi, G., & Dello Iacono, I. (2025). Transcultural Challenges in The Nurse-Migrant Patient Caring Relationship: A Phenomenological Study. *Applied Nursing Research*, 83, 151954. <https://doi.org/10.1016/j.apnr.2025.151954>
- Auliannisa, S., Siauta, V. A., & Hidayat, E. (2023). Hubungan Moral Distress Terhadap Kinerja Tenaga Kesehatan di UPTD Puskesmas Kamonji Palu. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 245–249. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i3.80>
- Beadle, E. S., Walecka, A., Sangam, A. V., Moorhouse, J., Winter, M., Munro Wild, H., Trivedi, D., & Casarin, A. (2024). Triggers and Factors Associated With Moral Distress And Moral Injury in Health and Social Care Workers: A Systematic Review of Qualitative Studies. *PLOS ONE*, 19(6), e0303013. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0303013>

- Bhati, D., Deogade, M. S., & Kanyal, D. (2023). Improving Patient Outcomes Through Effective Hospital Administration: A Comprehensive Review. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.47731>
- Booth, A. T., Dobson, B. F., Christian, B. J., Clark, P. R., & Sha, S. (2024). Institution-Wide Moral Distress Among Nurses. *JONA: The Journal of Nursing Administration*, 54(11), 597–604. <https://doi.org/10.1097/NNA.0000000000001497>
- Čartolovni, A., Stolt, M., Scott, P. A., & Suhonen, R. (2021). Moral Injury in Healthcare Professionals: A Scoping Review and Discussion. *Nursing Ethics*, 28(5), 590–602. <https://doi.org/10.1177/0969733020966776>
- Du, J., Huang, S., Lu, Q., Ma, L., Lai, K., & Li, K. (2022). Influence of Empathy and Professional Values on Ethical Decision-Making of Emergency Nurses: A Cross Sectional Study. *International Emergency Nursing*, 63. <https://doi.org/10.1016/j.ienj.2022.101186>
- Duarte, A. C. da S., Chicharo, S. C. R., Silva, T. A. S. M. da, & Oliveira, A. B. de. (2024). Ethical-Legal Dilemmas of Nursing Practice in Emergencies and Disasters: A Scoping Review. *Revista Da Escola de Enfermagem Da USP*, 58. <https://doi.org/10.1590/1980-220x-reeusp-2023-0233en>
- Dzeng, E., Batten, J. N., Dohan, D., Blythe, J., Ritchie, C. S., & Curtis, J. R. (2023). Hospital Culture and Intensity of End-of-Life Care at 3 Academic Medical Centers. *JAMA Internal Medicine*, 183(8), 839. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2023.2450>
- Fahmi, R., Rovita, A., Ardila, S., Afnanita, S., Zahra, S. H., & Herawati, N. (2025). Etika Profesi Dokter Dalam Pelanggaran Etik: Tinjauan Forensik. *MIKHAYLA : Journal of Advanced Research*, 2(2), 96–103. <https://doi.org/10.61579/mikhayla.v2i2.484>
- Frank, C., Holmberg, M., Jernby, E. E., Hansen, A. S., & Bremer, A. (2022). Older Patients' Autonomy When Cared for at Emergency Departments. *Nursing Ethics*, 29(5), 1266–1279. <https://doi.org/10.1177/09697330221105637>
- Geng, S., Zhang, L., Zhang, Q., & Wu, Y. (2024). Ethical Dilemmas for Palliative Care Nurses: Systematic Review. *BMJ Supportive & Palliative Care*, spcare-2023-004742. <https://doi.org/10.1136/spcare-2023-004742>
- Haahr, A., Norlyk, A., Martinsen, B., & Dreyer, P. (2020). Nurses experiences of ethical dilemmas: A review. In *Nursing Ethics* (Vol. 27, Issue 1). <https://doi.org/10.1177/0969733019832941>
- Hamric, A. B., & Blackhall, L. J. (2007). Nurse-Physician Perspectives on The Care of Dying Patients in Intensive Care Units: Collaboration, Moral Distress, and Ethical Climate. *Critical Care Medicine*, 35(2), 422–429. <https://doi.org/10.1097/01.CCM.0000254722.50608.2D>

- Hou, Y., Timmins, F., Zhou, Q., & Wang, J. (2021). A cross-sectional exploration of emergency department nurses' moral distress, ethical climate and nursing practice environment. *International Emergency Nursing*, 55. <https://doi.org/10.1016/j.ienj.2021.100972>
- Intana Aji Safrima, Asiya Chaniatuttazkiya, & Sza Sza Al Zahwa Noor Sandaga. (2024). Euthanasia Dipandang Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 1(4), 201–213. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v1i4.153>
- Jia, Y. (2024). Ethical Dilemmas of Nurses on Patient Autonomy in End-Of-Life Care in A Selected Tertiary Hospital in Nanyang City, China. *International Journal of Social Science and Human Research*, 7(08). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i08-24>
- Kateb, A. Y., ALSahli, F. A., ALHARBI, T. A., Albarnawi, R. T., & Alluqmani, A. O. (2025). Ethical Decision-Making in Healthcare: The Combined Role of Nurses and Physicians. *Journal of Posthumanism*, 4(3). <https://doi.org/10.63332/joph.v4i3.3498>
- Koskenvuori, J., Numminen, O., & Suhonen, R. (2019). Ethical Climate in Nursing Environment: A Scoping Review. *Nursing Ethics*, 26(2), 327–345. <https://doi.org/10.1177/0969733017712081>
- Kwame, A., & Petrucka, P. M. (2021). A Literature-Based Study of Patient-Centered Care and Communication in Nurse-Patient Interactions: Barriers, Facilitators, and The Way Forward. *BMC Nursing*, 20(1), 158. <https://doi.org/10.1186/s12912-021-00684-2>
- Larsman, P., Pousette, A., Skyvell Nilsson, M., Gadolin, C., & Törner, M. (2024). Ethical Value Conflicts in Healthcare And Their Effects On Nurses' Health, Turnover Intent, Team Effectiveness, and Patient Safety: A Longitudinal Questionnaire Study. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 50(2), 113–121. <https://doi.org/10.5271/sjweh.4138>
- Liu, Y., Wang, X., Wang, Z., Zhang, Y., & Jin, J. (2023). Ethical Conflict in Nursing: A Concept Analysis. *Journal of Clinical Nursing*, 32(15–16), 4408–4418. <https://doi.org/10.1111/jocn.16563>
- Maryanto, M., & Triadi, I. (2025). Penerapan Nilai Etik, Norma, dan Disiplin Kesehatan dalam Praktik Pelayanan Kesehatan dengan Penyelesaian Sengketa Etik. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(4), 387–402. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i4.4520>

- Michaels, J. A., & Maheswaran, R. (2023). Conflicting Perspectives During Guidelines Development are An Important Source of Implementation Failure. *Health Policy*, 131, 104801. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2023.104801>
- Nengsih, C. R., Mulyati, M., & Novilla, A. (2022). Sikap dalam Dilema Etik dan Sikap Profesional Perawat terhadap Kualitas Pelayanan. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 6(1), 366–376. <https://doi.org/10.31539/jks.v6i1.4386>
- Pakkanen, P., Häggman-Laitila, A., & Kangasniemi, M. (2022). Ethical Issues Identified In Nurses' Interprofessional Collaboration in Clinical Practice: A Meta-Synthesis. *Journal of Interprofessional Care*, 36(5), 725–734. <https://doi.org/10.1080/13561820.2021.1892612>
- Poorchangizi, B., Farokhzadian, J., Abbaszadeh, A., Mirzaee, M., & Borhani, F. (2017). The Importance of Professional Values from Clinical Nurses' Perspective in Hospitals of A Medical University in Iran. *BMC Medical Ethics*, 18(1). <https://doi.org/10.1186/s12910-017-0178-9>
- Rainer, J., Schneider, J. K., & Lorenz, R. A. (2018). Ethical Dilemmas in Nursing: An Integrative Review. *Journal of Clinical Nursing*, 27(19–20), 3446–3461. <https://doi.org/10.1111/jocn.14542>
- Restika, I., Erika, K. A., & Saleh, A. (2020). Pengalaman, Dampak, Dan Strategi Untuk Mengatasi Moral Distress Perawat: Systematic Review. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, Edisi Khusus, 88–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jkm.v5i2.3806>
- Rizkianti, I., Freitas, L. A., Sesilia, F., Kurhayati, K., Reis, S. Dos, Nasrullah, K., & Trisyani, Y. (2025). Pengalaman Perawat Dalam Menghadapi Dilema Etik Pada Pasien Paliative di ICU: A Scoping Review. *MAHESA: Malahayati Health Student Journal*, 5(7), 3107–3121. <https://doi.org/10.33024/mahesa.v5i7.18922>
- Rushton, C. H. (2023). Transforming Moral Suffering by Cultivating Moral Resilience and Ethical Practice. *American Journal of Critical Care*, 32(4), 238–248. <https://doi.org/10.4037/ajcc2023207>
- Silverman, H., Wilson, T., Tisherman, S., Kheirbek, R., Mukherjee, T., Tabatabai, A., McQuillan, K., Hausladen, R., Davis-Gilbert, M., Cho, E., Bouchard, K., Dove, S., Landon, J., & Zimmer, M. (2022). Ethical Decision-Making Climate, Moral Distress, And Intention to Leave Among ICU Professionals in A Tertiary Academic Hospital Center. *BMC Medical Ethics*, 23(1), 45. <https://doi.org/10.1186/s12910-022-00775-y>

- Usberg, G., Uibu, E., Urban, R., & Kangasniemi, M. (2021). Ethical Conflicts in Nursing: An Interview Study. *Nursing Ethics*, 28(2), 230–241. <https://doi.org/10.1177/0969733020945751>
- Victorino, J. P., de Brito, E. S., Westin, U. M., Vargas, M. A. de O., Mendes, K. D. S., & Ventura, C. A. A. (2025). Health Advocacy and Moral Distress Among Nurses in Organ Transplant Units. *Nursing Ethics*, 32(3), 994–1003. <https://doi.org/10.1177/09697330241295368>
- Yusuf, Z. F. A., Supriatini, A., & Nuryanto, U. W. (2022). Dinamika Implementasi Good Hospital Governance dan Prinsip Etika Autonomi, Beneficience, Non-Maleficene ; Justice Pada Keputusan Pelayanan Pasien Rumah Sakit. *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)*, 2(1), 346–360. <https://doi.org/10.46306/ncabet.v2i1.92>
- Zhu, Z., Wang, M., Li, Z., Li, Y., Xue, K., Sun, Y., & Zeng, Y. (2026). Moral Distress Among Nursing Students During Clinical Practice: A Qualitative Systematic Review and Meta-Synthesis. *Nurse Education Today*, 157, 106923. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2025.106923>

BAB VII

PENGUATAN PROFESIONALISME DAN ORGANISASI

A. Pendahuluan

Transformasi sistem pelayanan kesehatan di Indonesia menuntut praktik keperawatan yang tidak lagi semata bertumpu pada keterampilan klinis, tetapi juga berlandaskan etika, hukum, dan profesionalisme yang kuat. Perawat sebagai profesi yang berada pada garis depan pelayanan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan tidak hanya tepat secara klinis, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan legal. Atas dasar ini, penguatan profesionalisme dan organisasi keperawatan menjadi kebutuhan mendasar untuk menjaga konsistensi mutu pelayanan serta memperkuat posisi profesi dalam sistem kesehatan. Sejalan dengan tuntutan tersebut, praktik keperawatan memerlukan landasan nilai yang mampu membimbing perawat dalam setiap pengambilan keputusan, yaitu etika keperawatan (WHO, 2020).

Etika keperawatan merupakan dasar normatif yang membimbing perawat dalam bersikap dan mengambil keputusan secara profesional. Etika tidak hanya bersifat konseptual, tetapi tercermin dalam praktik melalui pertimbangan nilai kemanusiaan, keadilan, tanggung jawab, dan kejujuran dalam setiap tindakan keperawatan. Di Indonesia, nilai-nilai tersebut dirumuskan dalam Kode Etik Perawat Indonesia oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sebagai pedoman perilaku profesional. Kode etik ini berperan penting dalam menjaga integritas profesi sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan keperawatan. Namun, penerapan etika tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu didukung oleh kerangka hukum yang memberikan batasan, kepastian, dan perlindungan dalam pelaksanaan praktik keperawatan (Aimee, 2018).

Aspek hukum berfungsi sebagai sistem yang mengatur praktik keperawatan agar berjalan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab profesional. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yang menjadi dasar legal praktik keperawatan di Indonesia. Melalui regulasi tersebut, perawat memiliki pedoman yang jelas mengenai ruang lingkup praktik sekaligus jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Pemahaman terhadap aspek hukum menjadi krusial agar praktik keperawatan tidak hanya memenuhi standar etika, tetapi juga memiliki legitimasi secara hukum. Sinergi

antara etika dan hukum ini pada akhirnya menjadi fondasi penting dalam membentuk dan memperkuat profesionalisme perawat dalam praktik keperawatan.

Profesionalisme dalam keperawatan mencerminkan kemampuan perawat dalam mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta kepatuhan terhadap nilai etika dan hukum yang berlaku. Profesionalisme tidak hanya terlihat dari kemampuan teknis, tetapi juga dari konsistensi dalam menerapkan standar praktik, komitmen terhadap pengembangan diri, serta kemampuan beradaptasi dalam dinamika pelayanan kesehatan. Laporan *State of the World's Nursing 2020*, menegaskan bahwa penguatan profesionalisme merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas tenaga keperawatan secara global. Upaya mewujudkan profesionalisme tersebut tidak hanya bergantung pada individu perawat, tetapi sangat ditentukan oleh sistem dan peran organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pengembangan profesi keperawatan (Cao et al., 2023).

Organisasi, baik organisasi profesi maupun institusi pelayanan kesehatan, memiliki peran strategis dalam membangun dan mempertahankan profesionalisme perawat. Melalui kebijakan, sistem pembinaan, serta pengembangan kompetensi berkelanjutan, organisasi menciptakan lingkungan yang memungkinkan perawat menjalankan praktik secara optimal. Selain itu, organisasi berperan dalam menegakkan standar profesi, membentuk budaya kerja yang etis, serta memastikan praktik keperawatan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Dengan demikian, sinergi antara etika, hukum, profesionalisme, dan dukungan organisasi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan praktik keperawatan yang bermutu, berintegritas, dan berkelanjutan (WHO, 2020).

Atas dasar itu, etika, hukum, dan profesionalisme merupakan tiga pilar utama yang saling berkaitan dalam praktik keperawatan di Indonesia. Ketiganya tidak dapat dipisahkan karena bersama-sama membentuk dasar bagi praktik yang bertanggung jawab dan berintegritas. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai keterkaitan ketiga aspek tersebut dengan penekanan pada penguatan profesionalisme dan organisasi. Diharapkan buku ini dapat menjadi rujukan dalam mengembangkan praktik keperawatan yang tidak hanya kompeten secara ilmiah, tetapi juga matang secara etis, taat hukum, dan kuat secara profesional. (Yakov et al., ;(Jiang et al., 2024)

B. Konsep Dasar Profesionalisme Keperawatan

1. Definisi Profesionalisme dalam Keperawatan

Profesionalisme dalam keperawatan merupakan suatu sikap, komitmen, dan perilaku perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, standar profesi, serta kode etik keperawatan. Profesionalisme mencerminkan kemampuan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan secara aman, efektif, dan bermutu dengan tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Dalam penerapannya, profesionalisme tidak hanya berfokus pada aspek keterampilan klinis, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial dalam memenuhi kebutuhan pasien secara holistic

2. Karakteristik Perawat Profesional

Perawat profesional memiliki sejumlah karakteristik yang menjadi landasan dalam praktik keperawatan, yaitu:

- a. Kompeten, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpikir kritis yang memadai dalam memberikan asuhan keperawatan berbasis bukti (evidence-based practice).
- b. Etis, yaitu senantiasa berpegang pada kode etik keperawatan dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hak pasien.
- c. Bertanggung jawab, yaitu mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakan keperawatan yang dilakukan, baik secara moral, profesional, maupun hukum.
- d. Berorientasi mutu, yaitu memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan melalui evaluasi, refleksi praktik, dan perbaikan berkelanjutan (Therese Zink, MD, 2011)

3. Nilai Inti Profesionalisme

Nilai inti profesionalisme keperawatan menjadi fondasi dalam membentuk perilaku profesional perawat, yang meliputi:

- a. Caring, yaitu kepedulian yang tulus dalam memberikan asuhan keperawatan secara holistik, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pasien.
- b. Integritas, yaitu konsistensi antara nilai, prinsip, dan tindakan dalam menjalankan tugas keperawatan secara jujur dan dapat dipercaya.
- c. Akuntabilitas, yaitu kemampuan perawat untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan dalam praktik keperawatan.
- d. Empati, yaitu kemampuan memahami dan merasakan kondisi pasien, sehingga tercipta hubungan terapeutik yang lebih manusiawi dan bermakna (Pena et al., 2017).

4. Hubungan Profesionalisme dengan Mutu Pelayanan Keperawatan

Profesionalisme memiliki hubungan yang sangat erat dengan mutu pelayanan keperawatan. Semakin tinggi tingkat profesionalisme perawat, maka semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien. Hal ini terlihat dari peningkatan keselamatan pasien, efektivitas asuhan keperawatan, serta kepuasan pasien terhadap layanan yang diterima. Selain itu, profesionalisme juga berkontribusi dalam menurunkan risiko kesalahan praktik, meningkatkan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, serta memperkuat kolaborasi antar tenaga kesehatan. Oleh karena itu, profesionalisme menjadi salah satu faktor kunci dalam mewujudkan pelayanan keperawatan yang bermutu, aman, dan berkelanjutan (Storm et al., 2014).

C. Standar Profesi dan Kompetensi perawat

1. Standar Kompetensi Perawat di Indonesia

- a. Standar kompetensi perawat di Indonesia merupakan acuan yang menetapkan kemampuan minimal yang wajib dimiliki oleh setiap perawat dalam menjalankan praktik keperawatan. Standar ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam pelayanan, tetapi juga sebagai dasar dalam proses pendidikan, uji kompetensi, registrasi, dan pemberian izin praktik. keberadaan standar kompetensi dapat memastikan praktik keperawatan berlangsung secara terarah, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara profesional maupun hukum. Selain itu, standar ini juga menjadi instrumen penting dalam menjamin mutu pelayanan serta melindungi keselamatan pasien.
- b. Kerangka Kompetensi Perawat (Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap)
Kompetensi perawat dibentuk melalui integrasi tiga ranah utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan mencakup pemahaman terhadap konsep keperawatan, ilmu kesehatan dasar, serta perkembangan ilmu dan teknologi yang relevan dengan praktik. Keterampilan merujuk pada kemampuan teknis dan klinis yang diperlukan dalam memberikan asuhan keperawatan secara tepat dan aman, termasuk kemampuan komunikasi terapeutik dan pengambilan keputusan klinis. Sementara itu, sikap menggambarkan nilai-nilai profesional yang ditunjukkan melalui perilaku kerja, seperti tanggung jawab, kedisiplinan, kejujuran, serta kepedulian terhadap pasien. Ketiga aspek ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dan membentuk kompetensi yang utuh dalam praktik keperawatan.

c. Penerapan Evidence-Based Practice dalam Pelayanan Keperawatan

Penerapan *evidence-based practice* (EBP) menjadi salah satu indikator penting dalam praktik keperawatan modern. Pendekatan ini mengintegrasikan bukti ilmiah terkini dengan pengalaman klinis perawat serta kebutuhan dan preferensi pasien dalam penentuan tindakan keperawatan. Melalui EBP, keputusan yang diambil tidak semata-mata didasarkan pada kebiasaan atau pengalaman semata, tetapi memiliki dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berpengaruh pada peningkatan efektivitas intervensi, penurunan risiko kesalahan praktik, serta penguatan mutu pelayanan keperawatan secara berkesinambungan.

d. Standar Praktik Keperawatan sesuai Regulasi Nasional

Standar praktik keperawatan di Indonesia disusun sebagai pedoman agar setiap tindakan keperawatan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Standar ini mencakup seluruh tahapan proses keperawatan, mulai dari pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan, pelaksanaan tindakan, hingga evaluasi hasil asuhan. Selain itu, aspek dokumentasi, komunikasi profesional, serta kepatuhan terhadap prosedur operasional juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Penerapan standar praktik yang konsisten tidak hanya menjamin mutu pelayanan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi perawat dalam menjalankan praktik profesionalnya (Tian et al., 2018).

D. Etika Profesi dalam Penguatan Profesionalisme

Etika profesi keperawatan merupakan landasan moral yang membimbing perawat dalam menjalankan praktik secara bertanggung jawab, aman, dan berorientasi pada martabat manusia. Dalam praktik keperawatan, etika tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi juga sebagai nilai yang terinternalisasi dalam setiap tindakan, keputusan, dan interaksi perawat dengan pasien maupun tim kesehatan. Sehingga, etika menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari profesionalisme dan kualitas pelayanan keperawatan.

1. Kode Etik Keperawatan sebagai Pedoman Praktik

Kode etik keperawatan berfungsi sebagai pedoman perilaku profesional yang mengarahkan perawat dalam menjalankan tugasnya secara benar secara moral dan profesional. Kode etik ini mengatur hubungan perawat dengan pasien, keluarga, sejawat, profesi lain, serta masyarakat luas.

Dalam pelaksanaannya, kode etik menuntut perawat untuk menjaga kerahasiaan pasien, menghormati hak dan martabat manusia, serta memberikan pelayanan yang adil tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, maupun

ekonomi. Kepatuhan terhadap kode etik mencerminkan integritas profesional dan menjadi dasar kepercayaan masyarakat terhadap profesi keperawatan (Kagabo et al., 2020).

Prinsip-Prinsip Etika dalam Keperawatan

Praktik keperawatan berlandaskan pada prinsip-prinsip etika yang menjadi acuan dalam setiap pengambilan keputusan klinis, yaitu:

- a. Autonomy (otonomi): menghargai hak pasien untuk menentukan pilihan dan keputusan terkait kesehatannya.
- b. Beneficence (berbuat baik): berupaya memberikan tindakan yang membawa manfaat optimal bagi pasien.
- c. Non-maleficence (tidak merugikan): menghindari tindakan yang dapat menimbulkan cedera, risiko, atau kerugian bagi pasien.
- d. Justice (keadilan): memberikan pelayanan secara adil, merata, dan tidak diskriminatif.
- e. Veracity (kejujuran): menyampaikan informasi secara benar, jujur, dan dapat dipahami oleh pasien.
- f. Fidelity (kesetiaan): menjaga komitmen, kepercayaan, dan tanggung jawab terhadap pasien serta profesi.
- g. Confidentiality (kerahasiaan): melindungi seluruh informasi pasien agar tidak disebarluaskan tanpa izin yang sah.
- h. Accountability (akuntabilitas): bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam praktik keperawatan.

Prinsip-prinsip tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar penting dalam membentuk perilaku profesional perawat di berbagai situasi klinis (Antonelli, 2019)

2. Pengambilan Keputusan Etis dalam Praktik Keperawatan

Dalam realitas praktik keperawatan, perawat sering dihadapkan pada situasi yang menuntut pertimbangan etis kompleks. Karena itu, pengambilan keputusan tidak hanya berlandaskan pada aspek klinis, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral, kondisi pasien, serta ketentuan regulasi yang berlaku.

Proses pengambilan keputusan etis dilakukan secara sistematis dan reflektif, melalui proses analisis masalah, mengidentifikasi prinsip etika yang terlibat, serta mendiskusikannya dalam tim kesehatan bila diperlukan. Dengan pendekatan ini, keputusan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya tepat secara klinis, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan profesional (Aimee, 2018).

3. Penanganan Dilema dan Konflik Etik

Dilema etik muncul ketika perawat dihadapkan pada dua atau lebih pilihan yang sama-sama memiliki nilai kebaikan, namun tidak dapat dipenuhi secara bersamaan. Situasi ini sering terjadi dalam praktik klinis, terutama ketika terdapat perbedaan kepentingan antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, perawat perlu bersikap hati-hati, melakukan komunikasi yang baik dengan tim kesehatan, serta mempertimbangkan nilai budaya dan keyakinan pasien. Penyelesaian dilema etik yang tepat tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi keperawatan (Aimee, 2018).

E. Aspek Hukum dalam Praktik Keperawatan

Aspek hukum dalam praktik keperawatan merupakan kerangka yang memberikan batasan, arah, sekaligus perlindungan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Dalam tatanan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks, pemahaman terhadap aspek hukum menjadi bagian penting dari profesionalisme perawat. Setiap tindakan keperawatan tidak hanya dinilai dari ketepatan klinis, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, praktik keperawatan harus dilaksanakan secara hati-hati, sesuai standar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Landasan Hukum Praktik Keperawatan di Indonesia

Praktik keperawatan di Indonesia diselenggarakan berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi tenaga kesehatan. Regulasi ini mencakup aspek pendidikan, registrasi, perizinan, serta pelaksanaan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Landasan hukum tersebut memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup kewenangan perawat, sekaligus menjadi pedoman dalam menjalankan praktik yang aman dan legal. Dengan memahami ketentuan yang berlaku, perawat dapat menjalankan tugasnya secara lebih terarah serta terhindar dari pelanggaran hukum yang dapat merugikan diri sendiri maupun pasien.

2. Hak dan Kewajiban Perawat

Dalam praktik keperawatan, perawat memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hak perawat mencakup perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai standar, memperoleh lingkungan kerja yang aman, serta mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan.

sementara itu, perawat memiliki kewajiban untuk memberikan asuhan keperawatan sesuai standar profesi, menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan informasi, serta bekerja dalam batas kewenangan yang dimiliki. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini menjadi dasar dalam mewujudkan praktik keperawatan yang profesional dan berintegritas.

3. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Hukum

Setiap tindakan keperawatan yang dilakukan memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Tanggung jawab ini mencakup ketepatan tindakan, kepatuhan terhadap prosedur, serta keselamatan pasien.

Akuntabilitas hukum menuntut perawat untuk bekerja secara teliti, mengikuti standar operasional yang berlaku, serta mendokumentasikan setiap tindakan dengan lengkap dan akurat. Dokumentasi yang baik tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari proses pelayanan, tetapi juga menjadi bukti penting apabila terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.

4. Malpraktik dalam Keperawatan

Malpraktik dalam keperawatan dapat terjadi apabila terdapat kelalaian, kesalahan, atau tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kompetensi, kelelahan kerja, atau ketidakpatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

Upaya pencegahan malpraktik dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi, penerapan standar praktik secara konsisten, serta penguatan kesadaran hukum dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, perawat dapat meminimalkan risiko kesalahan dan menjaga mutu pelayanan keperawatan (WHO, 2020).

F. Peran Organisasi Profesi (PPNI)

Organisasi profesi keperawatan memiliki peran penting dalam menjaga mutu praktik serta mengembangkan profesionalisme perawat secara berkelanjutan. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia sebagai wadah yang menghimpun perawat sekaligus mengarahkan perkembangan profesi sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan.

1. Fungsi dan Pengembangan Perawat

Organisasi profesi berperan dalam meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, kegiatan ilmiah, dan pengembangan profesional berkelanjutan. Selain itu, organisasi juga memperkuat identitas dan tanggung jawab profesional perawat terhadap mutu pelayanan.

2. Regulasi, Advokasi, dan Perlindungan Profesi

Organisasi profesi turut memperkuat regulasi praktik keperawatan serta melakukan advokasi dalam kebijakan kesehatan. Dari perspektif lain, organisasi memberikan perlindungan kepada perawat dalam menghadapi permasalahan hukum maupun konflik praktik.

3. Sertifikasi, Registrasi, dan Lisensi (STR/SIP)

Organisasi profesi mendukung proses sertifikasi kompetensi sebagai dasar penerbitan registrasi (STR) dan izin praktik (SIP). Hal ini bertujuan memastikan bahwa perawat yang berpraktik telah memenuhi standar kompetensi dan persyaratan legal.

4. Pengembangan Kebijakan Profesi

Organisasi profesi berperan dalam menyusun standar praktik dan arah pengembangan keperawatan. Kebijakan yang dihasilkan menjadi pedoman dalam menjaga konsistensi dan kualitas pelayanan keperawatan (Co, 2021).

G. Pengembangan Profesional Berkelanjutan (Continuing Professional Development/CPD)

Pengembangan profesional yang berkelanjutan merupakan upaya sistematis untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi perawat seiring perkembangan ilmu dan tuntutan pelayanan. CPD tidak bersifat insidental, melainkan proses belajar sepanjang hayat yang terintegrasi dengan praktik.

1. **Pendidikan berkelanjutan dan pelatihan kompetensi** dilakukan melalui pelatihan, workshop, dan pembelajaran klinis yang relevan dengan kebutuhan layanan.
2. **Sertifikasi keahlian dan spesialisasi** menjadi bentuk pengakuan atas kompetensi lanjutan yang dimiliki perawat.
3. **Peran institusi pendidikan dan organisasi profesi** penting dalam menyediakan program yang terstruktur, bermutu, dan terakreditasi.

H. Strategi peningkatan kompetensi

mencakup pembelajaran mandiri, refleksi praktik, supervisi, serta pemanfaatan hasil penelitian dalam pelayanan (WHO, 2020). Budaya Organisasi dalam Pelayanan Keperawatan

Budaya organisasi mencerminkan nilai, norma, dan pola perilaku yang berkembang dalam lingkungan kerja dan memengaruhi cara perawat memberikan pelayanan.

1. **Konsep budaya organisasi** menggambarkan sistem nilai yang menjadi pedoman dalam bertindak di fasilitas pelayanan kesehatan.

2. **Nilai, norma, dan perilaku kerja perawat** membentuk sikap profesional, disiplin, dan tanggung jawab dalam praktik.
3. **Budaya kerja profesional dan kolaboratif** mendorong komunikasi terbuka, saling menghargai, dan kerja tim yang efektif.
4. **Pengaruh budaya organisasi** terlihat pada kinerja perawat, kepuasan kerja, serta kualitas pelayanan yang dihasilkan (Tsai, 2011)

I. Kepemimpinan dalam Keperawatan

Kepemimpinan keperawatan berperan dalam mengarahkan, mengoordinasikan, dan mengembangkan praktik keperawatan agar berjalan efektif dan profesional.

- **Peran kepala ruangan dan manajer keperawatan** meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan pelayanan.
- **Gaya kepemimpinan** yang adaptif dan partisipatif mampu membangun motivasi serta budaya kerja profesional.
- **Pengambilan keputusan dan supervisi klinis** menjadi bagian penting dalam menjaga mutu dan keselamatan pasien.
- **Pengembangan tim kerja** dilakukan melalui pembinaan, komunikasi efektif, dan peningkatan kolaborasi antar anggota tim (Demishev et al., 2018).

J. Kolaborasi Interprofesional

Kolaborasi interprofesional merupakan pendekatan kerja sama antar tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang komprehensif dan terintegrasi.

1. **Konsep kerja tim** menekankan sinergi antar profesi untuk mencapai tujuan pelayanan yang optimal.
2. **Kolaborasi perawat dengan profesi lain** seperti dokter, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya memperkuat kesinambungan pelayanan.
3. **Komunikasi efektif antar profesi** menjadi kunci dalam mencegah kesalahan dan meningkatkan koordinasi.
4. **Dampak kolaborasi** terlihat pada peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan efisiensi sistem layanan (Reeves et al., 2018).

K. Tata Kelola Profesi (Professional Governance)

Tata kelola profesi merupakan sistem pengaturan praktik keperawatan yang bertujuan menjamin pelayanan yang terstandar, akuntabel, dan berkelanjutan.

1. **Sistem pengelolaan praktik profesional** mencakup pengaturan peran, tanggung jawab, serta kewenangan perawat dalam organisasi.

2. **Standarisasi, audit, dan evaluasi praktik** dilakukan untuk memastikan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. **Akuntabilitas institusi dan individu perawat** menuntut tanggung jawab terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.
4. **Peningkatan mutu berbasis organisasi** dilakukan melalui perbaikan berkelanjutan, monitoring, dan evaluasi kinerja (Schmidt et al., 2011).

L. Penutup

Penguatan profesionalisme dan organisasi keperawatan merupakan upaya strategis dalam menjawab tuntutan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks. Etika, hukum, dan profesionalisme menjadi landasan utama yang saling melengkapi dalam membentuk praktik keperawatan yang bertanggung jawab, aman, dan bermutu. Ketiganya tidak hanya mengarahkan perilaku individu perawat, tetapi juga memperkuat sistem pelayanan melalui dukungan organisasi yang terstruktur dan berkelanjutan.

Peran organisasi profesi, pengembangan kompetensi secara terus-menerus, budaya kerja yang kondusif, kepemimpinan yang efektif, serta kolaborasi interprofesional menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi praktik keperawatan. Selain itu, tata kelola profesi yang baik memastikan bahwa setiap tindakan keperawatan dilaksanakan sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, penguatan profesionalisme tidak dapat dipisahkan dari peran organisasi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung praktik yang etis, legal, dan berkualitas. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan keperawatan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi keperawatan sebagai bagian integral dari sistem Kesehatan (Silver et al., 2021)

Referensi

- Aimee, M. (2018). Ethical Awareness: What It Is and Why It Matters. *Journal of Issues in Nursing*, 1, 1–7.
- Ainy, F. N., Susanto, T., & Susumaningrum, L. A. (2021). The relationship between environmental sanitation of family and stunting among under-five children: A cross-sectional study in the public health center of Jember, Indonesia. *Nursing Practice Today*, 8(3), 173–178. <https://doi.org/10.18502/npt.v8i3.5932>
- Antonelli, G. (2019). HBV Reactivation in Patients Undergoing Hematopoietic Stem Cell Transplantation:
- Cao, H., Song, Y., Wu, Y., Du, Y., He, X., Chen, Y., & Wang, Q. (2023). What is nursing professionalism? a concept analysis. *BMC Nursing*, 1–14. <https://doi.org/10.1186/s12912-022-01161-0>
- Co, I. (2021). Council of Nurses THE ICN CODE OF ETHICS FOR NURSES.
- Demishev, S. V., Gilmanov, M. I., Samarin, A. N., Semeno, A. V., Sluchanko, N. E., Samarin, N. A., Bogach, A. V., Shitsevalova, N. Y., Filipov, V. B., Karasev, M. S., & Glushkov, V. V. (2018). Magnetic resonance probing of ground state in the mixed valence correlated topological insulator. *Scientific Reports*, January, 4–11. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-25464-y>
- Jiang, J., Liu, M., Li, Y., Gao, H., & Tian, L. (2024). Nursing Professionalism: A Scoping Review of Implementation Level, Evaluation Instruments, Influential Factors, and Intervention Strategies. 2024. <https://doi.org/10.1155/2024/7272296>
- Kagabo, R., Thiese, M. S., Eden, E., Thatcher, A. C., Gonzalez, M., & Okuyemi, K. (2020). Truck Drivers' Cigarette Smoking and Preferred Smoking Cessation Methods. 5–11. <https://doi.org/10.1177/1178221820949262>
- Pena, L. D. M., Calcar, S. C. Van, Hansen, J., Edick, M. J., Walsh, C., Leslie, N., Cameron, C., Mohsen, A., Berry, S. A., & Georgianne, L. (2017). enrolled in the IBEM-IS database. 118(4), 272–281. <https://doi.org/10.1016/j.ymgme.2016.05.007.Outcomes>
- Reeves, S., Xyrichis, A., Zwarenstein, M., Reeves, S., & Xyrichis, A. (2018). Teamwork, collaboration, coordination, and networking: Why we need to distinguish between different types of interprofessional practice distinguish between different types of interprofessional practice. *Journal of Interprofessional Care*, 32(1), 1–3. <https://doi.org/10.1080/13561820.2017.1400150>
- Schmidt, W., Genser, B., Luby, S. P., & Chalabi, Z. (2011). Estimating the Effect of Recurrent Infectious Diseases on Nutritional Status: Sampling. 29(4), 317–326.

- Silver, J. A., Bogatchenko, M., Pusztaszeri, M., Forest, V. I., Hier, M. P., Yang, J. W., Tamilia, M., & Payne, R. J. (2021). BRAF V600E mutation is associated with aggressive features in papillary thyroid carcinomas ≤ 1.5 cm. 1 – 8. <https://doi.org/10.1186/s40463-021-00543-9>
- Storm, I. M. L. D., Rasmussen, R. R., & Rasmussen, P. H. (2014). Occurrence of Pre- and Post-Harvest Mycotoxins and Other Secondary Metabolites in Danish Maize Silage. 2256–2269. <https://doi.org/10.3390/toxins6082256>
- Therese Zink, MD, M. (2011). Comparison of Methods for Identifying Ano-Genital Injury After Consensual. 39(1), 113–118. <https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2008.08.024>. Comparison
- Tian, G., Li, D., Yu, H., Dong, Y., Mu, S., & Xue, H. (2018). Laparoscopic splenectomy: posterolateral approach in patients with liver cirrhosis and portal hypertension with platelet count. 454–459.
- Tsai, Y. (2011). Relationship between Organizational Culture, Leadership Behavior and Job Satisfaction.
- WHO. (2020). NURSING.

PROFIL PENULIS



Dr. Ontran Sumantri Riyanto, S.H., M.H. Lahir di Indragiri Hilir 27 Desember 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu S1 Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang tahun 2003. S2 di Program Magister Hukum Kesehatan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan lulus tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan lulus tahun pada tahun 2024. Saat ini Penulis adalah Advokat/Konsultan Hukum, Dosen di STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta dan sebagai Tutor Universitas Terbuka. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ontran27@yahoo.co.id



Yuanita, S.Kep., Ns., M.H. Lahir di Bahungin 19 Juli 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Madani Yoyakarta 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Islam Nusantara dan lulus tahun pada tahun 2025. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2026 sebagai Dosen Tetap di Universitas YPIB Majalengka. Saat ini penulis bekerja di Universitas YPIB Majalengka mengampu mata kuliah Keterampilan Dasar Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail yuanitarha@gmail.com
Motto: "Study law for justice, uphold ethics for truth."



Ns. Fithriyani, S.Kep, M.Kep Lahir di Jambi, 29 Juli 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Andalas tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Andalas dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 sebagai Dosen Tetap di Universitas Baiturrahim. Saat ini penulis bekerja di Universitas Baiturrahim mengampu mata kuliah Manajemen Keperawatan, Keperawatan Dasar. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: fithri.yani25@yahoo.co.id

Motto: "Hidup untuk bermanfaat bagi sesama"



Ns. Nuraini, S.Kep., M.Kep. dilahirkan di Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, pada 19 Juni 1983. Pendidikan keperawatan ditempuh mulai dari Diploma III Keperawatan di Akademi Keperawatan Baiturrahim Jambi dan diselesaikan pada tahun 2004. Komitmennya terhadap pengembangan ilmu terus berlanjut melalui pendidikan Sarjana Keperawatan pada tahun 2007, pendidikan profesi Ners pada tahun 2008, hingga menyelesaikan Magister Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2016.

Perempuan yang akrab disapa Anni ini merupakan putri dari pasangan almarhum H. Muhammad Amin/H. Dg. Passolong dan Hj. Rosmini/Hj.

Dg. Macenning. Kiprahnya di dunia keperawatan dimulai sebagai perawat klinis sejak tahun 2004, sebelum kemudian beralih menekuni bidang pendidikan sebagai dosen pada tahun 2009. Pengalaman akademiknya dimulai di Akademi Keperawatan Prima Jambi, dilanjutkan di Akademi Keperawatan Harum Jakarta pada tahun 2014, dan sejak 2017 mengabdikan diri sebagai dosen keperawatan di Universitas Muhammadiyah Tangerang.

Selain menjalankan peran sebagai tenaga pendidik, ia aktif berpartisipasi dalam organisasi profesi maupun kegiatan sosial, serta konsisten terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat dan aktivitas penelitian. Di luar bidang akademik, ia juga berperan sebagai pendamping PPH serta mengembangkan usaha di bidang kecantikan melalui Anney Skincare Easthatic. Korespondensi dapat dilakukan melalui surat elektronik: anney.passolong@gmail.com.

Motto hidup yang dipegangnya adalah: *"Terus belajar, terus berjuang, dan terus memberi inspirasi, karena ilmu yang bermanfaat merupakan warisan terbaik bagi masa depan."*



Zaenal Abidin, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,M.H. Dosen Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borobudur. Penulis lahir di Lamongan tanggal 07 Maret 1991. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borobudur. Penulis menyelesaikan pendidikan Diploma 3 Keperawatan di Universitas Borneo Tarakan tahun 2013 kemudian S1 keperawatan di Universitas Airlangga tahun 2016 dan Ners 2017. Penulis menyelesaikan pendidikan Magister Keperawatan di Universitas Airlangga tahun 2019 dan Magister Hukum (Konsentrasi Hukum Kesehatan) di Universitas Hang Tuah Surabaya tahun 2019. Dalam

organisasi penulis menjabat sebagai ketua LBHPI (Lembaga Bantuan Hukum Perawat Indonesia) cabang Surabaya tahun 2021-2025. Tahun 2020-2021 penulis menjadi Relawan Penanganan COVID-19 di RSLK KOGABWILHAN II Surabaya. Penulis aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi berupa pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Karya yang telah dihasilkan oleh penulis adalah penelitian yang telah terbit pada jurnal nasional dan internasional, book chapter keselamatan dan kesehatan kerja, bunga rampai sistem perlindungan anak di Indonesia, dan lainnya. Selain sebagai Dosen, penulis juga merupakan perawat di Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya sejak Juni 2025. Selama menjadi perawat, penulis pernah ditugaskan sebagai perawat poli, *Supervisor On Duty* (SOD), IGD dan saat ini di Instalasi Radioterapi. Selain itu penulis juga ditugaskan sebagai tim *Clinical Research Unit* RSUP Surabaya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ners.zaenal@gmail.com

Motto: "Keras dalam berusaha, rendah hati dalam belajar, lembut dalam keberagaman"



Sri Wahyuni, S.Kep., Ns., M.Kep. lahir di Karanganyar, 25 Mei 1975. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2010. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta dan lulus pada tahun 2025.

Riwayat pekerjaan dimulai pada tahun 2025 sebagai Dosen Part Timer di Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta. Saat ini, penulis bekerja di RS PKU Muhammadiyah Surakarta dan di Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta dan mengampu mata kuliah Manajemen Keperawatan. Penulis

dapat dihubungi melalui e-mail: sriwahyuni250522@gmail.com

Motto: "Never stop creating, as every moment is a chance to leave a meaningful legacy."



Ns. Erma Kasumayanti, M.Kep. Penulis lahir di Pulau Jambu pada 28 Februari 1984. Pendidikan keperawatan ditempuh dimulai dari Diploma III Keperawatan di Muhammadiyah Riau lulus tahun 2005, kemudian S1 Keperawatan di Universitas Riau lulus pada tahun 2008, dan pendidikan Magister Keperawatan di Universitas Andalas Padang lulus pada tahun 2013.

Karier profesional dimulai pada tahun 2009 dan saat ini penulis mengabdikan sebagai dosen tetap di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, dengan bidang keilmuan Manajemen Keperawatan.

Dalam kegiatan akademik, penulis mengampu mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan, Falsafah Keperawatan dan Konsep Dasar Keperawatan. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain penulisan buku, publikasi ilmiah, serta partisipasi dalam forum-forum akademik. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: erma.nabihan@gmail.com.

Motto: "Menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya melalui ilmu, kerja, dan pengabdian yang bermakna"

Sinopsis

Buku referensi Etika, Hukum, dan Profesionalisme dalam Praktik Keperawatan Indonesia membahas secara komprehensif landasan moral, aturan hukum, serta nilai-nilai profesional yang menjadi pedoman utama bagi perawat dalam menjalankan praktik keperawatan. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya etika profesi, kepatuhan terhadap regulasi, serta tanggung jawab profesional dalam memberikan pelayanan keperawatan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Materi dalam buku ini mencakup konsep dasar etika keperawatan, prinsip moral dalam pelayanan kesehatan, kode etik perawat, hak dan kewajiban perawat maupun pasien, aspek legal dalam praktik keperawatan, serta tanggung jawab hukum yang melekat pada profesi perawat. Selain itu, buku ini juga membahas isu-isu etik dan hukum yang sering muncul dalam praktik keperawatan di Indonesia, seperti informed consent, kerahasiaan pasien, kelalaian, malpraktik, dokumentasi keperawatan, pengambilan keputusan klinis, serta hubungan profesional antar tenaga kesehatan.

Dengan penyajian yang sistematis dan kontekstual, buku ini dapat digunakan oleh mahasiswa keperawatan, dosen, perawat praktisi, manajer keperawatan, serta tenaga kesehatan lainnya sebagai sumber rujukan dalam memahami dan menerapkan praktik keperawatan yang etis, legal, dan profesional. Kehadiran buku ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan keperawatan di Indonesia, sekaligus memperkuat integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme perawat dalam menghadapi berbagai tantangan pelayanan kesehatan modern.



Buku referensi Etika, Hukum, dan Profesionalisme dalam Praktik Keperawatan Indonesia membahas secara komprehensif landasan moral, aturan hukum, serta nilai-nilai profesional yang menjadi pedoman utama bagi perawat dalam menjalankan praktik keperawatan. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya etika profesi, kepatuhan terhadap regulasi, serta tanggung jawab profesional dalam memberikan pelayanan keperawatan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Materi dalam buku ini mencakup konsep dasar etika keperawatan, prinsip moral dalam pelayanan kesehatan, kode etik perawat, hak dan kewajiban perawat maupun pasien, aspek legal dalam praktik keperawatan, serta tanggung jawab hukum yang melekat pada profesi perawat. Selain itu, buku ini juga membahas isu-isu etik dan hukum yang sering muncul dalam praktik keperawatan di Indonesia, seperti informed consent, kerahasiaan pasien, kelalaian, malpraktik, dokumentasi keperawatan, pengambilan keputusan klinis, serta hubungan profesional antar tenaga kesehatan.

Dengan penyajian yang sistematis dan kontekstual, buku ini dapat digunakan oleh mahasiswa keperawatan, dosen, perawat praktisi, manajer keperawatan, serta tenaga kesehatan lainnya sebagai sumber rujukan dalam memahami dan menerapkan praktik keperawatan yang etis, legal, dan profesional. Kehadiran buku ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan keperawatan di Indonesia, sekaligus memperkuat integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme perawat dalam menghadapi berbagai tantangan pelayanan kesehatan modern.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-04-6 (PDF)



9

786347

756046